

ASUHAN KEBIDANAN KASUS FISILOGIS PADA BAYI, BALITA, DAN ANAK PRA SEKOLAH



Bd. Novita Br Ginting Munthe, SST., M.Keb
Evy Ernawati, S.ST., M.Kes
Ike Putri Setyatama, S.ST., M.Kes
Siti Patimah, SST., M.Keb
Retno Wulan, S.S.T.Keb., M.K.M
Mareza Yolanda Umar, S. ST., M. Kes.
Erma Herdyana, M.Kes
Purwati, S.ST., MPH
Siswati, S.SiT., M.Kes
Ani Triana, SST., Bd., M.Kes
Novita Ayu Indraswati, S.ST., M.Tr.Keb

**ASUHAN KEBIDANAN KASUS FISIOLOGIS
PADA BAYI, BALITA, DAN ANAK PRA SEKOLAH**

Bd. Novita Br Ginting Munthe, SST., M.Keb

Evy Ernawati, S.ST., M.Kes

Ike Putri Setyatama, S.ST., M.Kes

Siti Patimah, SST., M.Keb

Retno Wulan, S.S.T.Keb., M.K.M

Mareza Yolanda Umar, S. ST., M. Kes.

Erma Herdyana, M.Kes

Purwati, S.ST., MPH

Siswati, S.SiT., M.Kes

Ani Triana, SST., Bd., M.Kes

Novita Ayu Indraswati, S.ST., M.Tr.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

**ASUHAN KEBIDANAN KASUS FISIOLOGIS
PADA BAYI, BALITA, DAN ANAK PRA SEKOLAH**

Penulis:

Bd. Novita Br Ginting Munthe, SST., M.Keb
Evy Ernawati, S.ST., M.Kes
Ike Putri Setyatama, S.ST., M.Kes
Siti Patimah, SST., M.Keb
Retno Wulan, S.S.T.Keb., M.K.M
Mareza Yolanda Umar, S. ST., M. Kes.
Erma Herdyana, M.Kes
Purwati, S.ST., MPH
Siswati, S.SiT., M.Kes
Ani Triana, SST., Bd., M.Kes
Novita Ayu Indraswati, S.ST., M.Tr.Keb

Desain Cover:

Ivan Zumarano

Tata Letak:

Siti Hartina Fatimah

ISBN:

978-623-88659-3-2

Cetakan Pertama:

April, 2023

Hak Cipta 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website: www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, yang sudah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketekunan sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan buku asuhan kebidanan (askeb) ini mulai dari penulisan hingga pencetakan: rekan-rekan kami, penerbit dan banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Buku askeb yang berjudul 'Asuhan Kebidanan Kasus Fisiologis Pada Bayi, Balita, Dan Anak Pra Sekolah' ini telah diselesaikan dengan sebaik - baiknya yang dapat digunakan oleh para pembaca sebagai sumber informasi dan menambah pengetahuan asuhan kebidanan kasus fisiologis pada bayi, balita, dan anak pra sekolah.

Masing – masing bab telah disajikan materi askeb yang dapat digunakan sebagai pedoman alternatif bagi pengajar atau dosen dan mahasiswa yang membutuhkan berbagai materi dan juga pengayaan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku askeb ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran ataupun kritik yang membangun untuk perbaikan. Semoga buku askeb ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca.

Hormat kami,
Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 DETEKSI DINI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN NEONATUS, BAYI, BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH	1
BAB 2 GIZI PADA BAYI SERTA BALITA	21
BAB 3 BUKU KIA	33
BAB 4 BABY SPA	47
BAB 5 DOKUMENTASI ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH	61
BAB 6 PEMERIKSAAN FISIK PADA BAYI, BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH	75
BAB 7 PERAWATAN BAYI DI RUMAH.....	89
BAB 8 ASUHAN LANGSUNG PADA BAYI BARU LAHIR	103
BAB 9 KONSEP DASAR PENCEGAHAN INFEKSI PADA NEONATUS.....	123
BAB 10 RAWAT GABUNG (<i>ROOMING IN</i>)	137
BAB 11 ADAPTASI BAYI BARU LAHIR TERHADAP KEHIDUPAN DILUAR UTERUS...	147

BAB 1

**DETEKSI DINI PERTUMBUHAN DAN
PERKEMBANGAN NEONATUS, BAYI, BALITA DAN
ANAK PRA SEKOLAH**

Evy Ernawati, S.ST., M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

**DETEKSI DINI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN NEONATUS,
BAYI, BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH***Evvy Ernawati, S.ST., M.Kes*

A. KONSEP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN

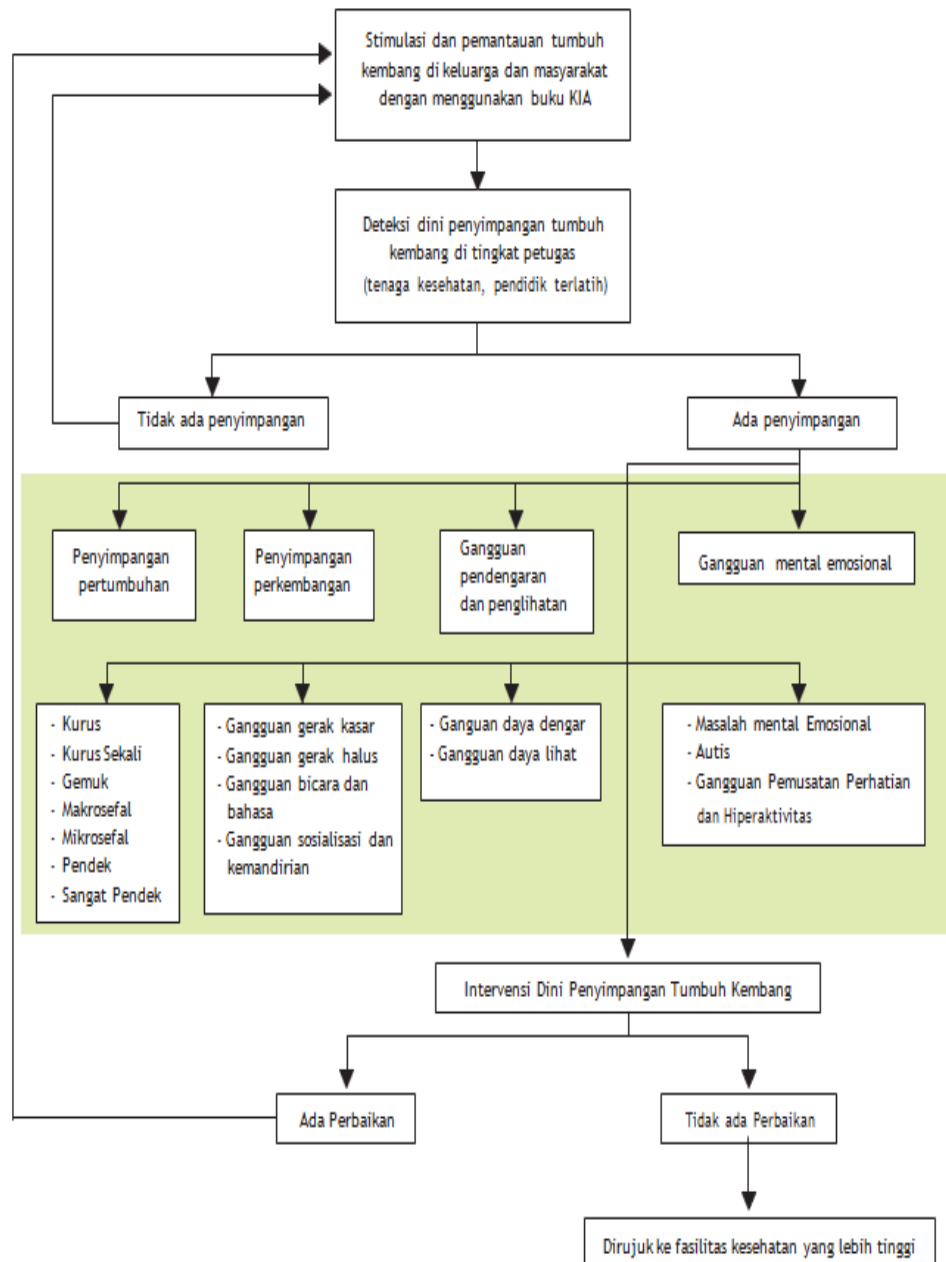
Tumbuh kembang mencakup dua peristiwa yang sifatnya berbeda, tetapi saling berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan (growth) berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat (gram, pound, kilogram), ukuran panjang (cm, meter), umur tulang dan keseimbangan metabolic (retensi kalsium dan nitrogen tubuh). Perkembangan (development) adalah bertambahnya kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks (Nurjanah, 2018). Secara singkat dapat diutarakan perbedaan kedua istilah perkembangan dan pertumbuhan adalah bahwa perkembangan (development), merupakan proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju yang bersifat psikis. Adapun pertumbuhan (growth), merupakan tahapan peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti pentingnya.

Berdasarkan UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa hak-hak anak meliputi hak untuk memperoleh: (1) kelangsungan hidup (survival), (2) perlindungan (protection), (3) tumbuh kembang (development), (4) partisipasi (participation), dan (5) identitas (identity). Setiap anak harus mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dari tenaga medis terlatih secara berkala, untuk mencegah adanya gangguan tumbuh kembang lanjut yang sulit ditangani. Semakin terlambat gangguan dideteksi, semakin sulit penanganannya (IDAI, 2016). Perkembangan setiap anak memiliki keunikan tersendiri dan kecepatan promosi tiap perkembangan anak berbeda. Kisaran waktu ancaman tiap tahap perkembangan umumnya cukup besar, misalnya seorang anak dikatakan normal jika ia dapat berjalan mulai usia 10 hingga 18 bulan, sehingga seringkali terjadi perbedaan perkembangan di antara anak seusianya. Untuk itu, orang tua perlu mengenal tanda bahaya (*red flag*) perkembangan anak (IDAI, 2013).

Rendahnya derajat kesehatan dan gizi anak akan menghambat pertumbuhan fisik dan motorik anak yang juga berlangsung sangat cepat pada tahun-tahun pertama kehidupan anak. Gangguan yang terjadi pada pertumbuhan fisik dan motorik anak, sulit diperbaiki pada periode berikutnya, jika kondisi terus berlanjut, dapat mengakibatkan cacat permanen. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan adalah suatu perubahan fungsional yang bersifat kualitatif, baik dari fungsi-fungsi fisik maupun mental sebagai hasil keterkaitannya dengan pengaruh lingkungan. Perkembangan dapat juga dikatakan sebagai suatu urutan-urutan

perubahan yang bersifat sistematis, dalam arti saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara aspek-aspek fisik dan psikis dan merupakan satu kesatuan yang harmonis (Setyaningrum, 2017).

Kerangka konsep pembinaan tumbuh kembang balita dan anak pra sekolah menurut kemenkes tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 kerangka konsep pertumbuhan dan perkembangan

B. DETEKSI DINI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN

Deteksi dini tumbuh kembang yang dapat dikerjakan oleh tenaga kesehatan berupa (IDAI, 2016):

1. Deteksi dini gangguan pertumbuhan, yaitu menentukan status gizi anak apakah gemuk, normal, kurus dan sangat kurus, pendek, atau sangat pendek, makrosefali atau mikrosefali.
2. Deteksi dini penyimpangan perkembangan, yaitu untuk mengetahui gangguan perkembangan anak (keterlambatan), gangguan daya lihat, gangguan daya dengar.
3. Deteksi dini penyimpangan mental emosional, yaitu untuk mengetahui adanya masalah mental emosional, autisme dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas

C. PETALAKSANAAN DETEKSI DINI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN

1. DETEKSI DINI PERTUMBUHAN

Antropometri berasal dari kata *anthropos* dan *metros*. *Anthropos* artinya tubuh dan *metros* artinya ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran tubuh (Supriasa, 2002). Antropometri adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh manusia (Permenkes, 2020). Menurut NHAES (National Health and Nutrition Examination Survey, antropometri adalah studi tentang pengukuran tubuh manusia dalam dimensi tulang otot dan jaringan adipose atau lemak. Karena tubuh dapat mengasumsikan berbagai postur, antropometri selalu berkaitan dengan posisi anatomi tubuh. Parameter antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi. Indeks antropometri merupakan kombinasi dari parameter-parameter yang ada.

Standar Antropometri Anak digunakan untuk menilai atau menentukan status gizi anak. Penilaian status gizi Anak dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dengan Standar Antropometri Anak. Klasifikasi penilaian status gizi berdasarkan Indeks Antropometri sesuai dengan kategori status gizi pada WHO Child Growth Standards untuk anak usia 0-5 tahun dan The WHO Reference 2007 untuk anak 5-18 tahun (Kemenkes, 2020).

Standar Antropometri Anak didasarkan pada parameter berat badan dan panjang/tinggi badan yang terdiri atas 4 (empat) indeks, meliputi:

- a. Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) Indeks BB/U ini menggambarkan berat badan relatif dibandingkan dengan umur anak. Indeks ini digunakan untuk menilai anak dengan berat badan kurang (*underweight*) atau sangat kurang (*severely underweight*), tetapi tidak dapat digunakan untuk mengklasifikasikan anak gemuk atau sangat gemuk. Penting diketahui bahwa

seorang anak dengan BB/U rendah, kemungkinan mengalami masalah pertumbuhan, sehingga perlu dikonfirmasi dengan indeks BB/PB atau BB/TB atau IMT/U sebelum diintervensi.

- b. Indeks Panjang Badan menurut Umur atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (stunted) atau sangatpendek (severely stunted), yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit. Anak-anak yang tergolong tinggi menurut umurnya juga dapat diidentifikasi. Anak-anak dengan tinggi badan di atas normal (tinggi sekali) biasanya disebabkan oleh gangguan endokrin, namun hal ini jarang terjadi di Indonesia.
- c. Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) Indeks BB/PB atau BB/TB ini menggambarkan apakah berat badan anak sesuai terhadap pertumbuhan panjang/tinggi badannya. Indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak gizi kurang (wasted), gizi buruk (severely wasted) serta anak yang memiliki risiko gizi lebih (possible risk of overweight). Kondisi gizi buruk biasanya disebabkan oleh penyakit dan kekurangan asupan gizi yang baru saja terjadi (akut) maupun yang telah lama terjadi (kronis).
- d. Indeks Masa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Indeks IMT/U digunakan untuk menentukan kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, gizi lebih dan obesitas. Grafik IMT/U dan grafik BB/PB atau BB/TB cenderung menunjukkan hasil yang sama. Namun indeks IMT/U lebih sensitif untuk penapisan anak gizi lebih dan obesitas. Anak dengan ambang batas IMT/U $>+1SD$ berisiko gizi lebih sehingga perlu ditangani lebih lanjut untuk mencegah terjadinya gizi lebih dan obesitas.

Tabel 1.1 Indeks Antropometri

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-score)
Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 - 60 Bulan	Berat Badan sangat kurang (<i>severly underweight</i>)	<-3 SD
	Berat Badan kurang (<i>underweight</i>)	-3 SD sd <-2 SD
	Berat Badan normal	-2 SD sd + 1 SD
	Risiko Berat Badan lebih	> + 1 SD
Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 - 60 bulan	Sangat pendek (<i>severly wasted</i>)	<-3 SD
	Pendek (<i>stunted</i>)	-3 SD sd <-2 SD
	Normal	-2 SD sd + 1 SD
	Tinggi	> + 1 SD
Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 -60 bulan	Gizi Buruk (<i>severly wasted</i>)	< - 3 SD
	Gizi kurang (<i>wasted</i>)	- 3 SD sd < -2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Berisiko gizi lebih (<i>possible risk of overweight</i>)	> +1 SD sd +2 SD
	Gizi lebih (<i>over weight</i>)	> +2 SD sd +3 SD
	Obesitas (<i>obese</i>)	> +3 SD
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia 0 - 60 bulan	Gizi Buruk (<i>severly wasted</i>)	< - 3 SD
	Gizi kurang (<i>wasted</i>)	- 3 SD sd < -2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Berisiko gizi lebih (<i>possible risk of overweight</i>)	> +1 SD sd +2 SD
	Gizi lebih (<i>over weight</i>)	> +2 SD sd +3 SD
	Obesitas (<i>obese</i>)	> +3 SD
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia 5 - 18 tahun	Gizi Buruk (<i>severly thinness</i>)	< -3 SD
	Gizi kurang (<i>thinness</i>)	-3 SD sd < -2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Gizi lebih (<i>over weight</i>)	> +1 SD sd +2 SD
	Obesitas (<i>obese</i>)	> +2 SD

Sumber : (Kemenkes, 2020)

Pengukuran lingkaran kepala adalah metode non-invasif yang cepat untuk menentukan apakah ukuran kepala bayi terlalu besar (megacephaly) atau terlalu kecil (microcephaly). Jika dibandingkan dengan kurva pertumbuhan normatif, pengukuran lingkaran serial sangat penting dalam memantau kesehatan bayi. Pengukuran Lingkaran Kepala Anak (LKA) bertujuan untuk mengetahui lingkaran kepala anak dalam batas normal atau diluar batas normal. Identifikasi awal masalah ukuran kepala oleh dokter keluarga dapat menjadi langkah awal yang penting dalam mengidentifikasi gangguan seperti mikrosefali, yang mengarah ke rujukan ke spesialis anak dan, sesuai kebutuhan, penyediaan layanan intervensi dini yang berpusat pada keluarga (Harris, 2015)

Pelaksanaan pengukuran disesuaikan dengan umur anak dimana:

- a. Anak yang berumur 0 - 11 bulan maka pengukuran dilakukan setiap tiga bulan.
Pada anak yang lebih besar,
 - b. Pada anak umur 12 – 72 bulan maka pengukuran dilakukan setiap enam bulan.
- Cara mengukur lingkaran kepala dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Alat pengukur dilingkarkan pada kepala anak melewati dahi, diatas alis mata, diatas kedua telinga dan bagian belakang kepala yang menonjol, tarik agak kencang.
 - b. Baca angka pada pertemuan dengan angka.
 - c. Menghitung umur bayi/anak dengan cara tanyakan tanggal lahir bayi/anak,
 - d. Hasil pengukuran dicatat pada grafik lingkaran kepala menurut umur dan jenis kelamin anak.
 - e. Buat garis yang menghubungkan antara ukuran yang lalu dengan ukuran sekarang.

Dari hasil pengukuran di catat pada grafik lingkaran kepala sesuai dengan umur dan jenis kelamin dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jika ukuran lingkaran kepala anak berada di dalam “jalur hijau” maka lingkaran kepala anak normal.
- b. Bila ukuran lingkaran kepala anak berada di luar “jalur hijau” maka lingkaran kepala anak tidak normal.
- c. Lingkaran kepala anak tidak normal ada 2 (dua), yaitu makrosefal bila berada diatas “jalur hijau” dan mikrosefal bila berada dibawah “jalur hijau”

2. DETEKSI DINI PERKEMBANGAN

a. PERKEMBANGAN

1) DDST

Denver II dibuat untuk menolong petugas kesehatan menemukan secara dini masalah penyimpangan perkembangan potensial anak berumur kurang dari 6 tahun. Denver II terdiri dari 125 item (DDST memiliki 105) item terbagi 4 area perkembangan umum; personal social, motorik halus adaptif, bahasa dan motorik kasar. Denver Development Screening Test (DDST) bukanlah test IQ maupun alat untuk memprediksi kelainan kemampuan intelektual, kelainan belajar, kelainan berbahasa, atau kemampuan emosi serta tidak dilakukan sebagai bagian dari test diagnostik fisik. Prinsip DDST adalah membandingkan penampilan perkembangan anak dengan anak lainnya yang seusia.

Cara pemeriksaan DDST II menurut sulistyawati (2014) adalah sebagai berikut:

- a) Tetapkan umur kronologis anak, tanyakan tanggal lahir anak yang akan diperiksa. Gunakan patokan 30 hari untuk satu bulan dan 12 bulan untuk satu tahun. Jika dalam perhitungan umur kurang dari 15 hari§ dibulatkan ke bawah, jika sama dengan atau lebih dari 15 hari dibulatkan ke atas
- b) Buat garis lurus dari atas sampai bawah berdasarkan umur kronologis yang memotong garis horisontal tugas perkembangan pada formulir
- c) Uji semua item dengan cara :
 - (1) Pertama pada tiap sektor, uji 3 item yang berada di sebelah kiri garis umur tanpa menyentuh batas usia
 - (2) Kedua uji item yang berpotongan pada garis usia
 - (3) Ketiga item sebelah kanan tanpa menyentuh garis usia sampai anak gagal
- d) Setelah itu dihitung pada masing-masing sektor, berapa yang P dan berapa yang F

Skor Penilaian pada DDST II adalah sebagai berikut:

Skor penilaian tiap uji coba ditulis pada kotak segi empat uji coba dekat dengan tanda garis 50%. Skor yang dipakai pada Denver II :

- a) “P” = Pass : anak melakukan uji coba dengan baik, atau ibu/pengasuh melaporkannya (“tepat”/dapat dipercaya) bahwa anak dapat melakukannya
- b) “F” = Fail/gagal : anak tidak dapat melakukan uji coba dengan baik, atau ibu/pengasuh memberi laporan bahwa anak tidak dapat melakukan dengan baik
- c) “NO”= Opportunity /tidak ada kesempatan : anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan uji coba karena ada hambatan. Skor ini hanya boleh dipakai pada uji coba dengan “R”
- d) “R” = refusal/menolak : anak menolak melakukan uji coba. Penolakan dapat dikurangi dengan mengatakan kepada anak apakah dapat melakukannya (uji coba yang dilaporkan oleh ibu.pengasuh tidak diskor sebagai penolakan)

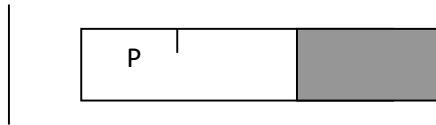
Intepretasi hasil pemeriksaan DDST dapat dibedakan menjadii (Sulistyawati,2014):

a) Intepretasi Penilaian Individual:

- (1) Penilaian lebih (*advanced*). Jika seorang anak “Pass” pada uji coba yang terletak dikanan garis umur, dinyatakan perkembangan anak

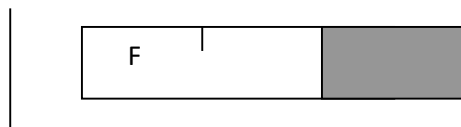
lebih pada uji coba tersebut, karena anak “Pass” pada uji coba dimana kebanyakan anak lainnya belum “Pass”

Age line

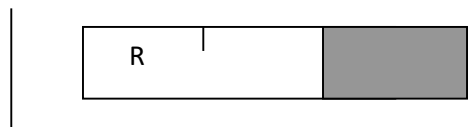


- (2) Penilaian “ Normal “, jika seorang anak “gagal” atau “menolak” melakukan uji coba disebelah kanan garis umur, perkembangan anak dinyatakan normal. Anak tidak diharapkan “Pass” sampai umurnya lebih tua. Seperti gambar 5, seorang anak dimana garis umur terletak diantara persentil 25 dan 75, sehingga perkembangan anak pada uji coba tersebut dinyatakan normal.

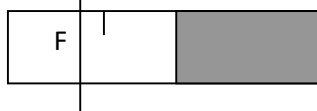
Age line



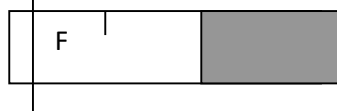
Age line



Age line



Age line



Age line



- (3) Penilaian ‘caution/peringatan’, jika seorang anak gagal/ menolak uji coba dimana garis umur terletak pada atau antara persentil 75 dan 90 skornya = caution (tulis C disebelah kanan kotak segi panjang)

Age line



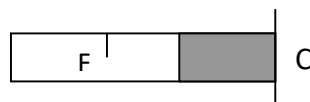
Age line



Age line

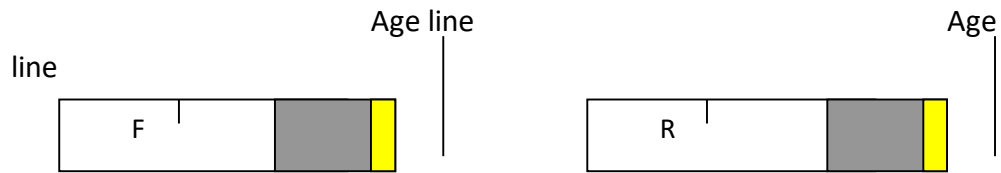


C C

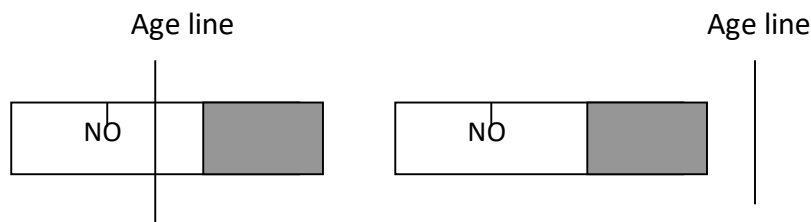


C

- (4) Penilaian ‘delayed’ (keterlambatan). Jika seorang anak “gagal” atau menolak melakukan uji coba yang terletak lengkap pada sebelah kiri garis umur, karena anak gagal atau menolak uji coba dimana 90% anak pada sample baku dapat “Pass” pada umur lebih dini. Keterlambatan ditandai dengan memberi warna pada akhir tepi kotak segi panjang.



- (5) Penilaian Opportunity/tidak ada kesempatan. uji coba yang dilaporkan orang tua bahwa anak tidak ada kesempatan untuk melakukan atau mencoba diskor sebagai “NO” untuk no opportunity.



b) Interpretasi tes/uji coba :

- (1) Normal = tidak ada “keterlambatan/delayed” dan ada paling banyak satu “caution”. Lakukan ulangan pemeriksaan pada kontrol kesehatan berikutnya
- (2) Suspek= Jika didapatkan ≥ 2 caution dan atau ≥ 1 ‘delayed’. Lakukan uji ulang dalam 1-2 minggu untuk menghilangkan factor sesaat seperti rasa takut, sakit dan kelelahan
- (3) Tidak dapat diuji = Jika ada skor menolak pada ≥ 1 total di sebelah kiri garis umur atau menolak pada ≥ 1 uji coba yang ditembus garis umur pada daerah 75 – 90%. Uji ulang dalam 1-2 minggu.
- (4) Seferal Consideration = Jika setelah uji ulang, hasil uji coba “suspek” atau “tidak dapat diuji”, maka dipikirkan untuk dikirim keahlianya, tetapi harus ditentukan keadaan klinis atau factor lainnya.

2) KPSP (SKRINING PEMERIKSAAN PERKEMBANGAN ANAK MENGGUNAKAN KUESIONER PRA SKRINING PERKEMBANGAN)

Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) merupakan salah satu instrumen penilaian perkembangan pada anak yang direkomendasikan oleh Departemen Kesehatan RI tahun 2006, selain Denver II. Tujuan dari penggunaan KPSP sebagai instrumen skrining adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak sesuai dengan umurnya. Selain itu, instrumen ini juga digunakan sebagai alat untuk mendeteksi penyimpangan perkembangan anak agar segera dapat dilakukan intervensi. Skrining dilakukan secara rutin pada anak umur 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42,

48, 54, 60, 66, dan 72 bulan. Apabila orang tua datang dengan keluhan anaknya mempunyai masalah tumbuh kembang, sedangkan umur anak bukan umur skrining, maka pemeriksaan menggunakan KPSP untuk umur yang terdekat pada umur yang lebih muda. Skrining menggunakan KPSP dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, guru TK, dan petugas PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang telah terlatih (Sulistyowati, 2014)

Alat/instrumen yang digunakan pada skrining KPSP adalah sebagai berikut :

- a) Formulir KPSP menurut umur. Formulir ini berisi 9 – 10 pertanyaan tentang kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak. Sasaran KPSP adalah anak umur 0 – 72 bulan.
- b) Alat bantu pemeriksaan berupa pensil, kertas, bola sebesar bola tenis, kerincingan, kubus berukuran sisi 2,5 cm sebanyak enam buah, kismis, kacang tanah, dan potongan biscuit kecil ukuran 0,5 – 1 cm.

Cara penggunaan Kuesioner skrining menurut sulistyawati (2014) adalah sebagai berikut:

- a) Pada waktu pemeriksaan anak harus dibawa
Tentukan umur anak dengan menanyakan tanggal, bulan, dan tahun anak lahir. Bila umur anak (dalam hitungan bulan) lebihnya 16 hari, maka dibulatkan menjadi 1 bulan. Misalnya umur anak 6 bulan 16 hari, maka dibulatkan menjadi 7 bulan. Jika umur anak 6 bulan 15 hari, maka umur anak tetap dihitung 6 bulan.
- b) Setelah menentukan umur anak, pilihlah KPSP yang sesuai dengan umur anak
- c) KPSP terdiri atas dua macam pertanyaan sebagai berikut:
 - (1) Pertanyaan yang dijawab oleh ibu/pengasuh anak. Contoh, “Dapatkah bayi makan kue sendiri?”
 - (2) Perintah kepada ibu/pengasuh anak atau petugas untuk melaksanakan tugas yang tertulis pada KPSP. Misalnya, “Pada posisi anak telentang, tariklah bayi pada pergelangan tangannya secara perlahan – lahan ke arah posisi duduk!”
- d) Jelaskan kepada orang tua agar tidak takut atau ragu – ragu untuk menjawab. Oleh karena itu, pastikan orang tua/pengasuh anak mengerti dengan apa yang ditanyakan kepadanya.
- e) Ajukan pertanyaan secara berurutan dan satu per satu. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban, yaitu ya atau tidak. Catat jawaban tersebut pada formulir.

- f) Ajukan pertanyaan yang berikutnya setelah orang tua/pengasuh anak menjawab pertanyaan sebelumnya.
- g) Terakhir, teliti kembali apakah semua pertanyaan yang ada dalam KPSP telah terjawab.

Hasil Interpretasi KPSP dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Hitunglah berapa jumlah jawaban “ya”.
- b) Jumlah jawaban “ya” = 9 atau 10, berarti perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya (S).
- c) Jumlah jawaban “ya” = 7 atau 8, berarti perkembangan anak meragukan (M).
- d) Jumlah jawaban “ya” = 6 atau kurang, kemungkinan ada penyimpangan (P).
- e) Untuk jawaban “tidak”, perlu dirinci jumlah jawaban “tidak” menurut jenis keterlambatan (gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian).

Intervensi pelaksanaan skrining perkembangan menggunakan KPSP adalah sebagai berikut (kemenkes RI,2016):

- a) Bila perkembangan anak sesuai perkembangan (S), lakukan tindakan sebagai berikut:
 - (1) Beri pujian kepada orang tua/pengasuh anak karena telah mengasuh anak dengan baik.
 - (2) Teruskan pola asuh anak sesuai dengan tahap perkembangan anak.
 - (3) Beri stimulasi perkembangan anak setiap saat, sesering mungkin, sesuai dengan umur dan kesiapan anak.
 - (4) Ikutkan anak pada kegiatan penimbangan dan pelayanan kesehatan di posyandu secara teratur sebulan sekali dan setiap ada kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Jika anak sudah memasuki usia prasekolah, ikutkan dalam kegiatan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelompok bermain, dan Taman Kanak – Kanak.
 - (5) Lakukan pemeriksaan secara rutin menggunakan KPSP setiap tiga bulan pada anak umur kurang dari 24 bulan dan setiap enam bulan pada anak umur 24 sampai 72 bulan.
- b) Bila perkembangan anak meragukan (M), lakukan tindakan sebagai berikut :
 - (1) Beri petunjuk pada ibu/pengasuh anak agar melakukan stimulasi perkembangan pada anak lebih sering lagi, setiap saat, dan sesering mungkin.

- (2) Ajarkan ibu cara melakukan intervensi stimulasi perkembangan anak untuk mengatasi penyimpangan/mengejar ketertinggalannya.
- (3) Lakukan pemeriksaan kesehatan untuk mencari kemungkinan adanya penyakit yang menyebabkan penyimpangan perkembangannya.
- (4) Lakukan penilaian ulang KPSP dua minggu kemudian dengan menggunakan daftar KPSP yang sesuai dengan umur anak.
- (5) Jika hasil jawaban “ya” tetap 7 atau 8, maka kemungkinan memang ada penyimpangan perkembangan (P).
Bila dalam perkembangan anak terjadi penyimpangan (P), lakukan rujukan ke rumah sakit dengan menuliskan jenis dan jumlah penyimpangan perkembangan (gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, dan sosialisasi dan kemandirian).

KPSP PADA ANAK UMUR 24 BULAN

Alat dan bahan yang dibutuhkan:

- Kubus
- Bola tenis

		YA	TIDAK
Anak dipangku ibunya / Pengasuh ditepi meja periksa			
1	Apakah anak dapat meletakkan satu kubus di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu?	Gerak Halus	
2	Tanpa bimbingan, petunjuk, atau bantuan anda, dapatkah anak menunjuk dengan benar paling sedikit satu bagian badannya (rambut, mata, hidung, mulut, atau bagian badan yang lain)?	Bicara dan Bahasa	
Tanya ibu			
3	Apakah anak suka meniru bila ibu sedang melakukan pekerjaan rumah tangga (menyapu, mencuci, dll)?	Sosialisasi dan Kemandirian	
4	Apakah anak dapat mengucapkan paling sedikit 3 kata yang mempunyai arti selain "papa" dan "mama"?	Bicara dan Bahasa	
5	Apakah anak berjalan mundur 5 langkah atau lebih tanpa kehilangan keseimbangan? (Anda mungkin dapat melihatnya ketika anak menarik mainannya)	Gerak Kasar	
6	Dapatkah anak melepas pakaiannya seperti : Baju, Rok, atau celananya ?	Gerak Halus	
7	Dapatkah anak berjalan naik tangga sendiri? Jawab YA jika ia naik tangga dengan posisi tegak atau berpegangan pada dinding atau pegangan tangga. Jawab TIDAK jika ia naik tangga dengan merangkak atau anda tidak mebolehkan anak naik tangga atau anak harus berpegangan pada seseorang.	Gerak Kasar	
8	Dapatkah anak makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah?	Sosialisasi dan Kemandirian	
9	Dapatkah anak membantu memungut mainannya sendiri atau membantu mengangkat piring jika diminta?	Bicara dan Bahasa	
Berdiri anak			
10	Letakkan bola tenis di depan kakinya. Apakah dia dapat menendangnya, tanpa berpegangan pada apapun?	Gerak Kasar	
TOTAL			

Lihat Algoritme untuk Interpretasi dan Tindakan

Perinci untuk Aspek Perkembangan dengan jawaban “Tidak”

Gambar 1.2 Kuesioner KPSP untuk usia 24 bulan (kemenkes RI,2016)

b. TES DAYA LIHAT

Tujuan pelaksanaan tes daya lihat adalah untuk mendeteksi secara dini adanya kelainan daya lihat sehingga segera dapat dilakukan tindakan lanjutan sehingga kesempatan untuk memperoleh ketajaman daya lihat menjadi lebih besar. Pelaksanaan tes daya lihat dilakukan setiap 6 bulan pada anak usia prasekolah umur 36 sampai 72 bulan. Tes ini dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan.

a. Alat/sarana yang diperlukan adalah:

- 1) Ruang yang bersih, tenang dengan penyaluran yang baik
- 2) Dua buah kursi, 1 untuk anak dan 1 untuk pemeriksa
- 3) Poster "E" untuk digantung dan kartu "E" untuk dipegang anak
- 4) Alat Penunjuk

Cara melakukan daya lihat:

- 1) Pilih suatu ruangan yang bersih dan tenang, dengan penyaluran yang baik
- 2) Gantungkan poster "E" setinggi mata anak pada posisi duduk
- 3) Letakkan sebuah kursi sejauh 3 meter dari poster "E" menghadap ke poster "E"
- 4) Letakkan sebuah kursi lainnya di samping poster "E" untuk pemeriksa.
- 5) Pemeriksa memberikan kartu "E" pada anak.. Latih anak dalam mengarahkan kartu "E" menghadap atas, bawah, kiri dan kanan; sesuai yang ditunjuk pada poster "E" oleh pemeriksa. Beri pujian setiap kali anak mau melakukannya. Lakukan hal ini sampai anak dapat mengarahkan kartu "E" dengan benar.
- 6) Selanjutnya, anak diminta menutup sebelah matanya dengan buku/kertas.
- 7) Dengan alat penunjuk, tunjuk huruf "E" pada poster, satu persatu, mulai baris pertama sampai baris ke empat atau baris "E" terkecil yang masih dapat di lihat.
- 8) Puji anak setiap kali dapat mencocokkan posisi kartu "E" yang dipegangnya dengan huruf "E" pada poster.
- 9) Ulangi pemeriksaan tersebut pada mata satunya dengan cara yang sama.
- 10) Tulis baris "E" terkecil yang masih dapat di lihat, pada kertas yang telah di sediakan : Mata kanan : Mata kiri :

c. TES DAYA DENGAR

Tes daya dengar memiliki tujuan untuk menemukan adanya gangguan pendengaran sejak dini sehingga gangguan dapat segera ditindaklanjuti untuk

meningkatkan kemampuan daya dengar dan bicara anak. Pelaksanaan TDD (tes daya dengar) adalah setiap 3 bulan pada bayi umur kurang dari 12 bulan dan setiap 6 bulan pada anak umur 12 bulan keatas. Tes ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, guru TK, tenaga PAUD dan petugas terlatih lainnya. Tenaga kesehatan mempunyai kewajiban memvalidasi hasil pemeriksaan tenaga lainnya.

- a. Alat/sarana yang diperlukan adalah: Instrumen TDD menurut umur anak.
- b. Cara melakukan TDD :
 - 1) Hitung umur anak dalam bulan dengan cara menanyakan tanggal, bulan dan tahun anak lahir
 - 2) Memilih daftar pertanyaan TDD yang sesuai dengan umur anak.
 - a. Umur kurang dari 24 bulan

Pelaksanaan pemeriksaan pada anak umur kurang dari 24 bulan adalah dengan cara menanyakan semua pertanyaan kepada orang tua/pengasuh anak dengan pelan, jelas dan nyaring. Hasil Jawaban YA jika menurut orang tua/pengasuh, anak dapat melakukannya dalam satu bulan terakhir. Sedangkan jawaban TIDAK jika menurut orang tua/pengasuh anak tidak pernah, tidak tahu atau tak dapat melakukannya dalam satu bulan terakhir.
 - b. Umur anak lebih dari 24 bulan

Pada anak umur 24 bulan atau lebih dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berupa perintah melalui orangtua/pengasuh untuk dikerjakan oleh anak. Kemudian amati kemampuan anak dalam melakukan perintah orangtua/pengasuh. Hasil jawaban YA jika anak dapat melakukan perintah orangtua/pengasuh. Sedangkan Jawaban TIDAK jika anak tidak dapat atau tidak mau melakukan perintah orangtua/pengasuh.
 - 3) Interpretasi:

Bila ada satu atau lebih jawaban TIDAK, kemungkinan anak mengalami gangguan pendengaran kemudian catat dalam Buku KIA atau register SDIDTK, atau status/catatan medik anak.
 - 4) Intervensi:
 - a) Tindak lanjut sesuai dengan buku pedoman yang ada.
 - b) Rujuk ke RS bila tidak dapat ditanggulangi

3. DETEKSI DINI PENYIMPANGAN MENTAL EMOSIONAL

Deteksi dini penyimpangan perilaku emosional adalah kegiatan/pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya masalah perilaku emosional, autisme dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak, agar dapat segera dilakukan tindakan intervensi. Bila penyimpangan perilaku emosional terlambat diketahui, maka Intervensi akan lebih sulit dan hal ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak.

Menurut kemenkes RI tahun 2016 bahwa deteksi dini penyimpangan perilaku emosional meliputi deteksi yang dilakukan menggunakan Kuesioner Masalah Perilaku Emosional (KMPE) bagi anak umur 36 bulan sampai 72 bulan. Ceklis autis anak prasekolah (Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) bagi anak umur 18 bulan sampai 36 bulan. Formulir deteksi dini Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH) menggunakan Abreviated Conner Rating Scale bagi anak umur 36 bulan ke atas.

4. DETEKSI DINI MASALAH PERILAKU EMOSIONAL

Tujuannya adalah mendeteksi secara dini adanya penyimpangan/masalah perilaku emosional pada anak pra sekolah. Pelaksanaan deteksi dini masalah perilaku emosional sesuai dengan jadwal pelayanan SDIDTK yaitu rutin setiap 6 bulan pada anak umur 36 bulan sampai 72 bulan.

a. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan adalah Kuesioner Masalah Perilaku Emosional (KMPE) yang terdiri dari 14 pertanyaan untuk mengenali problem perilaku emosional anak umur 36 bulan sampai 72 bulan.

b. Cara melakukan :

- 1) Tanyakan setiap pertanyaan dengan lambat, jelas dan nyaring, satu persatu perilaku yang tertulis pada
- 2) KMPE kepada orang tua/pengasuh anak.
- 3) Catat jawaban YA, kemudian hitung jumlah jawaban YA.

c. Interpretasi :

Bila ada jawaban YA, maka kemungkinan anak mengalami masalah perilaku emosional.

d. Intervensi :

Bila jawaban YA hanya 1 (satu) maka lakukan konseling kepada orang tua menggunakan Buku Pedoman Pola asuh Yang Mendukung Perkembangan Anak dan lakukan evaluasi setelah 3 bulan, bila tidak ada perubahan rujuk ke Rumah Sakit yang memberi pelayanan rujukan tumbuh kembang atau memiliki fasilitas pelayanan kesehatan jiwa.

Bila jawaban YA ditemukan 2 (dua) atau lebih maka rujuk ke Rumah Sakit yang

memberi pelayanan rujukan tumbuh kembang atau memiliki fasilitas pelayanan kesehatan jiwa. Rujukan harus disertai informasi mengenai jumlah dan masalah mental emosional yang ditemukan.

5. DETEKSI DINI AUTIS PADA ANAK PRASEKOLAH

Gangguan spektrum autisme adalah konstruksi yang digunakan untuk menggambarkan individu dengan kombinasi khusus dari gangguan dalam komunikasi sosial dan perilaku berulang, minat yang sangat terbatas dan/atau perilaku sensorik yang dimulai sejak awal kehidupan (Lord et al., 2020). Menurut kemenkes RI (2016) tujuan deteksi dini adalah mendeteksi secara dini adanya autisme pada anak umur 18 bulan sampai 36 bulan.

a. Indikasi

Dilaksanakan atas indikasi atau bila ada keluhan dari ibu/pengasuh atau ada kecurigaan tenaga kesehatan, kader kesehatan, petugas PAUD, pengelola TPA dan guru TK. Keluhan tersebut dapat berupa salah satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- 1) Keterlambatan berbicara.
- 2) Gangguan komunikasi/ interaksi sosial.
- 3) Perilaku yang berulang-ulang.

b. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan adalah M-CHAT (Modified-Checklist for Autism in Toddlers) dengan jumlah 23 pertanyaan yang dijawab oleh orang tua/pengasuh anak. Pertanyaan yang diajukan secara berurutan, satu persatu. Jelaskan kepada orangtua untuk tidak ragu-ragu atau takut menjawab.

c. Cara menggunakan M-CHAT.

- 1) Ajukan pertanyaan dengan lambat, jelas dan nyaring, satu persatu perilaku yang tertulis pada M-CHAT kepada orang tua atau pengasuh anak.
- 2) Lakukan pengamatan kemampuan anak sesuai dengan tugas pada Modified-Checklist for Autism in
- 3) Toddlers (M-CHAT)
- 4) Catat jawaban orang tua/pengasuh anak dan kesimpulan hasil pengamatan kemampuan anak, YA atau
- 5) TIDAK. Teliti kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab.

d. Interpretasi:

- 1) Enam pertanyaan No. 2, 7, 9, 13, 14, dan 15 adalah pertanyaan penting (critical item) jika dijawab tidak berarti pasien mempunyai risiko tinggi autisme.
- 2) Jawaban tidak pada dua atau lebih critical item atau tiga pertanyaan lain yang dijawab tidak sesuai (misalnya seharusnya dijawab ya, orang tua menjawab

- tidak) maka anak tersebut mempunyai risiko autisme
- 3) Jika perilaku itu jarang dikerjakan (misal anda melihat satu atau 2 kali) , mohon dijawab anak tersebut tidak melakukannya.
- e. Intervensi:
- Bila anak memiliki risiko tinggi autisme atau risiko autisme, Rujuk ke Rumah Sakit yang memberi layanan rujukan tumbuh kembang anak.

6. DETEKSI DINI GANGGUAN PEMUSATAN PERHATIAN DAN HIPERAKTIFITAS (GPPH) PADA ANAK

Menurut ningrum (2022) bahwa gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (gpph) adalah suatu kondisi gangguan mental yang biasanya muncul pada masa kanak-kanak dan dapat menetap atau menetap hingga dewasa. Tujuan deteksi dini adalah mengetahui secara dini anak adanya Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH) pada anak umur 36 bulan ke atas. Pelaksanaan deteksi dilakukan atas indikasi bila ada keluhan dari orang tua/pengasuh anak atau ada kecurigaan tenaga kesehatan, kader kesehatan, BKB, petugas PAUD, pengelola TPA dan guru TK. Keluhan tersebut dapat berupa salah satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- 1) Anak tidak bisa duduk tenang
- 2) Anak selalu bergerak tanpa tujuan dan tidak mengenal lelah
- 3) Perubahan suasana hati yang mendadak/impulsive

Menurut kementerian kesehatan RI (2016) bahwa alat yang digunakan adalah formulir deteksi dini Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas/GPPH (*Abbreviated Conners Rating Scale*), Formulir ini terdiri 10 pertanyaan yang ditanyakan kepada orang tua/pengasuh anak/guru TK dan pertanyaan yang perlu pengamatan pemeriksa.

a. Cara menggunakan formulir deteksi dini GPPH:

- 1) Ajukan pertanyaan dengan lambat, jelas dan nyaring, satu persatu perilaku yang tertulis pada formulir deteksi dini GPPH. Jelaskan kepada orangtua/pengasuh anak untuk tidak ragu-ragu atau takut menjawab.
- 2) Lakukan pengamatan kemampuan anak sesuai dengan pertanyaan pada formulir deteksi dini GPPH.
- 3) Keadaan yang ditanyakan/diamati ada pada anak dimanapun anak berada, misal ketika di rumah, sekolah, pasar, toko, dll); setiap saat dan ketika anak dengan siapa saja.
- 4) Catat jawaban dan hasil pengamatan perilaku anak selama dilakukan pemeriksaan.
- 5) Teliti kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab.

b. Interpretasi:

Beri nilai pada masing-masing jawaban sesuai dengan "bobot nilai" berikut ini, dan jumlahkan nilai masing-masing jawaban menjadi nilai total

Nilai 0: jika keadaan tersebut tidak ditemukan pada anak.

Nilai 1: jika keadaan tersebut kadang-kadang ditemukan pada anak.

Nilai 2: jika keadaan tersebut sering ditemukan pada anak.

Nilai 3: jika keadaan tersebut selalu ada pada anak.

Bila nilai total 13 atau lebih anak kemungkinan dengan GPPH.

c. Intervensi:

- 1) Anak dengan kemungkinan GPPH perlu dirujuk ke Rumah Sakit yang member pelayanan rujukan tumbuh kembang atau memiliki fasilitas kesehatan jiwa untuk konsultasi dan lebih lanjut.
- 2) Bila nilai total kurang dari 13 tetapi anda ragu-ragu, jadwalkan pemeriksaan ulang 1 bulan kemudian. Ajukan pertanyaan kepada orang-orang terdekat dengan anak (orang tua, pengasuh, nenek, guru, dsb).

DAFTAR PUSTAKA

- Harris, S. R. (2015). Measuring head circumference: Update on infant microcephaly. *Canadian Family Physician Medecin De Famille Canadien*, 61(8), 680–684.
- Indonesia. 2014. Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
- Kemenkes RI (2016) Simulasi. Pedoman Pelaksanaan Deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Kemenkes RI (2020) *Standar Antropometri Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Ningrum (2022) *Literature Review: Hubungan Terapi Bermain dengan Daya Konsentrasi pada Anak Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH) | Journal of Issues in Midwifery*. (n.d.). Retrieved December 25, 2022, from <https://joim.ub.ac.id/index.php/joim/article/view/440>
- Lord, C., Brugha, T. S., Charman, T., Cusack, J., Dumas, G., Frazier, T., Jones, E. J. H., Jones, R. M., Pickles, A., State, M. W., Taylor, J. L., & Veenstra-VanderWeele, J. (2020). Autism spectrum disorder. *Nature Reviews Disease Primers*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.1038/s41572-019-0138-4>
- Sulistyawati, Ari (2014). Deteksi Tumbuh kembang anak. Jakarta: salemba

BAB 2

GIZI PADA BAYI SERTA BALITA

Ike Putri Setyatama, S.ST., M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. PENDAHULUAN

Balita adalah salah satu kelompok usia yang rentan serta berisiko tinggi terhadap suatu penyakit. Kekurangan ataupun kelebihan asupan zat gizi dan asertaya infeksi pada balita akan mempunyai dampak pada status gizi serta status kesehatan balita. Masalah gizi yang sering dialami balita adalah Kurang Energi Protein (KEP) serta Obesitas (Kegemukan). Hal lain yang dapat mempengaruhi status gizi balita adalah pemberian serta perilaku makan yang salah pada balita.[1] Dalam hal ini peran orang tua khususnya ibu sangat penting dalam penentuan status gizi balita karena hal tersebut yang berhubungan langsung dalam persiapan serta pemberian makanan pada balita. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan balita di masyarakat adalah melalui usaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan posyandu balita dan pemberian asupan gizi yang sesuai pada balita. Kegiatan di Posyandu Balita dititikberatkan pada upaya pencapaian pertumbuhan serta perkembangan balita secara optimal. Beberapa kegiatan yang dilakukan di posyandu adalah penimbangan berat baserta, pengukuran tinggi baserta, konseling gizi, pemeriksaan kesehatan, imunisasi serta pemberian makanan tambahan (PMT). Menu PMT yang diberikan pada balita oleh posyandu berasal melalui menu yang direferensikan melalui Puskesmas setempat. Penyusunan buku ini bertujuan untuk menambah referensi gizi makanan untuk PMT bagi masyarakat serta para kader di posyandu balita dan diharapkan dapat disosialisasikan pula pada orang tua balita.[2]

Gizi serta Balita Gizi (nutrients) adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun serta memelihara jaringan, dan mengatur proses-proses kehidupan. Disamping untuk kesehatan, gizi dikaitkan dengan potensi ekonomi seseorang, karena gizi berhubungan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, serta produktivitas kerja. Makanan yang bergizi dibutuhkan balita untuk pertumbuhan perkembangan. [3] Jika asupan gizi cukup maka balita akan mencapai pertumbuhan serta perkembangan yang baik serta optimal. Perlu diketahui bahwa pada usia balita risiko untuk terjadinya gizi kurang sangatlah tinggi. Hal ini dikarenakan pada usia balita terjadi pertumbuhan serta perkembangan yang cepat sehingga balita membutuhkan zat gizi yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Pada masa balita biasanya terjadi penurunan nafsu makan serta rentan terkena infeksi. Asupan makanan yang kurang dan terjadinya infeksi pada balita menjadi penyebab langsung terjadinya status gizi

kurang. Oleh karena itu makanan yang kita sajikan untuk balita hendaklah memenuhi zat-zat gizi yang balita perlukan sehingga terjadinya gizi kurang dapat dicegah sedini mungkin.

B. KEBUTUHAN ZAT GIZI PADA BALITA

Zat Gizi Yang Diperlukan Balita Zat-zat gizi yang diperlukan balita untuk pertumbuhan serta perkembangan meliputi:

1. Energi
 - a. Energi pada tubuh didapatkan melalui karbohidrat, lemak serta beberapa berasal melalui protein.
 - b. Energi digunakan sebagai sumber tenaga untuk aktifitas apalagi anak usia balita bergerak cukup aktif sehingga dibutuhkan asupan energi yang banyak pula. Selain itu energi bermanfaat untuk pertumbuhan serta perkembangan balita.
 - c. Sumber energi berasal melalui makanan sumber lemak serta minyak, kacang-kacangan, biji-bijian, umbi-umbian, padi-padian, serta gula murni.
2. Karbohidrat
 - a. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi balita. Hampir separuh melalui energi yang dibutuhkan seorang balita sebaiknya berasal melalui sumber makanan kaya karbohidrat.
 - b. Balita usia > 1 tahun dianjurkan untuk mengonsumsi karbohidrat sebanyak 50-60% melalui total energi.

Karbohidrat dibutuhkan untuk perkembangan otak, pemberi rasa manis pada makanan, pengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses.
 - d. Sumber karbohidrat dapat berasal melalui padi-padian atau sereal (beras, gandum), umbi-umbian (kentang, ubi, singkong), kacang-kacangan serta gula.
3. Lemak
 - a. Tubuh balita membutuhkan lemak terutama lemak esensial terutama omega 3 serta omega 6.
 - b. Lemak dalam makanan bermanfaat sebagai sumber energi, melarutkan vitamin larut lemak (vitamin A, D, E serta K), memberi rasa kenyang serta kelezatan, memelihara suhu tubuh serta melindungi organ tubuh. Selain itu lemak berperan penting dalam proses pertumbuhan perkembangan sel – sel saraf otak untuk kecerdasan balita.
 - c. Balita membutuhkan lemak sekitar 35% melalui total energi.
 - d. Sumber lemak dapat berasal melalui susu, minyak, daging, telur, ikan, serta lain sebagainya.

4. Protein

- a. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan serta perbaikan jaringan tubuh, membuat enzim pencernaan serta zat kekebalan (antibodi) yang bermanfaat melindungi tubuh balita sehingga balita terlindung melalui penyakit infeksi.
- b. Protein bermanfaat untuk membentuk sel – sel baru untuk menunjang proses pertumbuhan seluruh organ tubuh dan perkembangan otak.
- c. Kebutuhan protein secara proporsional lebih tinggi untuk balita melaluipada orang dewasa.
- d. Sumber protein dapat berasal melalui ikan, susu, daging, telur, serta kacang-kacangan.

5. Serat

- a. Serat adalah bagian melalui karbohidrat serta protein nabati yang tidak dipecah dalam usus kecil serta penting untuk mencegah sembelit dan gangguan usus lainnya.
- b. Sumber serat dapat didapatkan melalui sayur-sayuran serta buah-buahan.

6. Vitamin serta Mineral

- a. Vitamin adalah zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil untuk banyak proses penting yang dilakukan dalam tubuh. Sesertagkan mineral adalah zat anorganik yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi
- b. Vitamin serta mineral mempunyai fungsi masingmasing bagi tubuh.
- c. Vitamin A bermanfaat bagi fungsi penglihatan balita, vitamin B2 untuk pertumbuhan serta kesehatan kulit, vitamin C sebagai antioksiserta serta mempercepat penyembuhan luka, vitamin D sangat baik untuk fungsi tulang balita.
- d. Kalsium, besi, serta zinc adalah mineral yang berhubungan dengan fungsi pertumbuhan. Iodium mencegah balita mengalami kekerdilan serta IQ yang rendah.
- e. Asam folat sangat penting pada masa pertumbuhan anak, memproduksi sel darah merah serta sel darah putih dalam sumsum tulang, berperan dalam pematangan sel darah merah serta mencegah anemia.
- f. Sumber vitamin serta mineral banyak ditemukan pada daging, ikan, telur, buah serta sayuran dan susu.[4]

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian zat gizi pada balita meliputi:[5]

1. Sesuai kombinasi zat gizi

Makanan yang dikonsumsi balita sebaiknya mengandung zat-zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan balita, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serta cairan.

2. Sesuai jumlah

Jumlah makanan yang diberikan pada balita harus mengandung zat-zat gizi yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) balita. Sesuai dengan perkembangan anak Pemberian makanan pada balita disesuaikan dengan usia serta berat baserta balita.

C. PEMENUHAN GIZI BALITA SESUAI USIA

1. Balita Usia 6-24 Bulan

Balita usia 6 – 24 bulan harus terpenuhi semua kebutuhan gizinya untuk pertumbuhan serta perkembangan. Pada usia ini balita sudah diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI (MPASI). Makanan dalam bentuk lumat dapat diberikan pada usia > 6 bulan seperti bubur susu, telur setengah matang, pepaya atau pisang dikerik serta lain sebagainya. Ketika usia 7 hingga 12 bulan makanan lembek atau lunak dapat diberikan seperti nasi tim, perkedel kukus sayur bayam, serta lain-lain. Pada saat anak berusia lebih melalui 12 bulan sudah dapat diperkenalkan dengan masakan keluarga. Jika pada usia ini mengalami ketidakseimbangan gizi maka dapat berdampak pada terhambat serta terganggunya pertumbuhan fisik serta perkembangan kecerdasan mental.

2. Balita Usia 2-5 Tahun

Balita pada usia 2 – 5 tahun mengalami pertumbuhan serta perkembangan yang sangat cepat sehingga kebutuhan zat gizinya juga lebih banyak dibanding usia di bawahnya. Usia ini membuat balita rentan mengalami gizi kurang, mengalami penurunan nafsu makan dan mudah terkena infeksi. Maka melalui itu asupan gizi seimbang sangat diperlukan. Balita pada usia ini sudah tidak mendapat ASI sehingga makanan keluarga atau makanan orang dewasa sudah dapat diberikan.[6].

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian makanan pada balita meliputi:

1. Berikan makanan dengan porsi yang tidak terlalu banyak sehingga balita tidak merasa sebah di perut.

2. Batasi makanan yang mengandung gula yang tinggi seperti permen, coklat, manisan, serta makanan-makanan yang terlalu manis. Hal ini akan menyebabkan balita menjadi cepat kenyang sehingga terjadi penurunan nafsu makan.
3. Hindari melalui menggunakan bumbu-bumbu tajam seperti cabe, merica, lada yang terlalu banyak agar tidak terjadi gangguan pada lambung serta usus.
4. Hindari penggunaan bahan pengawet dan MSG atau penyedap dalam makanan balita.
5. Ciptakan suasana yang menyenangkan saat memberikan makanan pada balita seperti makan bersama dalam keluarga.
6. Tidak memberi sanksi atau hukuman dan menakut-nakuti balita yang tidak mau makan karena hanya akan membuat balita trauma serta menjadikan waktu makan adalah hal yang menakutkan.[7]

D. PENCEGAHAN, DETEKSI SERTA PENEMUAN DINI GIZI BURUK

Pencegahan Gizi Buruk Upaya pencegahan kejadian gizi buruk pada balita perlu dilakukan sedini mungkin, berikut prinsip secara umum serta sesuai usia balita. Prinsip umum pencegahan gizi buruk:

1. Penyiapan kesehatan serta status gizi ibu hamil dilakukan sejak masa remaja serta selanjutnya saat usia subur.
 - a. Menerapkan pola hidup sehat bergizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan gizi serta mencegah terjadinya Kekurangan Energi Kronis (KEK).
 - b. Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)
 - c. Memperoleh konseling pranikah.
 - d. Mencegah pernikahan dini serta kehamilan pada remaja
 - e. Meningkatkan kepedanan Keluarga Berencana (KB).
 - f. Menerapkan praktik higiene serta sanitasi personal dan lingkungan.
2. Ibu hamil mendapat pelayanan antenatal care (ANC) terpadu berkualitas sesuai standar, penerapan standar pelayanan minimal, deteksi dini serta penanganan adekuat, pola hidup sehat serta gizi seimbang termasuk konseling.
3. Peningkatan status gizi serta kesehatan, pertumbuhan perkembangan dan kelangsungan hidup anak melalui strategi Pemberian Makan Bayi serta Anak (PMBA) yang dilakukan dengan praktik “Standar Emas Makanan Bayi serta Anak”:
 - a. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
 - b. ASI Eksklusif (0-6 Bulan)
 - c. Pemberian MP ASI mulai usia 6 bulan

- d. Pemberian ASI diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih. Selain itu, dilanjutkan dengan pemberian makan anak usia 24–59 bulan yang bergizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi pertumbuhan serta perkembangan anak.
 - e. Balita harus dipantau pertumbuhan serta perkembangannya secara rutin dan diberikan pola asuh yang sesuai. Balita juga harus memperoleh stimulasi perkembangan serta imunisasi lengkap sesuai dengan usianya seperti yang tercantum dalam buku Kesehatan Ibu serta Anak (KIA). Pemantauan perkembangan balita oleh keluarga mengacu pada Buku KIA sesertagkan pemantauan perkembangan balita oleh tenaga kesehatan mengacu pada Pedoman Stimulasi, Deteksi, serta Intervensi Dini Pertumbuhan Perkembangan (SDIDTK).
4. Penapisan massal untuk menemukan hambatan pertumbuhan serta perkembangan pada balita di tingkat masyarakat, dilakukan secara berkala melalui bulan penimbangan dengan target cakupan penapisan 100%. Bila ditemukan asertaya masalah pertumbuhan seperti kenaikan BB tidak memadai, maka balita perlu dirujuk ke tenaga kesehatan.
 5. Perhatian khusus diberikan pada bayi serta balita dengan faktor risiko akan mengalami kekurangan gizi, misalnya:
 - a. Bayi yang dilahirkan melalui ibu dengan kurang energi kronis (KEK) serta/ atau ibu usia remaja, bayi yang lahir prematur, bayi berat lahir rendah (BBLR), kembar, lahir dengan kelainan bawaan.
 - b. Balita dengan infeksi kronis atau infeksi akut berulang serta asertaya sumber penularan penyakit melalui dalam/ luar rumah atau gangguan kekebalan tubuh.
 - c. Balita yang berasal melalui keluarga dengan status sosio-ekonomi kurang.
 - d. Balita berkebutuhan khusus.
 - e. Balita yang berada di lingkungan yang terkendala akses air bersih, serta/ atau higiene serta sanitasi yang buruk. Semua balita dipantau pertumbuhannya secara berkala, terutama balita dengan faktor risiko.
 - f. Orangtua atau pengasuh diberi konseling tentang pemberian makan balita serta pelayanan lainnya dan tindak lanjut sedini mungkin untuk mengatasi masalah yang ditemukan.
 6. Dukungan program terkait Dukungan program terkait diperlukan dalam upaya pemenuhan total cakupan pelayanan, menghindarkan bayi/ balita melalui berbagai risiko kesehatan, konseling pemberian makan sesuai umur serta penanganan balita sakit secara komprehensif, dan advokasi serta komunikasi perubahan perilaku melalui komunikasi antar pribadi/ komunikasi interpersonal menuju pola hidup bersih serta sehat.

7. Dukungan lintas sektor Dukungan lintas sektor seperti dalam pemenuhan kebutuhan air bersih serta /atau pengadaan jamban keluarga, dan lingkungan sehat dalam upaya pencegahan penyakit infeksi berulang seperti diare yang dapat mengakibatkan gizi buruk pada balita[8]

E. PELAKSANAAN DETEKSI DINI SERTA RUJUKAN

Pelaksanaan Deteksi Dini serta Rujukan Kasus Deteksi dini kasus dilakukan:

1. Secara aktif, dilakukan oleh:
 - a. Anggota masyarakat, khususnya anggota masyarakat yang terlatih di setiap waktu serta setiap kesempatan.
 - b. Kader didampingi oleh petugas Kesehatan, melakukan sweeping serta kunjungan rumah untuk balita yang tidak hadir pada hari Posyandu. [1]Deteksi dini kasus ini dapat dilakukan dengan:
 - 1) Menimbang berat baserta balita
 - 2) Mengukur lingkar lengan atas (LiLA) balita usia 6–59 bulan dengan menggunakan pita LiLA berwarna
 - 3) Mengidentifikasi balita yang terlihat sangat kurus
 - 4) Mengidentifikasi kemungkinan asertaya pitting edema bilateral
 - 5) Mengidentifikasi bayi < 6 bulan yang terlalu lemah atau sulit menyusu
 - 6) Balita yang perlu dirujuk:
 - a) Balita yang terindikasi mengalami hambatan pertumbuhan
 - b) Balita (6–59 bulan) dengan LiLA di warna kuning (LiLA 11,5 cm - < 12,5 cm) atau warna merah (< 11,5 cm)
 - c) Balita (6–59 bulan) dengan LiLA di warna hijau namun terlihat sangat kurus
 - d) Balita yang teridentifikasi asertaya pitting edema bilateral
 - e) Bayi < 6 bulan yang terlalu lemah atau sulit menyusu
2. Secara pasif, saat kegiatan pemantauan pertumbuhan di Posyandu atau titik pemantauan lain (contoh kelas PAUD) serta saat balita berkunjung ke fasilitas layanan kesehatan (fasyankes). Deteksi dini kasus dengan:
 - a. Mengidentifikasi balita dengan hambatan pertumbuhan atau berisiko hambatan pertumbuhan menggunakan grafik pertumbuhan anak di KMS serta Buku KIA
 - b. Mengukur lingkar lengan atas (LiLA) balita usia 6–59 bulan dengan menggunakan pita LiLA berwarna untuk semua balita yang datang ke Posyandu
 - c. Pemeriksaan pitting edema bilateral
 - d. Mengidentifikasi bayi < 6 bulan yang terlalu lemah atau sulit menyusu
 - e. Balita yang perlu dirujuk bila:

- 1) Balita terindikasi mengalami hambatan pertumbuhan berdasarkan grafik pertumbuhan anak di KMS serta Buku KIA:
 - a) Garis pertumbuhan anak memotong salah satu garis Z-score
 - b) Garis pertumbuhan anak meningkat atau menurun secara tajam
 - c) Garis pertumbuhan anak terus mendatar, misalnya tidak ada kenaikan berat badan
- 2) Balita 6–59 bulan dengan LiLA di warna kuning (LiLA 11,5 cm - < 6 bulan yang terlalu lemah atau sulit menyusui Kader serta anggota masyarakat terlatih lain dibekali cara melakukan rujukan.[9]

F. PERMASALAHAN GIZI BALITA

Gizi buruk (*severe wasting*) dapat meningkatkan angka kesakitan serta kematian dan meningkatkan risiko terjadinya stunting. Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan prevalensi wasting pada balita sebesar 10,2% serta 3,5% atau sekitar 805.000 balita diantaranya adalah gizi buruk (*severe wasting*)

Gizi buruk adalah salah satu prioritas dalam pembangunan Kesehatan, sesuai arah kebijakan RPJMN 2020-2024, target tahun 2024 adalah menurunkan prevalensi wasting menjadi 7% serta stunting menjadi 14%. Penanganan balita gizi buruk harus dilakukan secara cepat serta sesuai untuk mencegah kematian serta komplikasi lebih lanjut dan memperbaiki pertumbuhan perkembangan anak di masa mendatang. Upaya penanggulangan gizi buruk dilakukan dengan pencegahan melalui penemuan dini serta memobilisasi masyarakat dan penanganan sesuai dengan tata laksana kasus, yang terintegrasi baik dengan pelayanan rawat jalan ataupun rawat inap.[10]

Menurut WHO, jika deteksi dini serta pemberdayaan masyarakat optimal, maka 80% atau sekitar 644.000 kasus gizi buruk dapat ditangani secara rawat jalan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan gizi buruk pada balita, meliputi melalui penyusunan Pedoman Pencegahan serta Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita, penguatan deteksi dini, edukasi gizi, 3 pemantauan pertumbuhan serta perkembangan balita, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita gizi kurang, pembentukan Therapeutic Feeding Centre (TFC) sebagai pusat pemulihan gizi di fasilitas kesehatan, dan peningkatan kapasitas tim asuhan gizi dalam tata laksana gizi buruk pada balita. Semua upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target RPJMN 2024 yaitu 60% Puskesmas di seluruh Indonesia mampu memberikan pelayanan tata laksana gizi buruk serta 90% balita gizi buruk mendapat pelayanan sesuai dengan tata laksana gizi buruk. Berbagai upaya terus dilakukan melalui

peningkatan akses serta kualitas pelayanan, peningkatan kerjasama lintas program/ sektor, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat. Penguatan teknis serta manajemen melalui seluruh sumber daya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penggerakan, dan pengawasan pengendalian menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengelolaan gizi buruk terintegrasi melibatkan semua pemangku kepentingan.

Pelayanan balita gizi buruk membutuhkan kolaborasi yang solid melalui tim asuhan gizi Puskesmas. Untuk lebih mengoptimalkan pemahaman serta kemampuan tim asuhan gizi, diperlukan panduan praktis berupa buku saku yang mengacu pada Pedoman Pencegahan serta Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita. Dengan asertaya buku saku tersebut, diharapkan dapat 5 meningkatkan cakupan serta kualitas pelayanan rawat jalan dalam penanganan balita gizi buruk terintegrasi.

G. PELAPORAN SERTA PENCATATAN

Dalam strategi penemuan dini serta kasus yang telah disepakati, perlu ditentukan sistem pencatatan serta pelaporan, khususnya untuk deteksi dini secara aktif serta rujukan kasus oleh anggota masyarakat. Pemantauan serta supervisi fasilitatif tenaga kesehatan, kepala daerah, serta pemangku kepentingan terkait perlu melakukan pemantauan serta supervisi fasilitatif secara berkala untuk kegiatan deteksi dini serta rujukan kasus balita gizi buruk atau balita yang berisiko gizi buruk. Dalam kegiatan pemantauan serta supervisi fasilitatif dibicarakan hal-hal yang menjadi keberhasilan, tantangan atau kendala serta mencari solusi bersama. Hal-hal yang perlu dipantau, termasuk diantaranya:

1. Cakupan Posyandu
2. Jumlah balita yang diskriming dengan menggunakan pita Lila
3. Jumlah balita dengan hambatan pertumbuhan
4. Jumlah balita yang dirujuk oleh anggota masyarakat terlatih melalui deteksi kasus aktif
5. Jumlah balita yang dirujuk dengan hambatan pertumbuhan

DAFTAR PUSTAKA

- A. K. Septa, K. Isti, and G. Putro. 2016. *Balita Garis Merah. Potret Status Gizi Balita Di Kindifey*.
- D. Riyadi and A. H. Fitriah. 2019. "Dasar-Dasar Manajemen dalam Pendidikan Gizi," *Refika*.
- Hardinsyah & Supariasa. 2016. "Buku 2016_1_TVS.pdf."
- I. Mardalena and E. Suyani. 2016. "Keperawatan Ilmu Gizi," *Kementeri. Kesehat. Republik Indones.*, p. 182, 2016, [Online]. Available: <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/08/Ilmu-Gizi-Keperawatan-Komprehensif.pdf>
- Kemenkes RI. 2019. "Pedoman Pencegahan Serta Tatalaksana Gizi Buruk Pada Balita," *Kementeri. Kesehat. Republik Indones.*, pp. 1–120, 2019.
- Kemenkes RI. 2020. *Pencegahan serta Tata Laksana Gizi Buruk Pada Balita di Layanan Rawat Jalan Bagi Tenaga Kesehatan*. 2020.
- PSG, "Hasil Psg 2017," *Buku saku pemantauan status gizi tahun 2017*, pp. 7–11, 2017.
- S. A. Fajar, "CAGI PEDIATRIC (Catatan Ahli Gizi Anak Indonesia)," *Azura*, 2018.
- S. A. Fajar, "Handbook: Buku Saku Gizi (Pediatric, Youth, Adult, Geriatri) Azura," *Handb. Buku Saku Gizi (Pediatric, Youth, Adult, Geriatr.*, p. 14, 2009.
- T. S. Purwanto and R. Sumaningsih. 2019. *Modul Ajar Gizi Ibu serta Anak Jilid 2*.

BAB 3

BUKU KIA

Siti Patimah,SST,M.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. PENDAHULUAN

Salah satu agenda utama SDGs adalah menurunkan angka kematian ibu dan kematian Balita. Kehamilan, persalinan, nifas, dan masa kanak-kanak adalah masa kritis. Secara global, kematian ibu dan anak telah turun secara signifikan, tetapi bebannya masih tinggi. Hampir 300 ribu perempuan meninggal selama dan setelah kehamilan dan persalinan pada tahun 2017. Demikian pula, sekitar 5 juta anak balita meninggal setiap tahun. Penyediaan pemeriksaan antenatal berkualitas tinggi dan teratur selama kehamilan kemungkinan akan menentukan status kesehatan ibu hamil dan anak-anak.

Pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan ketersediaan layanan esensial bagi ibu dan anak. Buku KIA memainkan peran penting sebagai alat berbasis rumah untuk memastikan kesehatan ibu dan anak yang berkelanjutan. Buku KIA merupakan panduan bagi keluarga dan penyedia layanan kesehatan untuk mengidentifikasi awal masalah kesehatan selama masa kehamilan dan masa kanak-kanak. Dengan demikian, buku pegangan ini merupakan alat yang efektif untuk memantau penyediaan dan ketersediaan layanan kesehatan ibu dan anak yang esensial untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Pandemi telah mempengaruhi program *International Knowledge Sharing*, melalui buku KIA Indonesia melakukan penguatan deteksi dini masalah kesehatan ibu dan anak melalui pemanfaatan buku KIA., pemberdayaan keluarga menggunakan buku KIA untuk deteksi dini, serta bagaimana meningkatkan kapasitas tenaga Kesehatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan buku KIA. (Kemenkes, 2022)

Kemenkes RI menyampaikan komitmen dalam pemanfaatannya di masyarakat masih belum sesuai harapan, sehingga perlu penguatan terutama kelengkapan pengisiannya oleh petugas kesehatan, kader dan orangtua. Buku KIA sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, karena berisi informasi kesehatan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan meliputi imunisasi, gizi seimbang dan Vitamin A. (Kemenkes, 2018). Berdasarkan hal tersebut maka Perlu dilakukan optimalisasi penggunaan buku kesehatan ibu dan anak (KIA) dalam mendukung kesehatan ibu dan anak. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang buku KIA secara lengkap. Besar harapan kami dapat membantu pembaca dalam memahami isi buku KIA dan bisa mengisinya dengan benar.

B. SEJARAH BUKU KIA

Buku KIA ini diperkenalkan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) pada tahun 1994 di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, kemudian diperkenalkan secara bertahap pada tingkat nasional sampai mencakup 33 provinsi pada 2005 (Dirjen Kesmas, 2016). Sejarah keberadaan Buku KIA di Indonesia terjadi pada 1994 yang menjadi titik balik dimana sebelumnya pencatatan pelayanan kesehatan ibu dan anak berupa kartu dan lembaran yang terpisah-pisah, dengan kemungkinan besar akan hilang dan tercecer. Bentuk pencatatan KIA yang mengintegrasikan kartu dan lembaran menjadi buku tersebut berfungsi sebagai home-based record untuk ibu hamil-bersalin-nifas sampai anak berusia 5 tahun.

Pada 2004 menjadi satu-satunya pencatatan KIA yang dituangkan dalam Kepmenkes nomor 284 tahun 2004, yang kemudian disepakati revisi Buku KIA diagendakan setiap 5 tahun sekali, dilakukan pada tahun 2009, 2015 dan tahun 2020 ini adalah revisi yang ketiga. Revisi buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) menjadi agenda revisi lima tahunan untuk mengikuti perkembangan ilmu dan kebijakan kesehatan yang terbaru. (Kemenkes, 2020)

C. DEFINISI

Menurut Kepmenkes RI Nomor 284/MENKES/SK/III/2024 Tentang Buku KIA, bahwa Buku KIA merupakan alat untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan atau masalah Kesehatan ibu dan anak, alat komunikasi dan penyuluhan dengan informasi yang penting bagi ibu, keluarga dan masyarakat mengenai pelayanan Kesehatan ibu dan anak termasuk rujukannya dan paket (standar) pelayanan KIA, gizi, imunisasi dan tumbuh kembang balita. (*Kepmenkes Buku KIA*, n.d.)

Buku KIA mengintegrasikan beberapa catatan kesehatan di komunitas seperti Kartu Menuju Sehat (KMS) untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan bayi balita, kartu imunisasi, kartu ibu dan beberapa hal lainnya. Buku KIA berisi informasi penting mengenai kesehatan ibu dan anak yang perlu dilakukan oleh ibu, suami dan keluarganya secara singkat dan padat, termasuk mengenai kewaspadaan keluarga dan masyarakat akan kesakitan dan masalah kegawatdaruratan pada ibu hamil, bayi baru lahir dan balita, sehingga pada akhirnya buku KIA menyumbang penurunan angka kematian bayi dan balita. (Kemenkes RI, 2018)

D. TUJUAN

Menurut Depkes RI buku KIA Bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan ibu dan anak di Indonesia, dengan kualitas layanan yang baik maka akhirnya dapat menurunkan AKI dan AKB. Beberapa tujuan buku KIA lainnya adalah untuk memudahkan keluarga dalam memahami informasi kesehatan tentang ibu dan anak yang tercantum dalam buku KIA, memudahkan tugas Ibu

untuk dapat memahami kondisi kesehatannya sendiri dan bayinya secara mandiri, serta untuk meningkatkan praktik keluarga dan masyarakat dalam memelihara/merawat kesehatan ibu dan anak (Departemen Kesehatan dan JICA, 2015)

E. MANFAAT

Hasil analisis data Riskesdas 2013 dan Sirkesnas 2016 menunjukkan terdapat keterkaitan antara kepemilikan Buku KIA dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ibu yang memiliki buku KIA lebih sering melakukan pemeriksaan kehamilan, lebih banyak bersalin dengan pertolongan tenaga kesehatan dan lebih banyak bersalin di fasilitas kesehatan dibandingkan ibu yang tidak memiliki Buku KIA. Bayi dari ibu yang memiliki Buku KIA juga lebih banyak mendapat imunisasi dasar lengkap daripada bayi dari ibu yang tidak memiliki Buku KIA, sehingga dapat disimpulkan bahwa Buku KIA berdampak positif pada perubahan perilaku ibu.

Manfaat Buku KIA tidak saja pada sektor kesehatan, tetapi sudah diintegrasikan dengan sektor lain, diantaranya surat keterangan lahir untuk mempermudah mendapatkan akte, buku pegangan pendamping Program Keluarga Harapan, sebagai media pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di PAUD, Bina Keluarga Balita dan lain-lain. (Kemenkes RI, 2018) . Menurut (Eka, 2019) Manfaat lainnya dari Buku KIA juga sebagai berikut : (Kemenkes RI, 2022)

1. Sebagai media KIE

Buku KIA berisi informasi Kesehatan ibu dan anak yang sangat lengkap, mulai masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta upaya promotif dan preventif Kesehatan, ada pula deteksi dini masalah Kesehatan ibu dan anak, pencegahan kekerasan terhadap anak dan kesiapsiagaan dalam situasi bencana.

Tenaga Kesehatan dapat menggunakannya sebagai media KIE, sebagai alat bantu untuk menjelaskan informasi Kesehatan sesuai dengan kebutuhan klien. Buku KIA memiliki tampilan gambar menarik dan isi pesan yang lengkap sehingga memudahkan tenaga Kesehatan dalam menyampaikan pesan.

2. Sebagai dokumen pencatatan pelayanan KIA

Buku KIA berisi catatan Kesehatan ibu dan catatan Kesehatan anak yang diisi oleh petugas Kesehatan maupun kader Kesehatan. Karena itu merupakan sebagai bukti pencatatan pelayanan Kesehatan ibu dan anak, memantau dan mendeteksi masalah Kesehatan ibu dan anak, untuk memastikan terpenuhinya hak mendapatkan pelayanan Kesehatan secara lengkap dan berkesinambungan.

3. Dapat digunakan pada system jaminan Kesehatan untuk mengajukan klaim pelayanan, dan untuk menerima bantuan bersyarat pada program pemerintah atau swasta

F. SASARAN BUKU KIA

Sasaran buku KIA terdiri dari dua yaitu, sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Berikut akan dijelaskan yang menjadi sasaran tersebut :

1. Sasaran langsung
 - Setiap ibu hamil akan mendapatkan Buku KIA, yang harus digunakan sejak masa kehamilan dan dilanjutkan penggunaannya samapai anak umur 6 tahun
 - Apabila kehamilan ibu di ketahui kembar maka ibu hamil diberikan Buku KIA sejumlah janin yang di kandungnya
 - Jika buku KIA hilang maka ibu/anak akan mendapatkan Buku KIA baru
 - Walaupun petugas akan mengganti buku yang hilang, ibu harus diberikan pengertian untuk menjaga Buku KIA tidak hilang, karena catatan Riwayat Kesehatan ibu/bayi tidak bisa di tuliskan Kembali.
2. Sasaran tidak langsung
 - Suami/anggota keluarga lain, pengasuh anak di panti/Lembaga kesejahteraan sosial anak
 - Tenaga Kesehatan yang berhubungan langsung untuk memberikan pelayanan Kesehatan ibu dan anak (Dokter, Bidan, Perawat, Nutritonist, Petugas Imunisasi, Petugas Laboratorium)
 - Kader Kesehatan di Posyandu
 - Guru TK/ Pendidikan anak usia dini
 - Penanggung jawab dan pengelola program KIA Dinas Kesehatan kabupaten/kota

G. MENGGUNAKAN BUKU KIA

Tenaga Kesehatan mempunyai peran yang penting dalam keberhasilan penggunaan buku KIA. Peran tenaga Kesehatan antara lain menjadikan buku KIA sebagai media KIE dan dokumen pencatatan pelayanan KIA. Tenaga Kesehatan juga harus memfasilitasi kader dalam mengisi KMS dan catatan pemberian vitamin A. Secara rinci berikut ini peran tenaga Kesehatan dalam menggunakan buku KIA :

1. Peran tenaga Kesehatan dalam menggunakan buku KIA

Tenaga Kesehatan harus memfasilitasi pemahaman dan penerapan buku KIA oleh orangtua, keluarga, kader dan pengasuh anak di panti/Lembaga kesejahteraan sosial, maka dalam hal ini peran tenaga Kesehatan yaitu :

- Menginformasikan pelayanan Kesehatan ibu dan anak yang menjadi hak setiap ibu dan anak
 - Menggunakan buku KIA sebagai media KIE
 - Mencatat setiap pelayanan yang diberikan dengan baik dan benar sejak ibu hamil sampai anak usia 6 tahun pada buku KIA
 - Menggunakan catatan pelayanan sebagai penyerta pada system jaminan Kesehatan dan bantuan bersyarat program pemerintah atau swasta
 - Memfasilitasi keluarga untuk segera mengurus akta kelahiran dengan melampirkan surat keterangan lahir yang ada di buku KIA
 - Memfasilitasi pemahaman dan penggunaan buku KIA oleh ibu, suami, keluarga dan pengasuh
 - Memfasilitasi kader dalam penerapan buku KIA
2. Peran tenaga Kesehatan memfasilitasi penggunaan buku KIA oleh ibu, keluarga/pengasuh

Tenaga Kesehatan bisa melakukan hal – hal di bawah ini untuk memfasilitasi ibu, keluarga/pengasuh dalam menggunakan buku KIA :

- Mengingatkan ibu, keluarga/pengasuh untuk selalu membawa buku KIA pada saat ke fasilitas Kesehatan, posyandu, kelas ibu pos PAUD dan Binak keluarga balita
- Meminta klien menyimpan buku KIA dan menjaga dengan baik agar tidak rusak/hilang. Hanya memperlihatkan buku KIA pada petugas Kesehatan
- Ibu, keluarga dan pengasuh berperan aktif membaca dan mengerti buku KIA dengan benar, jika ada yang tidak di pahami bertanya pada kader dan tenaga Kesehatan
- Membaca terlebih dahulu pokok bahasan dalam buku KIA untuk pertemuan selanjutnya, dan menyiapkan pertanyaan untuk hal-hal yang belum mengerti
- Memberi tanda centang pada bagian yang telah di pahami dan diterapkan oleh ibu/pengasuh.
- Memberi tanda centang pada kotak setelah mendapatkan pelayanan Kesehatan.
- Tenaga Kesehatan memberikan pemahaman kepada ibu, suami, keluarga/pengasuh terkait pesan informasi Kesehatan yang tertera pada buku KIA pada masa kehamilan, persalinan, masa nifas dan neonates, masa sejak lahir – 6 bulan, masa bayi 6 -12 bulan, pada anak usia 1-2 tahun, pada anak usia 2-6 tahun.

3. Peran tenaga Kesehatan dalam memfasilitasi penggunaan buku KIA oleh kader Kader merupakan salah satu sasaran dan pengguna buku KIA. Pemerintah membekali kader dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan buku KIA melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan dan revitalisasi. Berikut alasan kenapa tenaga Kesehatan harus memfasilitasi kader :

- Karena kader menggunakan buku KIA sebagai media penyuluhan Kesehatan ibu dan anak
- Kader aktif dalam memfasilitasi ibu, keluarga/pengasuh anak agar mematuhi jadwal pemberian layanan Kesehatan ibu dan anak dan imunisasi
- Kader Bertugas mengisi KMS
- Memberi vitamin A dan mencatat pada buku KIA
- Sebagai penghubung masyarakat dengan tenaga Kesehatan untuk memastikan penggunaan buku KIA oleh masyarakat

H. EVIDENCE BASED BUKU KIA

Banyak peneliti yang tertarik untuk mengetahui dan menguji buku KIA. Penelitian Nur HA menemukan Terdapat hubungan antara pemanfaatan buku KIA dengan tingkat pengetahuan dan perilaku kesehatan ibu hamil trimester III, semakin tinggi pemanfaatan buku KIA, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan perilaku kesehatan ibu hamil. (NUR HIDAYATUL AINIYAH, 2017). Hal ini sejalan dengan manfaat buku KIA. Penelitian lainnya di masa pandemic Buku KIA bisa mempermudah keluarga dalam mendeteksi masalah kesehatannya secara mandiri, sehingga mengurangi resiko kontak/ tertular oleh COVID -19. Persentase ketercapaian 59% ibu menjadikan buku KIA sebagai sahabat ibu dan anak untuk menemani sebelum kontak dengan fasilitas Kesehatan di masa pandemic (Amalia et al., 2021).

Suatu literature review dilakukan menemukan beragamnya studi yang ada, telah membuktikan manfaat, fungsi, dan efektifitas buku KIA terhadap kesehatan ibu, bayi, dan anak. Kategori pemanfaatan dan kegunaan buku KIA yang terintegrasi dengan catatan berbasis rumah, yaitu sebagai alat yang efektif guna memfasilitasi peningkatan perilaku pencarian kesehatan; perawatan yang; komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan; serta sebagai rekaman/catatan kesehatan berbasis rumah. Dalam rangka mengisi adanya kesenjangan, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada evaluasi khususnya pada bayi prematur/BBLR sebagai bagian dari populasi bayi baru lahir dengan risiko tinggi. Pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan implementasi intervensi dan aksesibilitas buku KIA juga dirasakan penting untuk dikembangkan. (Rustina et al., 2020)

I. MENGENAL DAN MENGISI BUKU KIA

Buku KIA revisi tahun 2021 terdiri dari dua bagian yaitu bagian ibu dan bagian Anak. (Kemenkes dan JICA, 2021)

Pada bagian ibu dan bagian anak terdapat :

1. Bagian Buku KIA yang di isi oleh tenaga Kesehatan,
2. Bagian buku KIA yang di isi oleh ibu, suami. Keluarga/pengasuh
3. Bagian buku KIA yang di isi oleh kader



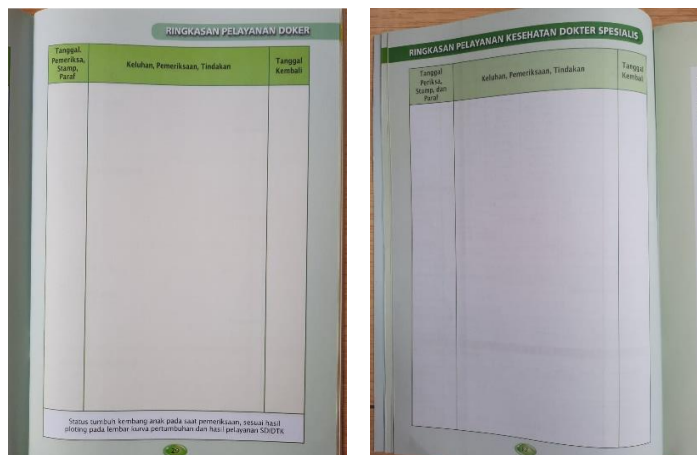
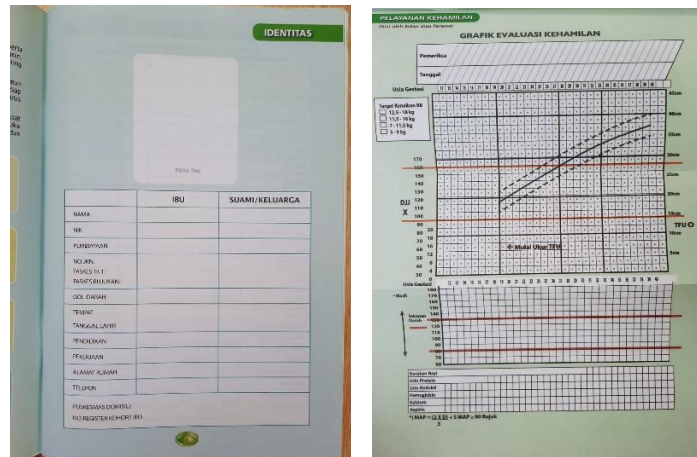
Gambar 3.1 Cover buku KIA bagian Ibu

Untuk mempermudah mempelajari buku KIA maka akan dibahas pada masing – masing bagian sebagai berikut :

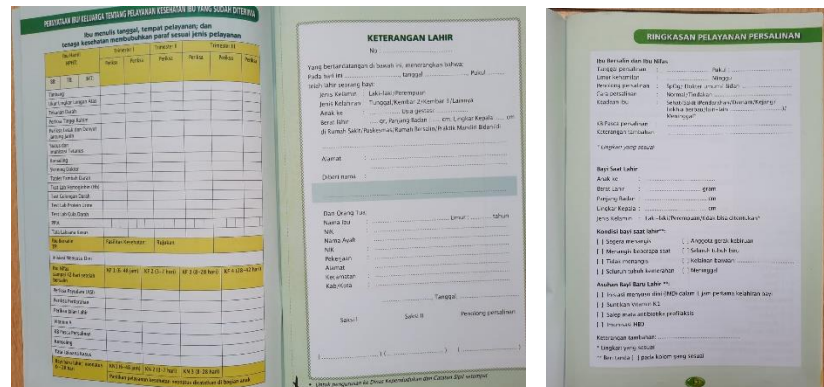
1. Buku KIA Bagian ibu

Pada bagian ini secara umum terdiri dari bagian bagian yang berupa catatan dan, bagian yang berisi informasi. Bagian catatan antara lain :

- Identitas ibu hamil , hal 1
- Pernyataan pelayanan Kesehatan ibu, hal 2
- Amanat persalinan, hal 4
- Pelayanan Dokter, hal 5-12
- Pelayanan kehamilan, hal 7-8
- Pelayanan persalinan, hal 13
- Pelayanan nifas, hal 14
- Pelayanan rujukan, hal 15



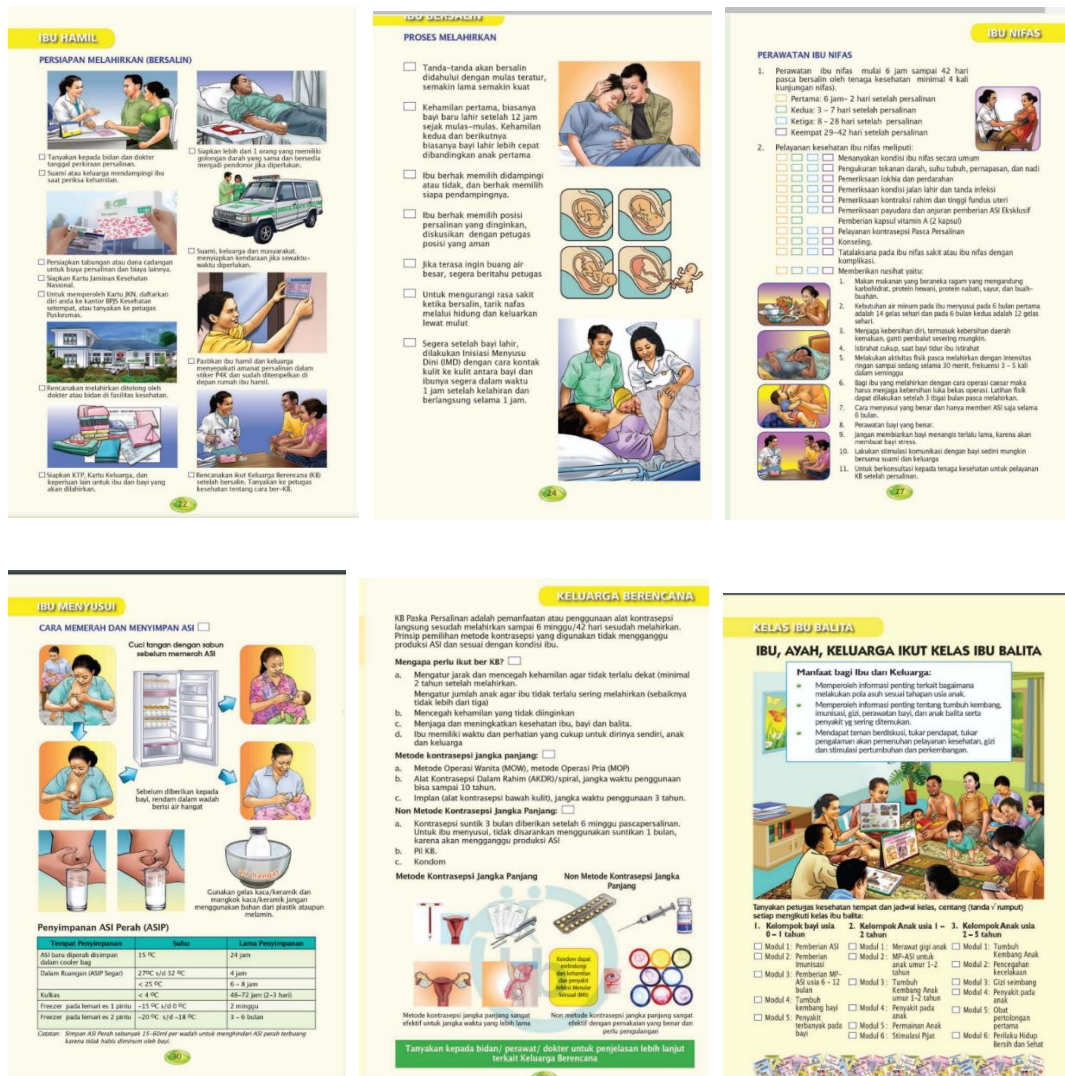
Gambar 3.2. Identitas dan pelayanan kehamilan



Gambar 3.3. Persalinan dan nifas

Setelah bagian catatan di buku KIA juga terdapat bagian – bagian yang berisi informasi Kesehatan yaitu :

- Ibu hamil, hal 16 – 22
- Ibu bersalin, hal 23 – 25
- Ibu nifas , hal 26 – 28
- Ibu menyusui, hal 29 – 31
- Keluarga Berencana, hal 33
- Kelas ibu hamil, hal 17



Gambar 3.4. Informasi Kesehatan ibu

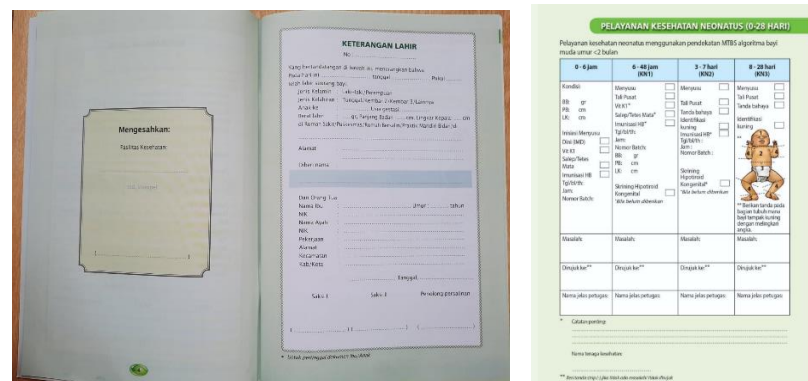
2. Buku KIA Bagian Anak

Sama seperti halnya pada bagian ibu, di bagian anak juga buku KIA terdiri dari bagian catatan dan bagian informasi. Bagian catatan yaitu :

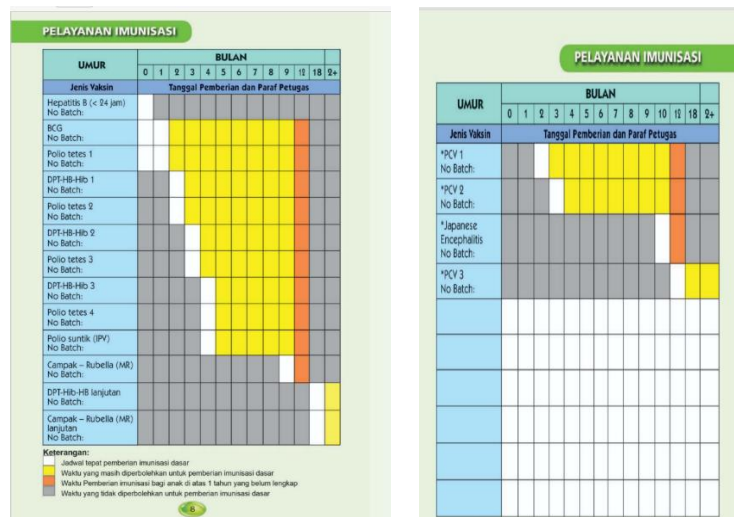
- Identitas, hal 1
- Pelayanan Kesehatan neonates, hal 7
- Imunisasi, hal 8 -9
- Pelayanan SDIDTK, hal 10 – 11
- PMBA.VIT A, Obat cacing, hal 12
- Kurva pertumbuhan, hal 13 – 25
- Ringkasan pelayanan MTBS, hal 27
- Rujukan, hal 31



Gambar 3.5 cover bagian anak dan identitas



Gambar 3.6 Keterangan kelahiran dan pelayanan neonatus



Gambar 3.7 Pelayanan imunisasi

PELAYANAN SDIDTK

PEMANTAUAN PERKEMBANGAN BUKU KIA		Umur	Deteksi Dini Penyimpangan Pertumbuhan			
			BB/N (DK/N) (BB/L)	BB/TB (DK/TB) (BB/GS)	TBAJ (SP/PT) (Ta/TT)	LKJ (M/L) (Ma)
20 hari-3 bulan		3 bulan				
3-6 bulan		6 bulan				
6-9 bulan		9 bulan				
9-12 bulan		12 bulan				
12-18 bulan		15 bulan				
18-24 bulan		18 bulan				
2-3 tahun		21 bulan				
3-4 tahun		24 bulan				
4-5 tahun		30 bulan				
5-6 tahun		36 bulan				
		42 bulan				
		48 bulan				
		54 bulan				
		60 bulan				

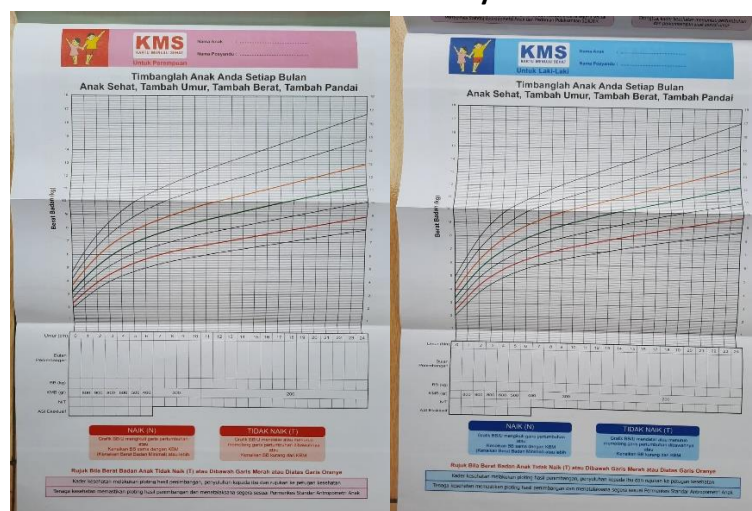
Orang tua dan keluarga diminta oleh kader memantau perkembangan anak sesuai ceklis pada Buku KIA halaman 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, dan 53.

Pelayanan SDIDTK

Deteksi Dini Penyimpangan Perkembangan	Deteksi Dini Penyimpangan Perilaku Emosional	Tindakan di rumah (Rujukan, rujukan)	Kunjungan Ulang
KMPD (DK/DK) (Dy)			
TDO (DN/D)			
TDL (DN/D)			
KMPD (DN/D)			
HE-CHAT (DN/D)			
GPPH (DN/D)			

Tetapi kesulitan melakukan skrining perkembangan dan tatalaksana segera sesuai Pedoman Pelaksanaan SDIDTK

Gambar 3.8 Pelayanan SDIDTK



Gambar 3.9 KMS anak perempuan, anak laki-laki

Buku KIA bagian anak juga berisi informasi antara lain sebagai berikut :

- Bayi baru lahir, hal 34 – 37
- Kondisi batita, hal 38
- Bayi, anak balita 6 – 24 bulan, hal 40 – 47
- Anak balita umur 2 – 3 tahun, hal 49
- Anak balita umur 3 – 4 tahun, hal 51
- Anak balita 4 – 5 tahun, hal 52
- Anak 5 – 6 tahun, hal 53
- Kelas ibu balita, hal 32



Gambar 3.10. Informasi Kesehatan

Ada hal yang menarik dari edisi revisi ini yaitu pada bagian informasi ada topik kesiapsiagaan dalam situasi bencana. Tentunya ini adalah hal tepat mengingat Indonesia termasuk negara yang rawan bencana alam (banjir, longsor, gempa bumi, tsunami) ibu dan anak adalah kelompok rentan terdampak pada situasi bencana, karena itu keluarga harus memahami bagaimana mempersiapkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, adaptasi di pengungsian dan trauma pasca bencana. Persiapan kesiapsiagaan menghadapi bencana oleh keluarga yaitu :

- a. Membuat rencana darurat keluarga
 - Mengenali ancaman bencana
 - Menyimpan nomor kontak penting (keluarga, fasilitas pelayanan Kesehatan/RS/Puskesmas/Klinik dll.
 - Identifikasi lokasi untuk mematikan gas, air dan listrik
 - Identifikasi titik kumpul dan titik aman di dalam bangunan atau rumah
 - Mengetahui rute evakuasi
 - Identifikasi anggota keluarga yang rentan (bayi, balita, ibu hamil. Ibu bersalin, lansia, penyandang disabilitas)
- b. Menyimak informasi dari radio/televisi/media online/informasi resmi dari BPBD, BNPB
- c. Menyiapkan KIT Bencana

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., Mardiyanti, I., Andriani, R., Putri, W., & Nasir, M. (2021). Buku KIA dalam Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Paradigma*, 3, 39–44.
- Dirjen Kesmas, K. R. (2016). *TCTP Buku KIA*. Kemenkes. <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/080117-tctp-buku-kia>
- Eka, E. (2019). *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Wineka Eka. https://books.google.co.id/books?id=-_CYDwAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Kemenkes. (2018). *Ayo Tingkatkan Pemanfaatan Buku KIA untuk Pantau Kesehatan Ibu dan Anak*. Kemenkes. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20180919/0627969/ayo-tingkatkan-pemanfaatan-buku-kia-pantau-kesehatan-ibu-dan-anak/>
- Kemenkes. (2020). *Sosialisasi Buku KIA edisi Revisi tahun 2020*. Dirjen Kesmas, Kemenkes. <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/061918-sosialisasi-buku-kia-edisi-revisi-tahun-2020#>
- Kemenkes. (2022). *Turunkan Angka Kematian Ibu dan Anak, Buku KIA Wajib Dimiliki Keluarga*. Kemenkes. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220909/0441039/turunkan-angka-kematian-ibu-dan-anak-buku-kia-wajib-dimiliki-keluarga/>
- Kemenkes dan JICA. (2021). *BUKU KIA*. Kemenkes RI.
- Kepmenkes Buku KIA*. (n.d.).
- NUR HIDAYATUL AINIYAH. (2017). *HUBUNGAN PEMANFAATAN BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) DENGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN PERILAKU KESEHATAN IBU HAMIL TRIMESTER III DI PUSKESMAS JAGIR SURABAYA*. Universitas Asyiyah Yogyakarta.
- Rustina, Y., Efendi, D., & Ilmu Keperawatan, F. (2020). Literature Review: Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta Potensi Pengembangan Selanjutnya Literature Review: Utilization of Maternal and Child Health Books and Potential for Further Development. *Jurnal Kesehatan*, 11(2), 311–321. <http://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK>

BAB 4

BABY SPA

Retno Wulan, S.S.T.Keb.,M.K.M



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. DEFINISI

Spa adalah singkatan dari Solus Per Aqua yang berarti perawatan atau pengobatan, air air. Spa tersebut berasal dari kota kecil di provinsi Liège dengan mata air mineral yang sudah ada sejak abad ke-14 (Julianti, 2017).

Baby Spa adalah perawatan bayi yang terdiri dari hydrotherapy (renang), (senam) dan pijat (massage). Berendam dan berenang dimaksudkan untuk merangsang gerakan motorik pada bayi. Air membuat seluruh anggota tubuh bayi, saat berendam dilatih untuk mengontrol gerakan bayi, biasanya bayi lebih peka dan tanggap terhadap lingkungan (Riksani, 2014). Spa adalah perawatan air atau sistem hipnoterapi. Permenkes No. 1205/Menkes/X/2004 Spa adalah pijat tradisional yang menggunakan metode hidroterapi (hipnoterapi) dan pijat (massage) untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan emosi (Yahya, 2011).

B. MANFAAT

Baby spa menawarkan perasaan tenang, nyaman dan segar sehingga bayi dapat tidur dengan nyenyak. Karena 75% hormon pertumbuhan dilepaskan saat tidur. Seiring meningkatnya hormon, jumlah jam tidur bayi juga meningkat (Fida, 2012). Hal ini sejalan dengan penelitian Galenia (2014), manfaat baby spa yang mengoptimalkan pertumbuhan fisik anak, membawa berat badan dan tinggi badan anak ke tingkat normal dengan rekomendasi Kemenkes untuk pertumbuhan fisik normal. Baby spa menawarkan keuntungan seperti baby swimming dan baby massage. Manfaat berenang bayi adalah merangsang gerakan motorik bayi sehingga otot bayi berkembang dengan baik, persendian nutrisi bekerja dengan optimal, sehingga menghasilkan pertumbuhan dan pemulihan tubuh yang optimal. Seperti halnya gerakan gerak, pertumbuhan tubuh semakin cepat dan tubuh menjadi lebih lentur.

C. PERLENGKAPAN BABY SPA

Menurut Julianti (2017) perlengkapan yang perlu disiapkan untuk baby spa sebagai berikut:

1. Handuk
2. Tempat berenang berukuran lebar dan kedalamannya 1 meter
3. Pelampung atau keamanan untuk bayi yang dilingkarkan dileher
4. Air bersih hanya sekali pakai
5. Membawa permainan tahan air seperti bola plastik berukuran sedan

D. TAHAPAN-TAHAPAN BABY SPA

Menurut Galenia (2014) tahap baby spa yaitu :

1. Pemeriksaan kondisi bayi
Pada bayi sehat, keadaannya bahagia dan tidak mempunyai kelainan bawaan pada umur 3 bulan sampai berat mencapai 5 kg.
2. Senam / Baby Gym
Senam sekitar 5 menit untuk tujuan mengoptimalkan kerja otot dan sendi tumbuh. Bayi diharapkan dapat menggerakkan tubuh secara cepat kuat dan aman.
3. Berenang / baby swim
Waktu berenang pada bayi kurang dari 6 bulan 10 menit, sedangkan lebih dari 6 bulan dapat di tingkatkan menjadi 15 menit sampai 30menit dengan 34-35°C. Manfaat yang di dapatkan dari berenang melatih otot motorik kasar dan halus.
4. Pijat / Baby massage
Sentuhan pijatan dimulai dari kaki, perut, dada, tangan, wajah dan punggung.

E. GERAKAN TAHAPAN BABY SPA

1. Pijat Bayi (*Baby Massage*)

Pijat bayi adalah isyarat yang indah untuk komunikasi antara ibu dan bayi. Sentuhan alami dengan bayi sebenarnya sama dengan memijat atau memijat. Prosedur ini dilakukan secara teratur dan sesuai dengan metode dan teknik pijat bayi, pijat ini dapat menjadi terapi yang menawarkan banyak manfaat bagi bayi (Dewi, 2016).

a. Manfaat Pijat Bayi

- 1) Meningkatkan berat badan
Peningkatan berat badan serta pertumbuhan pada bayi yang dilakukan pemijatan secara teratur dari lahir dapat memperoleh peningkatan berat badan yang lebih efektif dari pada bayi yang lain karena sentuhan pemijatan dapat memproduksi hormon pertumbuhan (Galenia, 2014).
- 2) Meningkatkan pertumbuhan
Semua sistem sensorik dan motorik berguna untuk pertumbuhan otak membentuk kecerdasan emosional dan merangsang kecerdasan lainnya (Galenia, 2014).
- 3) Meningkatkan daya tahan tubuh
Daya tahan tubuh pemijatan ini dapat meningkatkan kekebalan sel pertumbuhan alami (Galenia, 2014).
- 4) Meningkatkan konsentrasi bayi
Pijatan dapat mengubah gelombang otak dikarenakan umumnya bayi dipijat akan tertidur lebih lelap, meningkatkan kesiagaan konsentrasi.

Perubahan yang terjadi dengan menurunkan gelombang alfa akan meningkatkan gelombang beta serta teta yang dapat di buktikan dengan penggunaan EGE (Electro Encephatograp) (Galenia, 2014).

b. Waktu pemijatan

Pemijatan dapat dilakukan pada bayi usia 0-12 bulan. Untuk bayi yang berusia di bawah 7 bulan, pemijatan dapat dilakukan setiap hari. Waktu pemijatannya sebaiknya dilakukan 2 kali sehari yaitu

- 1) Pagi hari, pada saat orang tua dan anak siap untuk memulai hari baru
- 2) Malam hari, sebelum tidur.

c. Persiapan sebelum memijat:

- 1) Mencuci tangan dan dalam keadaan hangat.
- 2) Hindari kuku dan perhiasan yang bisa menggores kulit bayi.
- 3) Ruang untuk memijat usahakan hangat dan tidak menguap.
- 4) Bayi selesai makan atau tidak berada dalam keadaan lapar.
- 5) Usahakan tidak diganggu dalam waktu lima belas menit untuk melakukan semua tahap pemijatan.
- 6) Baringkan bayi di atas kain rata yang lembut dan bersih.
- 7) Ibu/ayah duduk dalam posisi nyaman dan tenang.
- 8) Siapkan handuk, popok, baju ganti, dan minyak bayi (baby oil/lotion).
- 9) Sebelum memijat, mintalah izin kepada bayi dengan cara membelai wajah dan kepala bayi sambil mengajak bicara.

d. Hal-hal yang tidak dianjurkan selama pemijatan :

- 1) Memijat bayi langsung setelah selesai makan.
- 2) Membangunkan bayi khusus untuk pemijatan.
- 3) Memijat bayi pada saat bayi dalam keadaan tidak sehat
- 4) Memijat bayi pada saat bayi tidak mau dipijat.
- 5) Memaksakan posisi pijat tertentu pada bayi

e. Urutan Pijat Bayi

Setiap gerakan pada tahap pemijatan dapat diulang sebanyak enam kali (Roesli, 2013).

1) Kaki

a) Perahan cara India

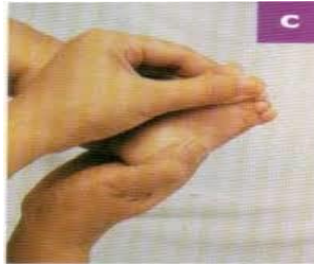
Peganglah kaki bayi pada pangkal paha, seperti memegang pemukul bergantian seperti memerah susu.



Gambar 4.1

b) Telapak Kaki

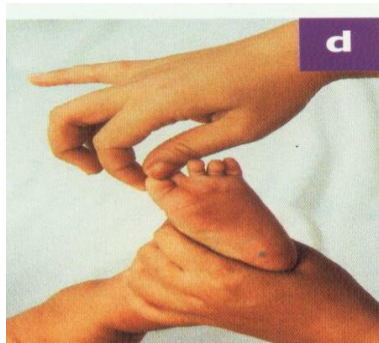
Urutlah telapak kaki bayi dengan kedua jari secara bergantian, dimulai dari tumit menuju jari – jari di seluruh telapak kaki



Gambar 4.2

c) Tarikan lembut jari

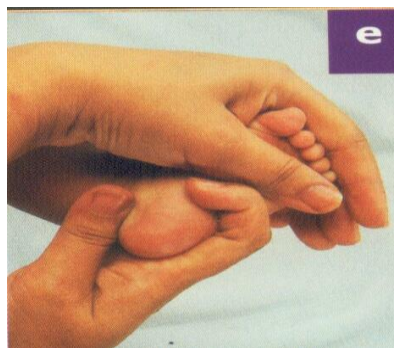
Pijatlah jari satu persatu dengan gerakan memutar menjauh, dengan tarikan yang lembut pada tiap ujung jari. Telapak kaki, diakhiri dengan tarikan yang lembut pada tiap jarinya.



Gambar 4.3

d) Titik tekan

Tekan – tekanlah kedua ibu jari secara bersamaan di seluruh permukaan telapak kaki dari arah tumit ke jari – jari



Gambar 4.4

e) Punggung kaki

Dengan mempergunakan kedua ibu jari secara bergantian pijatlah punggung kaki secara bergantian



Gambar 4.5

f) Gerakan menggulung

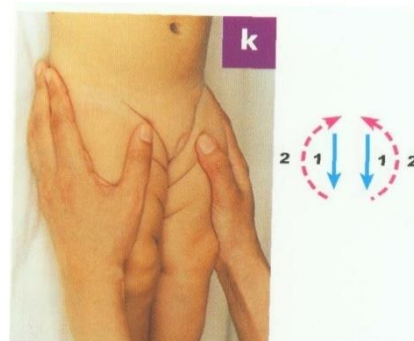
Pegang pangkal paha dengan kedua tangan anda, selanjutnya buatlah gerakan menggulug dari pangkal paha menuju pangkal kaki



Gambar 4.6

g) Gerakan akhir

Setelah gerakan 1 – 6 dilakukan pada kaki kanan dan kiri, rapatkan kedua kaki bayi. Letakan kedua tangan bersamaan pada pantat dan pangkal paha. Usap kedua kaki bayi dengan tekanan lembut dari paha kearah pergelangan kaki.

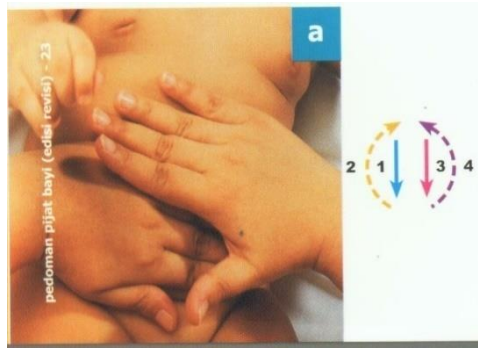


Gambar 4.7

2) Perut

a) Mengayuh sepeda

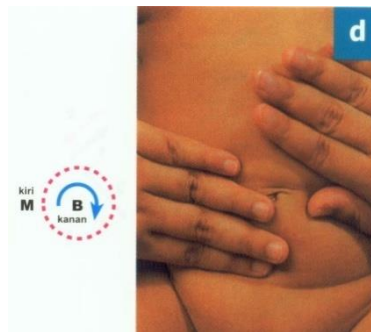
Lakukan gerakan memijat pada perut bayi seperti mengayuh pedal sepeda dari atas ke bawah perut bergantian dengan tangan kanan dan kiri.



Gambar 4.8

b) Matahari

Buatlah lingkaran searah jarum jam dengan jari tangan kiri mulai dari perut sebelah kanan bawah keatas, kemudian kembali ke daerah kanan bawah seolah membentuk gambar matahari



Gambar 4.9

c) Gerakan “I love You”

“I” pijatlah perut bayi mulai dari bagian kiri ke atas ke bawah dengan menggunakan jari – jari tangan kanan membentuk huruf “I”

“Love” pijatlah perut bayi membentuk huruf “L” terbaik mulai dari kanan atas kekiri atas, kemudian dari kiri atas ke kiri bawah

“You” pijatlah perut bayi membentuk huruf “U” terbalik, mulai dari kanan bawah ke atas kemudian kekiri bawah dan berakhir di perut bawah



Gambar 4.10

3) Dada

a) Jantung besar

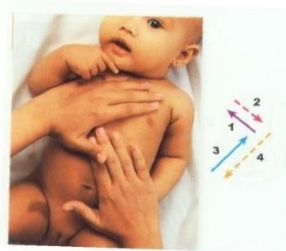
Buatlah gerakan yang menggambarkan jantung dengan meletakkan ujung jari kedua telapak tangan anda di dada bayi/ ulu hati, selanjutnya buat gerakan keatas sampai kebawah leher, kemudian kesamping diatas tulang selangka lalu ke bawah membentuk jantung dan kembali keulu hati



Gambar 4.11

b) Kupu – kupu

Buatlah gerakan diagonal seperti gambar kupu – kupu, dimulai dengan tangan kanan membuat gerakan memijat menyilang dari tengah dada kearah bahu kanan, dan kembali ke ulu hati. Selanjutnya gerakan tangan kiri anda ke bahu kiri dan kembali ke ulu hati



Gambar 4.12

4) Tangan

a) Perahan cara India



Gambar 4.13

b) Punggung tangan

Letakan tangan kanan bayi diantara kedua telapak tangan anda, selanjutnya usap punggung tangan nya dari pergelangan tangan kearah jari – jari dengan lembut



Gambar 4.14

5) Muka

a) Dahi : Menyetrika dahi

Letakan jari – jari kedua tangan anda pada pertengahan dahi, tekankan jari – jari anda dengan lembut mulai dari tengah dahi keluar kesamping kanan dan kiri seolah menyetrika dahi atau membuka lembaran buku kemudian gerakan kearah pelipis, kemudian gerakan ke dalam melalui daerah pipi di bawah



Gambar 4.15

6) Belakang telinga

Dengan mempergunakan ujung jari – jari berikan tekanan lembut pada daerah belakang telinga kanan dan kiri, selanjutnya gerakan kearah pertengahan dagu di bawah dagu.

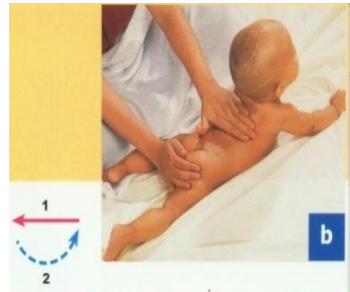


Gambar 4.16

7) Punggung

a) Gerakan maju mundur

Tengkurapkan bayi melintang di depan anda dengan kepala disebelah kiri dan kaki di sebelah kanan anda, selanjutnya pijatlah sepanjang punggung bayi dengan gerakan maju mundur menggunakan kedua telapak tangan dari bawah leher sampai ke pantat bayi lalu kembali ke leher



Gambar 4.17

b) Gerakan menyetrika

Pegang pantat bayi dengan tangan kanan, selanjutnya dengan tangan kiri, pijatlah mulai dari leher ke bawah sampai bertemu dengan tangan kanan yang menahan pantat bayi seolah menyetrika punggung

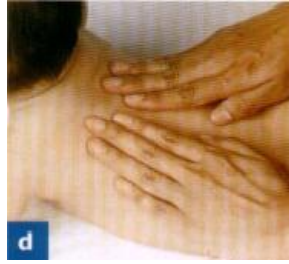


Gambar 4.18

c) Gerakan melingkar

Dengan jari – jari kedua tangan anda buatlah gerakan melingkar kecil – kecil mulai dari batas tengkuk turun ke bawah di sebelah kanan dan kiri tulang punggung sampai pantat, selanjutnya mulai dengan lingkaran – lingkaran kecil didaerah leher, kemudian lingkaran lebih besar didaerah pantat.

Setiap gerakan pada tahap pemijatan data di ulang sebanyak enam kali (Roesli, 2013).



Gambar 4.19

2. Senam Bayi (Baby Gym)

a. Definisi

Senam bayi adalah senam yang membantu merangsang pertumbuhan dan perkembangan optimal sistem saraf dan motorik bayi. Saat bayi bergerak, ikatan antara ibu dan bayi semakin kuat. Dengan baby training, Anda juga bisa mengetahui perkembangan bayi yang kurang baik sejak dini, sehingga dapat dilakukan tindakan proaktif yang diperlukan untuk memastikan bayi tumbuh normal. Senam bayi sangat penting untuk memperkuat otot dan persendian bayi karena mempersiapkan bayi untuk duduk, berdiri dan berjalan. Senam bayi didasarkan pada model perkembangan bayi (Julianti, 2017).

b. Manfaat Senam Bayi:

- 1) Merangsang pertumbuhan dan perkembangan, serta kemampuan pergerakan bayi yang lebih optimal.
- 2) Sebagai salah satu cara deteksi dini terhadap adanya kelainan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Deteksi yang dilakukan lebih dini merupakan tindak yang tepat untuk penanganan agar bayi tubuh dengan normal
- 3) Meningkatkan kemampuan intelegensia yang kompleks pada bayi termasuk belajar mengkoordinasi.
- 4) Memperkuat otot dan persendian pada bayi sebagai persiapan bayi untuk duduk, berdiri dan berjalan kelak.
- 5) Membuat tubuh bayi lebih bugar dan sehat.
- 6) Meningkatkan fleksibilitas atau daya kelenturan tubuh
- 7) Mengoptimalkan fungsi pendengaran, penglihat dan tumbuh kembang bayi.
- 8) Sentuhan yang diberikan orangtua ketika melakukan gerakan senam ini dapat mempererat ikatan kasih sayang antara orangtua dan bayi.
- 9) Melancarkan peredaran darah, menyehatkan jantung, dan meningkatkan koordinasi, keseimbangan dan kewaspadaan.
- 10) Meningkatkan perkembangan sensorik dan motorik bayi.
- 11) Meningkatkan kekebalan tubuh (Riksani, 2013).

c. Cara Melakukan *Baby Gym*

Berikut ini adalah contoh gerakan *baby gym* yang dilakukan pada bayi usia 3 bulan:

- 1) Peganglah tangan bayi, kemudian rentangkan lengan kanan kirinya setinggi bahu.
- 2) Gerakkan kedua lengan bayi ke atas kepala, lalu kembali ke posisi semula
- 3) Gerakkan kedua lengan ke samping badan, lalu kembali ke posisi semula.
- 4) Gerakkan lengan menyilang di depan tubuh, lalu kembali ke posisi semula.
- 5) Tekuk kedua tungkai bayi ke arah perut secara bersamaan, rentangkan kembali ke posisi awal.
- 6) Tekuk kedua tungkai bayi secara bergantian seperti gerakan mengayuh, lalu kembali ke posisi awal.
- 7) Tekuk kedua tungkai bayi kemudian putar pahanya ke arah luar, ke dalam, lalu kembali ke posisi awal.
- 8) Pertemukan kedua telapak kaki ke depan perut, lalu goyangkan ke kiri dan ke kanan.
- 9) Ulangi setiap gerakan di atas sebanyak 4 kali.

3. Baby swim (Renang)

a. Definisi

Berenang merupakan olahraga pertama yang aman untuk bayi, karena bayi sudah terbiasa berenang di dalam cairan ketuban sebelum sembilan bulan dalam kandungan. Makanan bayi memberikan rasa aman, nyaman dan hangat pada bayi. Oleh karena itu, sejak lahir, bayi Anda memiliki kemampuan naluriah untuk bergerak di dalam air dan tidak takut.

b. Manfaat berenang bagi bayi

- 1) Menghilangkan rasa takut pada air.
- 2) Meningkatkan pertumbuhan fisik, emosional, dan sosial sejak bayi.
- 3) Sarana bermain yang menyenangkan.
- 4) Menciptakan bonding (ikatan kasih sayang) antara orangtua dan anak.
- 5) Membantu pertumbuhan otot bayi.
- 6) Meningkatkan daya tahan tubuh sehingga terhindar dari berbagai penyakit.
- 7) Mengasah life skill meliputi keberanian, kemandirian, dan rasa percaya diri.
- 8) Mengurangi ketakutan terhadap olahraga air saat dewasa nantinya.
- 9) Membangun sistem saraf, membuat bayi mudah untuk tidur dan juga menambah nafsu makan. (Riksani, 2013).

c. Tahap-tahap renang

- 1) Pasangkan *neck ring* atau pelampung leher pada si kecil sebelum berenang.
- 2) Pastikan klip berada di belakang kepala dan dagu si kecil berada pada cekungan yang ada pada *neck ring*.
- 3) Masukkan si kecil perlahan-lahan ke dalam air. Gerakkan tangan dan kakinya di dalam air.
- 4) Biarkan si kecil berenang dan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya

d. Waktu yang tepat dilakukan Baby spa

- 1) Waktu yang tepat dalam melaksanakan baby spa
- 2) Usia minimal bayi untuk baby spa adalah 3-6 bulan karena diusia tersebut kepala bayi sudah kuat dan tegak.
- 3) Bayi sudah memiliki berat badan minimal 5 kg.
- 4) Bukan jam tidur bayi
- 5) Pemijatan dijadwalkan 1 jam setelah makan atau minum susu.
- 6) Bayi dalam kondisi sehat.
- 7) Jadwal baby spa bisa dilakukan seminggu sekali.

DAFTAR PUSTAKA

Galenia T. 2014. *Home Baby Spa*. Jakarta Timur: Penerbit Plus

Julianti.2021. *Rahasia Baby Spa: Sentuhan Cinta dan Kasih Sayang*. Depok: HM Books Pustaka

Riksani R. 2014. *Home Baby Spa*. Jakarta: Penebar Plus

Yahya N. 2011. *Spa Bayi dan Anak*. Jakarta: Metagraf.

BAB 5

DOKUMENTASI ASUHAN KEBIDANAN

PADA BAYI BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH

Mareza Yolanda Umar, S.ST., M. Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

**DOKUMENTASI ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BALITA
DAN ANAK PRA SEKOLAH**

Mareza Yolanda Umar, S.ST., M. Kes.

A. Konsep Dokumentasi

Dokumentasi kebidanan sangat penting bagi bidan dalam memberikan asuhan kebidanan. Hal ini karena asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien membutuhkan pencatatan dan pelaporan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menuntut tanggung jawab dan tanggung gugat dari berbagai permasalahan yang mungkin dialami oleh klien berkaitan dengan pelayanan yang diberikan. Selain sebagai sistem pencatatan dan pelaporan, dokumentasi kebidanan juga dipakai sebagai informasi tentang status kesehatan pasien pada semua kegiatan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh bidan. Disamping itu, dokumentasi berperan sebagai pengumpul, penyimpan, dan penyebarluasan informasi guna mempertahankan sejumlah fakta yang penting secara terus menerus pada suatu waktu terhadap sejumlah kejadian

Isi dan kegiatan dokumentasi apabila diterapkan dalam asuhan kebidanan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tulisan yang berisi komunikasi tentang kenyataan yang esensial untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi untuk suatu periode tertentu.
2. Menyiapkan dan memelihara kejadian-kejadian yang diperhitungkan melalui gambaran, catatan/dokumentasi.
3. Membuat catatan pasien yang otentik tentang kebutuhan asuhan kebidanan.
4. Memonitor catatan profesional dan data dari pasien, kegiatan perawatan, perkembangan pasien menjadi sehat atau sakit dan hasil asuhan kebidanan.
5. Melaksanakan kegiatan perawatan, mengurangi penderitaan dan perawatan pada pasien yang hampir meninggal dunia.

Dokumentasi mempunyai 2 sifat yaitu tertutup dan terbuka. Tertutup apabila di dalam berisi rahasia yang tidak pantas diperlihatkan, diungkapkan, dan disebarluaskan kepada masyarakat. Terbuka apabila dokumen tersebut selalu berinteraksi dengan lingkungannya yang menerima dan menghimpun informasi. Pendokumentasian dari asuhan kebidanan di rumah sakit dikenal dengan istilah rekam medik. Dokumentasi berisi dokumen/pencatatan yang memberi bukti dan kesaksian tentang sesuatu atau suatu pencatatan tentang sesuatu.

B. Konsep Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan merupakan proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya,

berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan yaitu meliputi bidang kesehatan ibu hamil, masa persalinan, nifas, bayi, balita dan anak prasekolah, serta keluarga berencana berdasarkan evidence based.

Dalam memberikan asuhannya bidan diharuskan untuk memperhatikan beberapa prinsip filosofi asuhan kebidanan sebagai berikut:

1. Memberdayakan perempuan (women empowering) dalam setiap asuhan diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh ibu, ibu dibantu untuk dapat mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk dirinya, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan social dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan agar ibu mendapatkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk menggunakan daya yang ibu miliki. Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan harapan agar perempuan mampu bertanggungjawab atas kesehatan diri mereka dan kesehatan keluarga.
2. Asuhan berkelanjutan (continuity of care) yaitu asuhan yang diberikan pada ibu dimulai sejak sebelum terjadinya kehamilan hingga usai masa nifas dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan, sesuai dengan keinginan ibu serta bidan tidak otoriter dan menghormati pilihan perempuan.
3. Women and family partnership merupakan saling bertukar pikiran, pengetahuan, sumberdaya dan komitmen antara bidan, ibu dan kepedulian keluarga ibu yang mendapatkan asuhan untuk mencapai tujuan bersama.
4. Women centre care adalah asuhan yang berpusat kepada perempuan dimana ibu sebagai membuat utama keputusan dalam asuhan dan ibu memiliki hak atas informasi yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam pengambilan keputusan yang mengutamakan interaksi antara ibu dan bidan.
5. Normal and natural childbirth adalah suatu keadaan dimana bidan berkeyakinan bahwa kehamilan dan persalinan merupakan suatu proses alamiah yang normal terjadi pada setiap wanita

C. Dokumentasi Asuhan Kebidanan pada Bayi, balita dan anak prasekolah

Asuhan kebidanan dapat dilakukan pada bayi dan balita. Bayi adalah individu yang berusia 0-12 bulan, sedangkan balita adalah individu yang berusia 12 hingga 60 bulan (1 sampai 5 tahun). Berdasarkan pertumbuhan dan perkembangannya balita dapat dikelompokkan menjadi usia toddler (1 sampai 3 tahun) dan usia pra sekolah (3 sampai 5 tahun).

Teknik penulisan dokumentasi asuhan kebidanan pada bayi dan balita

1. Pengkajian data subjektif

Data subjektif berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien. Ekspresi klien mengenai kekhawatiran dan keluhannya yang dicatat sebagai kutipan

langsung atau ringkasan yang akan berhubungan langsung dengan diagnosis. Data subjektif ini nantinya akan menguatkan diagnosis yang akan disusun.

Data subjektif didapatkan dengan anamnesis (wawancara) kepada orang tua bayi/balita (Ibu atau keluarga) yang meliputi:

- a) Biodata yang meliputi identitas balita dan orang tua.
- b) Keluhan utama atau masalah yang dihadapi balita berdasarkan sudut pandang orang tua.
- c) Riwayat kesehatan, baik riwayat kesehatan sekarang untuk mendeteksi penyakit yang diderita saat ini, maupun riwayat kesehatan lalu untuk mengetahui kemungkinan penyakit sebelumnya yang mempengaruhi kondisi kesehatan saat ini.
- d) Pola kesehatan sehari-hari
- e) Riwayat imunisasi

2. Pengkajian data objektif

Data objektif merupakan pendokumentasian hasil observasi yang jujur, hasil pemeriksaan fisik klien, hasil pemeriksaan laboratorium. Catatan medik dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimasukkan dalam data objektif ini sebagai data penunjang. Data ini akan memberikan bukti gejala klinis klien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosis.

Data objektif pada balita diolah dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan secara langsung oleh bidan dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki (head to toe) yang meliputi:

- a) Pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu frekuensi pernafasan, frekuensi denyut jantung dan suhu badan
- b) Pengukuran antropometri yang meliputi lingkaran kepala, lingkaran dada, lingkaran lengan, panjang badan dan berat badan
- c) Pemeriksaan fisik secara menyeluruh (head to toe) meliputi pemeriksaan muka (jika pucat dikhawatirkan bayi atau balita mengalami anemia), mata (Pemeriksaan sclera bertujuan untuk menilai warna, yang dalam keadaan normal berwarna putih. Sedangkan pemeriksaan konjungtiva dilakukan untuk mengkaji munculnya anemia. Konjungtiva yang normal berwarna merah muda), hidung (kebersihan hidung untuk mengobservasi fungsi sistem pernafasan pada bayi dan balita sudah berjalan dengan baik atau tidak), telinga (kebersihan telinga dan fungsi sistem pendengaran sudah baik atau tidak), mulut melihat caries pada balita, dan melihat pertumbuhan gigi bayi normal atau tidak), leher (memantau ada atau tidak pembesaran kelenjar tiroid), dada (melihat ada atau tidaknya tanda pneumonia pada bayi), perut (memeriksa terjadi defisiensi besi atau tidak), genitalia (memantau

perkembangan kelamin baik pada anak laki-laki dan pada anak perempuan) dan ekstremitas (melihat gerak kaki bayi dan balita)

d) Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk menunjang data objektif.

3. Menentukan Assesment

Langkah ini merupakan pendokumentasian hasil analisis dan intepretasi (kesimpulan) dari data subjektif dan objektif. Karena keadaan klien yang setiap saat bisa mengalami perubahan, dan akan ditemukan informasi baru dalam data subjektif maupun data objektif, maka proses pengkajian data akan menjadi sangat dinamis. Di dalam analisis menuntut bidan untuk sering melakukan analisis data yang dinamis tersebut dalam rangka mengikuti perkembangan klien. Analisis yang tepat dan akurat mengikuti perkembangan data klien akan menjamin cepat diketahuinya perubahan pada klien, dapat terus diikuti dan diambil keputusan/tindakan yang tepat. Analisis data adalah melakukan intepretasi data yang telah dikumpulkan, mencakup diagnosis, masalah kebidanan, dan kebutuhan. Hal ini dilanjutkan dengan antisipasi masalah tersebut, baik melalui konsultasi maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain.

4. Menentukan Penatalaksanaan

Penatalaksanaan adalah mencatat seluruh perencanaan dan penatalaksanaan yang sudah dilakukan seperti tindakan antisipatif, tindakan segera, tindakan secara komprehensif; penyuluhan, dukungan, kolaborasi, evaluasi/follow up dan rujukan. Tujuan penatalaksanaan untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien seoptimal mungkin dan mempertahankan kesejahteraanya. Bidan merencanakan asuhan sesuai dengan kelompok usia tumbuh kembang bayi, bidan harus memahami masa tumbuh kembang bayi dan balita. Bayi adalah individu yang berusia 0-12 bulan, usia toddler (1 sampai 3 tahun) dan usia pra sekolah (3 sampai 5 tahun).

D. Format Pengkajian Asuhan Kebidanan Pada Anak/balita

ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI /BALITA

Pada Anak.....Umur.....Dengan.....

Di.....

Tanggal Pengkajian :

Jam:

No Rekam Medis :

1) DATA SUBYEKTIF

1. Identitas

a. Bayi

Nama :

Tgl/jam lahir :

Jenis Kelamin :

b. Orang Tua

Nama Ibu : Nama Ayah :

Umur : :

Pendidikan : :

Pekerjaan : :

Suku Bangsa : :

Agama : :

Alamat : :

No Telp : :

2. Alasan datang ke RS/PMB/Puskesmas :

.....
.....
.....

3. Keluhan utama :

.....
.....
.....

4. Data Kesehatan

a. Riwayat kesehatan sekarang :

b. Riwayat penyakit dahulu

Penyakit yang pernah dialami :

Cacar () Pernah () Tidak Pernah

Polio () Pernah () Tidak Pernah

Difteri () Pernah () Tidak Pernah

Pertussis () Pernah () Tidak Pernah

Tetanus () Pernah () Tidak Pernah

Thypoid fever () Pernah () Tidak Pernah

TBC () Pernah () Tidak Pernah

Varicella () Pernah () Tidak Pernah
 Hepatitis () Pernah () Tidak Pernah
 Morbili () Pernah () Tidak Pernah
 Lainnya :
 Pernah dirawat di Rumah Sakit () Pernah () Tidak Pernah :

 Kecelakaan :
 Jenis obat yang digunakan :

c. Riwayat penyakit keluarga :

5. Data Imunisasi

NO	Jenis	Tanggal Penyuntikan			
		1	2	3	4
1.	Hepatitis B				
2.	BCG				
3.	DPT-HB-HiB				
4.	Polio				
5.	IPV				
6.	MR				

6. Riwayat pertumbuhan fisik

- a. Miring :
- b. Tengkurap :
- c. Merangkak :
- d. Tumbuh gigi pertama :
- e. Berdiri :
- f. Berjalan :

7. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari

- a. Pola nutrisi dan cairan
 - Pola makan :
 - Makanan pokok :
 - Makanan yang disukai :
 - Makanan yang tidak disukai :
 - Porsi :
 - Sayuran dan buah :
 - Minum :
 - Nafsu makan :
- b. Pola tidur :
- c. Pola eliminasi :

- d. Pola hygiene tubuh :
- e. Aktivitas :

2) Data Obyektif

1. Pemeriksaan Umum : () Baik, () Cukup, () Lemah
2. Tanda Vital :
 - Nadi :x/menit
 - Suhu :x/menit
 - Pernafasan :x/menit
 - () Teratur, () Tidak teratur
 - () Apnoe, () Cuping hidung
3. Antropometri
 - Berat badan :gram
 - PB :cm
 - LD :cm
 - LK :cm
 - LILA :cm
4. Pemeriksaan Fisik
 - a. Kepala : () Simetris, () Asimetris, () Pembesaran
 - Fontanela : () Normal, () Cekung, () Cembung
 - Mata : () Normal, () Strabismus
 - Telinga : () Simetris, () Asimetris, () Pengeluaran
 - Hidung : () Simetris, () Asimetris
 - Mulut : () Karies, () Stomatitis, () Trismus
 - () Perdarahan Gusi, () Bersih
 - b. Leher
 - Kelainan : () Ada, () Tidak ada
 - c. Dada
 - Bentuk : () Simetris, () Asimetris
 - Auskultasi jantung: () Vasikuler, () Whezing, () Ronkhi
 - Auskultasi Paru – paru : () S1 S2 tunggal () Mur-mur, () Gollap
 - d. Punggung :
 - e. Abdomen : () Supel, () Distended, () Meteorisme, () Flat
 - f. Kulit : () Kemerahan, () Biru, () Pucat, () Kuning,
 - () Odeme
 - () Kering, () Mengelupas, () Transparan
 - Turgor : () Baik, () Menurun, () Jelek
 - g. Ekstremitas

- Atas : () Normal, () Polidaktili, () Sindaktili
 Bawah : () Normal, () Polidaktili, () Sindaktili
 Tonus otot : () Baik, () Kurang, () Buruk
 Pergerakan : () Aktif, () Kurang, () Buruk
 Reflek patella : () Kanan (+/-), () Kiri (+/-)
 h. Anogenital :
 i. Genetalia
 Laki –laki : Penis:() Normal, () Kelainan, Jelaskan.....
 Testis:() Normal, () Kelainan,
 Uretra : () Normal, () Kelainan, Jelaskan.....
 Skrotum : () Normal, () Kelainan, Jelaskan.....
 Wanita : Labiya mayora: () Normal, () Kelainan,Jelaskan.
 Labiya Minora : () Normal, () Kelainan, Jelaskan.....

5. Pemeriksaan penunjang

- Haemoglobin :
 Golongan darah :
 Urine :

3) ASSESMENT

1. Merumuskan diagnosa/masalah kebidanan :.....
2. Mengantisipasi diagnose/masalah potensial :.....

4) PLANNING OF ACTION

1. Kebutuhan terhadap tindakan segera
2. Kolaborasi/rujukan Perencanaan
3. Pemberian imunisasi atau pengobatan MTBS/MTBM
4. KIE
5. Evaluasi
6. Kunjungan ulang

CATATAN PERKEMBANGAN

- Hari/Tanggal :
 Jam :
 S (Data Subjektif) :
 O (Data Objektif) :
 A (Analisis) :
 P (Penatalaksanaan) :

E. Format Pengkajian Asuhan Pada Tumbuh Kembang Balita

FORMULIR DETEKSI DINI PADA TUMBUH KEMBANG BAYI /BALITA

Pada Anak.....Umur.....Dengan.....

Di.....

Tanggal Pengkajian :

Jam:

No Rekam Medis :

1) DATA SUBYEKTIF

1. Identitas

a. Bayi

Nama :
Tgl/jam lahir :
Jenis Kelamin :
Umur anak :

b. Orang Tua

Nama Ibu	:	Nama Ayah	:
Umur	:		:
Pendidikan	:		:
Pekerjaan	:		:
Suku Bangsa	:		:
Agama	:		:
Alamat	:		:
No Telp	:		:

2. Alasan datang ke RS/PMB/Puskesmas :

.....
.....
.....

3. Keluhan utama :

.....
.....

4. Apakah anak mempunyai masalah tumbuh kembang :

.....
.....
.....

2) PEMERIKSAAN RUTIN SESUAI JADWAL

1. BB : kg: PB/TB : Cm BB/TB : a. Gizi Baik; b. Gizi Kurang; c. Gizi Buruk; d. Gizi Lebih; e. Rujuk : Ya/Tidak
2. LKA :Cm LKA/U : a. Normal; b. Mikrosefal; c. Makrosefal; d. Rujuk : Ya/Tidak
3. Perkembangan Anak :
 - a. Sesuai
 - b. Meragukan : b1. GK, b2 GH, b3. B-bahasa, b4. Sos. Kemandirian, b5. Rujuk : Ya/Tidak
 - c. Penyimpangan : c1. GK, c2 GH, c3. B-bahasa, c4. Sos. Kemandirian, c5. Rujuk : Ya/Tidak
4. Daya lihat : a. Normal; b. Curiga ada gangguan; c. Rujuk : Ya/Tidak
5. Daya dengar : a. Normal; b. Curiga ada gangguan; c. Rujuk : Ya/Tidak
6. Mental emosional : a. Normal; b. Curiga ada gangguan; c. Rujuk : Ya/Tidak

3) PEMERIKSAAN ATAS INDIKASI/JIKA ADA KELUHAN

1. Autis : a. Risiko tinggi; b. Risiko rendah; c. Gangguan lain; d. Batas Normal; e. Rujuk : Ya/Tidak
2. GPPH : a. Kemungkinan GPPH; b. Bukan GPPH; c. Rujuk : Ya/Tidak

4) KESIMPULAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5) TINDAKAN INTERVENSI

1. Konseling stimulasi bagi ibu: a. Diberikan; b. Tidak diberikan
2. Intervensi stimulasi perkembangan:
a. GK; b. GH; c. B-Bahasa; d. Sos. Kemandirian; e. Tgl evaluasi intervensi :
.....
3. Tindakan Pengobatan :
4. Dirujuk Ke : : a. ada surat rujukan; b. tidak ada surat rujukan

F. BUKU KIA DAN DOKUMENTASI PELAYANAN KIA

Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan salah satu dokumentasi pencatatan asuhan kebidanan yang mengakomodir kebutuhan hak ibu serta anak dan keluarganya, sehingga buku tersebut mencatat tentang kesehatan ibu dan anak serta pelayanan yang diberikan, kemudian disimpan oleh ibu atau keluarga.

Catatan yang dibuat pada buku KIA:

1. Catatan Kesehatan Ibu
2. Catatan Kesehatan Anak
3. Kartu Menuju Sehat (KMS)

Informasi yang ada tentang kesehatan anak tentang:

1. Perawatan bayi baru lahir sampai balita
2. Perawatan sehari-hari pada balita
3. Perawatan anak sakit
4. Cara pemberian makan anak
5. Cara merangsang perkembangan anak
6. Cara memberi makanan pengganti ASI (MP-ASI)

Catatan Perkembangan anak: Untuk memantau perkembangan dan pertumbuhan bayi dan balita dibuat KMS sampai anak berusia 5 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, Yusari, Risneni, 2016, Buku Ajar Dokumentasi Kebidanan, Jakarta : CV Trans Info Media
- Handayani, Sih Rini. Mulyati, Triwik, Sri, 2017. Dokumentasi Kebidanan. Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
- Indrayani, Djami, Moudy E. U, 2016, Update Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Jakarta : CV Trans Info Media
- Irianti, Bayu, Halida, Erda Mutiara, Duhita, Fitra, Et Al, 2014, Asuhan Kehamilan Berbasis Bukti Terkini, Jakarta : CV Sagung Seto
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang standar asuhan kebidanan
- Nurwiandani, Widy, 2018, Dokumentasi Asuhan Kebidanan, Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Setiyani, Astuti, Sukei, Esyuananik, 2017. Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah. Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
- Sukei, Setiyani, Astuti, Esyuananik, 2017. Praktikum Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah. Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

BAB 6

PEMERIKSAAN FISIK PADA BAYI, BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH

Erma Herdyana, M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

PEMERIKSAAN FISIK PADA BAYI, BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH*Erma Herdyana, M.Kes*

A. KONSEP PEMERIKSAAN FISIK**1. Definisi**

Pemeriksaan fisik merupakan metode yang dilakukan oleh petugas kesehatan secara menyeluruh mulai dari *head to toe* pada tubuh manusia untuk mendapatkan hasil pemeriksaan secara obyektif.

2. Tujuan

Pemeriksaan fisik memiliki 2 (dua) unsur tujuan, yaitu

a. Tujuan Umum

Tujuan Umum dilakukan pemeriksaan fisik yaitu untuk mendapatkan informasi berdasarkan temuan secara obyektif kondisi status kesehatan pasien/seseorang

b. Tujuan Definitif

Pemeriksaan Fisik pada manusia memiliki tujuan definitif mendapatkan potensial kemungkinan masalah atau mengetahui kondisi kesehatan seseorang ngan atau tanpa gejala apapun melalui serangkaian tekhnik (metode) untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit yang dilakukan pada manusia dengan kondisi sehat maupun sakit berdasarkan keluhan atau temuan secara obyektif yang didokumentasikan oleh pemeriksa dan selanjutnya sebagai catatan rekam medik seseorang tersebut sebagai temuan data awal yang akan dapat diperbaharui pada pemeriksaan fisik selanjutnya apabila terdapat adanya keluhan lainnya.

3. Manfaat

Pemeriksaan Fisik yang dilakukan pada Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah diharapkan mendapatkan beberapa manfaat diantaranya:

- a. Sebagai data obyektif pendukung berdasarkan informasi data subyektif sebelumnya melalui pengkajian
- b. Mendapatkan hasil temuan secara akurat
- c. Sebagai skrining/penapisan terhadap suatu tindakan selanjutnya
- d. Sebagai evaluasi, pengawasan/pemantauan kondisi Bayi/Balita/Anak Pra Sekolah

4. Tahapan/Metode Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan Fisik secara prinsip dilakukan dengan tahapan umum dan tahapan khusus. Tahapan Umum Pemeriksaan Fisik dan Tahapan Khusus Pemeriksaan Khusus, dengan uraian pada masing-masing tahapan tersebut dimaksud yaitu:

- a. Tahapan Umum Pemeriksaan Fisik:

- 1) Persiapan Alat
Persiapan alat dimaksud adalah beberapa peralatan yang digunakan dalam pemeriksaan pada Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah
 - 2) Persiapan Pasien
Persiapan pasien yang perlu dilakukan yaitu mempersiapkan Bayi/Balita/Anak Pra Sekolah pada bed/tempat tidur atau digendong menyesuaikan dengan kondisi pasien yang akan diperiksa dengan tujuan mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat
 - 3) Persiapan Pemeriksa
Pemeriksa melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan pada Bayi/Balita/Anak Pra Sekolah dengan Tindakan cuci tangan terlebih dahulu sebelum memegang pasien
 - 4) Persiapan Lingkungan
Lingkungan dalam kegiatan pemeriksaan fisik yang dilakukan pada Bayi/balita/Anak Pra Sekolah menyesuaikan dengan kondisi pasien, dalam hal ini ketika anak rewel atau kurang kooperatif pada saat dilakukan pemeriksaan fisik
 - 5) Teknik Pemeriksaan
Teknik Pemeriksaan pada Bayi/balita/Anak Pra Sekolah dilakukan dengan cara *head to toe* (dari kepala sampai kaki) dengan menggunakan bantuan alat tertentu sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan
- b. Tahapan Khusus Pemeriksaan Fisik:
- 1) Inspeksi (melihat)
Inspeksi merupakan bagian metode pemeriksaan fisik pada bayi/balita/Anak Pra Sekolah dengan melihat/memperhatikan/mengamati/mengingat secara keseluruhan kondisi tubuh pasien pada saat melakukan pemeriksaan.
Hasil pemeriksaan dari inspeksi dapat disimpulkan sebagai berikut:
Kesan umum, warna, bentuk dan ukuran pada setiap bagian tubuh yang Nampak/terlihat pada saat pemeriksaan. Memperhatikan kesan umum bayi/balita/anak pra sekolah, beberapa contoh diantaranya yaitu dengan kondisi rewel, menangis, kesakitan atau cara jalan apabila anak sudah bisa berjalan. Sedangkan pada warna – warna bagian tubuh yang terlihat dan perlu diperhatikan mulai *head to toe* seperti warna kulit, warna mata, sklera, pucat, sianosis dan lain – lainnya. Bentuk pada tubuh yang dilihat adalah Nampak gemuk, kurus atau bentuk pada bagian tubuh tertentu sesuai kondisi saat temuan. Ukuran anggota badan dengan melihat perbandingan, seperti perbandingan pada bagian

ukuran kepala dengan Panjang badan atau temuan lain pada bagian dada yang abnormal pada saat menarik nafas.

2) Palpasi (meraba)

Metode palpasi dengan menggunakan jari dan tangan meraba pada bagian tubuh bayi/balita/anak pra sekolah yang diperiksa dengan sense posisi (*proprioception*). Beberapa aspek yang menjadi deskripsi hasil pemeriksaan dengan palpasi antara lain: pada permukaan tubuh dirasakan kasar/halus, adanya benjolan, atau teraba lunak/keras, sedangkan teraba getaran akan terasa denyutan seperti denyut nadi, serta teraba bagian/organ tubuh dibawah permukaan yaitu teraba pembesaran massa, atau Batasan hepar, tulang rusuk pada dada dan organ lainnya. Pada saat meraba diusahakan secara langsung meraba pada bagian permukaan tubuh atau tanpa ada sesuatu yang menghalangi/mengurangi hasil pemeriksaan.

3) Perkusi (mengetuk)

Pemeriksaan perkusi adalah melakukan pemeriksaan pada bagian tubuh dengan menggunakan jari tangan (jari tengah tangan kiri yang diletakkan pada permukaan tubuh dan telunjuk atau jari tengah kanan diketukkan pada jari tengah kiri) untuk mendapatkan hasil pemeriksaan 5 (lima) nada suara kualitas dasar, yaitu nada suara pekak, redup, sonor, hipersonor, dan timpani. Adapun yang dimaksud dengan nada suara:

- a) Pekak adalah pada pemeriksaan bagian tubuh paha yaitu dihasilkan massa padat
- b) Redup, seperti suara perkusi yang dihasilkan dari organ hati
- c) Sonor, dihasilkan dari organ paru temuan normal
- d) Hipersonor, seperti temuan abnormal pada bagian paru dengan emfisema
- e) Timpani, seperti melakukan pengembungan pada pipi kemudian dilakukan perkusi maka akan terdengar suara

4) Auskultasi (mendengar)

Auskultasi adalah melakukan pemeriksaan pada bagian tubuh tertentu seperti dengan menggunakan bantuan alat yaitu stetoskop. Pada auskultasi akan terdengar temuan suara dari jantung, pembuluh darah dan paru dan usus yaitu suara secara kualitatif dan kuantitatif.

B. KONSEP BAYI, BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH

1. Definisi

a. Konsep Bayi

Masa bayi merupakan periode adaptasi mulai usia 1 – 12 bulan yang mengalami perubahan fisik dan perkembangan dengan cepat dalam proses adaptasi terhadap lingkungan.

b. Konsep Balita

Masa Balita merupakan periode usia 0 – 59 bulan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang begitu cepat yang diiringi dengan pemenuhan asupan nutrisi

c. Konsep Anak Pra Sekolah

Anak Pra Sekolah adalah masa dengan pertumbuhan dan perkembangan masa *golden age* atau masa kekhawatiran/kecemasan pada masanya.

2. Batasan

a. Usia Bayi

Usia Bayi merupakan rentang 1– 12 bulan

b. Usia Balita

Balita merupakan singkatan umum dengan kepanjangan bawah lima tahun dengan pembagian rentang usia 1 – 2 tahun biasa disingkat dengan batita dan usia 3 – 5 tahun dengan sebutan anak pra sekolah, dalam hal ini usia balita secara keseluruhan yaitu dengan periode rentang usia 0 – 59 bulan

c. Usia Anak Pra Sekolah

Usia anak pra sekolah dengan penjabaran usia 3 – 5 tahun

C. PEMERIKSAAN FISIK PADA BAYI, BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH

1. Pemeriksaan Fisik Pada Bayi dan Balita

Pemeriksaan fisik pada bayi dilakukan mulai Bayi Baru Lahir (BBL) untuk menilai kondisi fisik pada bayi baru lahir, 24 jam setelah bayi lahir serta dilakukan pada saat bayi akan pulang.

Pemeriksaan fisik pada bayi dilakukan dengan teknik yaitu melepas baju bayi secara keseluruhan untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat. Pemeriksaan fisik yang dilakukan pada bayi dan balita dilakukan secara *head to toe* (kepala sampai kaki) dengan metode inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Berikut adalah rangkaian pemeriksaan fisik pada bayi dan balita:

a. Pemeriksaan Fisik secara Umum

Bayi dan Balita dalam hal pemeriksaan fisik secara umum diawali dengan pemeriksaan umum yaitu tanda – tanda vital, yang meliputi:

1) Suhu

Pemeriksaan suhu pada bayi dan balita bisa dilakukan dengan pemeriksaan melalui oral, axilla maupun rektal. Pada kondisi normal dilakukan pada axilla dengan menggunakan thermometer axilla untuk memastikan kondisi bayi/balita dalam keadaan hypothermia atau hyperthermia dengan batasan normal suhu adalah 36,5 – 37,5 °C

2) Denyut Jantung

- a) Secara normal denyut jantung normal pada bayi baru lahir dengan frekuensi 100 – 160 kali per menit, denyut jantung normal pada bayi
- b) Sedangkan pada balita dilakukan pemeriksaan nadi yaitu dilakukan pada saat balita pada kondisi tidur atau istirahat, dan pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan alat arloji sebagai perhitungan nadi. Berikut merupakan pengelompokan denyut nadi normal pada bayi dan balita saat kondisi bangun dan saat tidur.

Tabel 6.1. Denyut Nadi Bayi, Batita dan Balita menurut Usia (denyut/menit)

Usia	Saat Bangun	Saat Tidur
Bayi (1-12 bulan)	100 – 150	90 – 160
Batita (1-2 tahun)	100 – 110	80 – 120
Balita (3-5 tahun)	65 - 110	65 – 100

3) Pernafasan

- a) Hasil pemeriksaan pernafasan normal pada bayi dengan frekuensi 30 – 60 kali per menit dengan penghitungan selama 1 (satu) menit utuh
- b) Pernafasan normal pada Batita yaitu 20 – 30 kali per menit, dan pada Balita dengan frekuensi pernafasan normal yaitu 20 – 25 kali per menit

4) Tekanan Darah

Tekanan Darah normal yaitu tekanan sistolik dan diastolic pada bayi dan balita menurut usia dikelompokkan pada table berikut.

Tabel 6.2. Tekanan Darah Pada Bayi, Batita dan Balita menurut Usia

Usia	Sistolik	Diastolik
Bayi (1-12 bulan)	80 – 100	55 – 65
Batita (1-2 tahun)	90 – 105	55 – 70
Balita (3-5 tahun)	95 - 107	60 – 71

5) Status Kesadaran

Pada bayi dan balita dilakukan pemeriksaan secara kualitatif dan kuantitatif. Adapun yang dimaksud dengan pemeriksaan secara

kualitatif yaitu komposmentis, apatis, somnolen, sopor, delirium, koma. Sedangkan penilaian secara kuantitatif yaitu penilaian yang diukur dengan skala koma (Glasgow), yaitu Glasgow, Coma Scale atau disingkat G-C-S.

6) Status Gizi

Status gizi pada bayi dan balita dilakukan dengan indicator sebagai berikut:

- a) Berat Badan
- b) Panjang Badan
- c) Lingkar Kepala

Adapun cara mengukur status gizi dilakukan dengan menggunakan Grafik WHO 2006 (*Cut off Z Score*) atau Standar Deviasi (SD) yang dilakukan dengan cara:

- a) Status gizi bayi berdasarkan berat badan sesuai umur (BB/U)
Penilaian status gizi bayi berdasarkan BB/U, yaitu:
 - (1) Berat badan sangat kurang: kurang dari -3 SD
 - (2) Berat badan kurang: -3 SD sampai dengan kurang dari -2 SD
 - (3) Berat badan normal: -2 SD sampai dengan +1 SD
 - (4) Risiko berat badan lebih: lebih dari +1 SD
- b) Status gizi bayi berdasarkan Panjang badan sesuai umur (PB/U)
Penilaian status gizi bayi berdasarkan PB/U, yakni:
 - (1) Sangat pendek: kurang dari -3 SD
 - (2) Pendek: -3 SD sampai dengan kurang dari 2 SD
 - (3) Normal: -2 SD sampai dengan +3 SD
 - (4) Tinggi: lebih dari +3 SD
- c) Status gizi bayi berdasarkan Berat Badan sesuai Panjang Badan (BB/PB)
Penilaian status gizi bayi berdasarkan BB/PB, yakni:
 - (1) Gizi buruk: kurang dari -3 SD
 - (2) Gizi kurang: -3 SD sampai dengan kurang dari -2 SD
 - (3) Gizi baik: -2 SD sampai dengan +1 SD
 - (4) Berisiko gizi lebih: lebih dari +1 SD sampai dengan +2 SD
 - (5) Gizi lebih: lebih dari +2 SD sampai dengan +3 SD
 - (6) Obesitas: lebih dari +3 SD
- d) Status gizi bayi berdasarkan lingkar kepala
Pada penilaian lingkar kepala bayi, dilakukan untuk mengetahui perkembangan otak dan kepala bayi, dan berikut ini merupakan cara

untuk mengetahui status gizi menurut WHO menggunakan ukuran persentil, yaitu:

- (1) Ukuran lingkar kepala terlalu kecil (*mikrosefalus*): persentil < 2
- (2) Ukuran lingkar kepala normal: persentil ≥ 2 sampai < 98
- (3) Ukuran lingkar kepala terlalu besar (*makrosefalus*): ≥ 98

b. Pemeriksaan Fisik secara khusus

Pemeriksaan fisik secara khusus pada bayi dan balita secara *head to toe* adalah sebagai berikut:

- 1) Kulit, kuku, rambut dan kelenjar getah bening, pada pemeriksaan:
 - (a) Kulit, dilakukan untuk menilai warna, sianosis, ikterus, eksema, pucat, purpura, makula, papula, vesikula, pustula, ulkus, turgor kulit
 - (b) Pemeriksaan kuku, dilakukan dengan tujuan melakukan inspeksi terhadap warna, bentuk keadaan kuku
 - (c) Pemeriksaan rambut, dilakukan dengan tujuan menilai adanya warna, kelebatan, distribusi karakteristik rambut
 - (d) Pemeriksaan kelenjar getah bening, dilakukan dengan cara teknik palpasi di daerah, leher/inguinal yang lain
 - 2) Kepala dan leher, terdiri dari pemeriksaan Wajah, Mata, Telinga, Hidung, Mulut, Faring, Laring, Leher
 - 3) Dada, terdiri dari pemeriksaan payudara, paru dan jantung
 - 4) Abdomen, pemeriksaan dilakukan dengan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi
 - 5) Genetalia, dilakukan pemeriksaan genetalia pada laki – laki yaitu dengan cara melihat ukuran, bentuk testis, penis serta adanya kelainan serta pada genetalia perempuan dilakukan pemeriksaan epispadiaa, ataupun adanya kelainan
 - 6) Tulang belakang dan ekstremitas Atas dan bawah, dilakukan untuk mendeteksi kelainan tulang belakang
 - 7) Pemeriksaan neurologis, diantaranya melakukan pemeriksaan refleks, tanda meningeal, pemeriksaan kekuatan dan tonus otot
- c. Pemeriksaan fisik Antropometri, meliputi pengukuran lingkar kepala, lingkar dada

2. Pemeriksaan Fisik Pada Anak Pra Sekolah

Pada anak pra sekolah dilakukan pemeriksaan fisik dengan teknik

a. KEPALA

- 1) Bentuk kepala ; makrosefali atau mikrosefali
- 2) Tulang tengkorak :

- a) Anencefali : tidak ada tulang tengkorak
- b) Encefalokel : tidak menutupnya fontanel occipital
- c) Fontanel anterior menutup : 18 bulan
- d) Fontanel posterior : menutup 2 – 6 bulan
- e) Caput succedaneum : berisi serosa muncul 2 jam pertama dan hilang dalam 2 hari
- f) Cephal hematoma : berisi darah muncul 24 – 48 jam dan hilang 2 – 3 minggu
- 3) Rambut, distribusi rambut dan warna
Apabila rambut berwarna kuning dan mudah rontok merupakan indikasi adanya gangguan nutrisi
- 4) Ukuran lingkar kepala 33 – 34 atau <49 dan diukur dari bagian frontal ke bagian occipital
- b. MUKA
 - 1) Simetris kiri kanan
 - 2) Tes nervus 7 (facialis)
 - a) Sensoris : menggunakan air dingin atau air hangat pada daerah maksilla dan mandibula dan menyebutkan apa yang dirasakan
 - b) Motorik : pasien diinstruksikan mengerutkan dahi selanjutnya menutup mata dengan kuat dan jari - jari pemeriksa menahan kedua kelopak mata agar tetap terbuka
 - 3) Tes nervus 6 (trigeminus)
 - a) Sensorik : dilakukan dengan menyentuhkan kapas pada daerah wajah dan ditanyakan respon terhadap rasa sentuhan tersebut
 - b) Motorik : dengan memberikan instruksi kepada klien untuk mengunyah dan pemeriksa meraba otot maseter dan mandibula
- c. MATA
 - 1) Simetris kanan kiri
 - 2) Alis tumbuh mulai usia 2 - 3 bulan
 - 3) Kelopak mata :
 - a) Edema
 - b) Ptosis : celah pada kelopak mata menyempit yang disebabkan karena kelopak mata atas turun
 - c) Enof kelopak mata menyempit karena kelopak mata atas dan bawah tertarik kebelakang
 - d) Exoptalmus : pelebaran celah kelopak mata dikarenakan kelopak mata pada bagian atas dan bawah tertarik kebelakang
 - 4) Pemeriksaan nervus II (optikus), yaitu test konfrontasi dan ketajaman penglihatan, sebagai objek mempergunakan jari, dilakukan dengan

pemeriksa dan pasien duduk berhadapan, mata yang akan diperiksa berhadapan dengan mata pemeriksa yang biasanya berlawanan mata kiri dengan mata kanan, pada garis ketinggian yang sama, Jarak antara keduanya berkisar 60 – 100 cm, dilakukan dengan cara mata yang lain ditutup dan obyek mulai digerakkan oleh pemeriksa mulai dari samping telinga, dan apabila obyek sudah tidak terlihat oleh pemeriksa maka secara normal obyek tersebut dapat dilihat oleh pasien, dan anak diminta membaca atau diberikan Snellen Chart

- 5) Pemeriksaan nervus III (oculomotoris refleks cahaya), dilakukan dengan teknik:
 - a) Pen light dinyalakan mulai dari samping atau kemudian cahaya diarahkan pada salah satu pupil yang akan diperiksa maka akan ada reaksi miosis
 - b) Pupil isokor kiri atau kanan
- 6) Pemeriksaan nervus IV (Trochlearis) pergerakan bola mata, dilakukan dengan mengajurkan klien melihat ke atas dan ke bawah
- 7) Pemeriksaan nervus V (Trigeminal), dilakukan dengan mengajurkan klien untuk melihat ke kanan dan ke kiri
- 8) Pemeriksaan nervus VI (Abducens refleks kornea), dilakukan dengan mengajurkan klien untuk:
 - a) Tutup mata yang satu dengan penutup
 - b) Minta klien untuk melihat ke arah latero superior (mata yang tidak diperiksa)
 - c) Selanjutnya sentuhkan pilin kapas pada kornea, didapatkan respon refleks berupa kedipan kedua mata secara cepat
- 9) Glabellar refleks: mengetuk dahi diantara kedua mata dengan hasil positif bila tiap ketukan mengakibatkan kedua mata klien berkedip
- 10) Doll eye refleks : bayi dipalingkan dan mata akan ikut tapi hanya berfokus pada satu titik.

d. HIDUNG

- 1) Posisi hidung dilihat simetris kiri kanan
- 2) Nampak jembatan hidung, dan jika tidak ada diduga down syndrome
- 3) Cuping hidung masih keras pada umur < 40 hari
- 4) Pasase udara : dilakukan dengan menggunakan kapas dan diletakkan di depan hidung dan apabila bulu kapas bergerak berarti anak bernafas
- 5) Menggunakan speculum untuk melihat pembuluh darah mukosa, secret, polip atau deviasi septum
- 6) Pemeriksaan nervus I (Olfaktorik), dilakukan dengan cara menutup salah satu lubang hidung klien dan diberikan bau-bauan lalu klien diminta

untuk menyebutkan bau yang dicium dan tiap hidung diuji secara terpisah

e. MULUT

- 1) Bibir kering atau pecah – pecah
- 2) Periksa labio schisis
- 3) Periksa gigi dan gusi, adakah Nampak perdarahan atau
- 4) Pemeriksaan nervus X (Vagus), dilakukan dengan menekan lidah menggunakan spatel dan anjurkan klien mengucapkan C AD C dan perhatikan ovula apakah terangkat.
- 5) Pemeriksaan nervus VIII (facialis) sensoris, dilakukan dengan meneteskan bagian 2/3 bagian anterior lidah dengan rasa asin manis dan pahit kemudian menentukan yang dirasakan dan 1/3 bagian bagian belakang lidah untuk pemeriksaan nervus IX
- 6) Pemeriksaan nervus XI (Dipoglosus), dilakukan dengan meminta pasien menjulurkan lidah lurus lurus kemudian menarik dengan cepat dan diminta menggerakkan lidah ke kiri dan kekanan dan sementara itu pemeriksa melakukan palpasi pada kedua pipi untuk merasakan kekuatan lidah
- 7) Rooting refleksi : bayi akan mencari benda yang diletakkan disekitar mulut dan kemudian akan mengisapnya
- 8) Sucking refleksi

f. TELINGA

- 1) Simetris kiri dan kanan, dilakukan dengan daun telinga dilipat dan lama baru kembali keposisi semula menunjukkan tulang rawan masih lunak
- 2) Pemeriksaan tes nervus VIII (Acustikus), dilakukan menggesekkan rambut atau tes bisik
- 3) Mendengarkan garpu tala tes Rinne, Weber, Starter refleksi: tepuk tangan dekat telinga mata akan berkedip

g. LEHER

- 1) Lipatan leher 2 – 3 kali lipat lebih pendek dari orang dewasa, periksa arteri karotis, vena jugularis, raba tiroid : daerah tiroid ditekan dan pasien diminta untuk menelan dirasakan oleh tangan pemeriksa adakah pembesaran atau tidak
- 2) Tonick neck refleksi : kedua tangan ditarik kepala akan mengimbangi
- 3) Neck rigting refleksi : posisi terlentang kemudian tangan ditarik kebelakang pertama badan ikut berbalik diikuti dengan kepala
- 4) Pemeriksaan nervus XII (Asesoris), dilakukan dengan menganjurkan klien memalingkan kepala lalu diminta klien menghadap kedepan

pemeriksa memberi tekanan terhadap kepala sambil meraba otot sternokleidomastoideus

h. DADA

- 1) Bentuk dada simetris kiri dan kanan
- 2) Bentuk dada barrel anterior – posterior dan transversal hampir sama 1:1 dan dewasa 1: 2
- 3) Suara tracheal : pada daerah trachea intensitas tinggi ICS 2 1:1
- 4) Suara bronchial : pada percabangan bronchus pada saat udara masuk intensitas keras pada ICS 4-5 1:3
- 5) Suara broncho vesikuler : pada bronchus sebelum alveolus intensitas sedang ICS 5
- 6) Suara vesikuler : pada seluruh bagian lateral paru intensitas rendah 3:1
- 7) Wheezing terdengar pada saat inspirasi dan rales pada saat ekspirasi
- 8) Perkusi pada daerah paru suara yang ditimbulkan adalah sonor
- 9) Apeks Jantung pada mid klavikula kiri intercostals 6
- 10) Perkusi pada daerah jantung adalah pekak

i. ABDOMEN

- 1) Observasi distensi abdomen
- 2) Terdengar suara peristaltic usus
- 3) Palpasi pada daerah hati teraba 1 – 2 cm dibawah costa panjangnya pada garis media klavikula 6 – 12 cm
- 4) Palpasi pada daerah limpa pada kuadran kiri atas, perkusi pada daerah hati suara yang ditimbulkan adalah pekak, perkusi pada daerah lambung suara yang ditimbulkan adalah timpani
- 5) Refleks kremaster : gores pada abdomen mulai dari sisi lateral ke medial terlihat kontraksi

j. UNGGUNG

- 1) Raba tulang belakang adanya spina bifida okulta : ada lekukan pada lumbo sacral tanpa herniasi dan distribusi lanugo lebih banyak
- 2) Rib hump and Flank: dalam posisi bungkuk sikap tulang belakang rata simetris, scoliosis postuera, sedangkan siku asimetris atau bahu tinggi sebelah dan vertebra bengkok, scoliosis structural, skoliometer >40

k. TANGAN

- 1) Jumlah jari – jari polidaktili > 5 dan sindaktili jari – jari Bersatu
- 2) Ada anak kuku dikebawakan dan tidak patah kalau patah diduga kelainan nutrisi
- 3) Kuku klubbing finger <180 bila lebih 180 diduga kelainan system pernafasan

I. PELVIS

- 1) CDH: Test gluteal lipatan paha simetris kiri kanan
- 2) Ortholani test : lutut ditekuk sama tinggi atau tidak
- 3) Barlow test : kedua lutut ditekuk dan regangkan kesamping akan terdengar bunyi klik
- 4) Tredelenburg test : berdiri angkat satu kaki lihat posisi pelvis apakah simetris kiri dan kanan
- 5) Waddling gait : jalan seperti bebek
- 6) Thomas test : lutut kanan ditekuk dan dirapatkan kedada sakit dan lutut kiri akan terangkat

m. LUTUT

- 1) Ballotemen patella : tekan mendorong kuat akan menimbulkan bunyi klik jika ada cairan diantaranya mengurut kantong supra patella kebawah akan timbul tonjolan pada kedua sisi tibia jika ada cairan diduga ada atritis
- 2) Reflek patella dan hamstring

n. KAKI

- 1) Lipatan kaki apakah 1/3, 2/3 bagian seluruh telapak kaki
- 2) Talipes : kaki bengkok kedalam
- 3) Clubfoot : otot-otot kaki tidak sama Panjang dan kaki jatuh kedepan
- 4) Refleks Chaddock
- 5) Stapping refleks

o. PEMERIKSAAN SISTEM NEUROLOGIS

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Ayu Putri. (2017). Gizi dan Diet. Trans Info Media, Jakarta
- Belajar Kedokteran, (2016). Pemeriksaan Fisik Dasar. Diakses dari laman website: <https://ilmuwankedokteran.blogspot.com/2016/09/pemeriksaan-fisik-dasar-inspeksi.html>
- Medscape. (2018). Normal Vital Signs: Normal Vital Signs, Normal Heart Rate, Normal Respiratory Rate. Medscape. (<https://emedicine.medscape.com/article/2172054-overview>)
- Potter, P.A. and Perry, A.G. (2005). Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik. Edisi 4, Volume 1, Alih Bahasa, Asih, Y., dkk. EGC, Jakarta.
- Suparyanto. (2014). Pengertian Balita. Diakses dari laman website blog: <https://dr-suparyanto.blogspot.com/2014/03/pengertian-balita.html>

BAB 7

PERAWATAN BAYI DI RUMAH

Purwati, S.ST., MPH



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. PENDAHULUAN

Bayi baru lahir hingga usia 28 hari memiliki kondisi yang rentan terhadap infeksi yang diakibatkan oleh paparan virus dan kuman baik selama proses persalinan maupun lingkungan sekitarnya pada minggu-minggu pertama kehidupannya. Perawatan yang kurang tepat dapat menimbulkan gejala yang menyebabkan kesakitan bahkan kematian pada bayi. Hal ini berhubungan dengan pengetahuan orang tua tentang perawatan bayi saat dirumah, hasil penelitian menunjukkan pengetahuan ibu tentang perawatan bayi dirumah masih rendah (Rahmawati, 2017). Perawatan bayi membutuhkan peran orang tua untuk melakukan perawatan secara mandiri dirumah tanpa bergantung pada tenaga kesehatan sepenuhnya. Tenaga kesehatan berkewajiban untuk memberikan informasi dan pelatihan pada orang tua khususnya ibu untuk melakukan perawatan bayi secara mandiri. Perawatan secara mandiri bermanfaat untuk menjalin hubungan batin yang kuat antara ibu dan bayi, selain itu bayi dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal.

1. Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Di Rumah

Kebutuhan nutrisi pada bayi harus tercukupi untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan. Bayi baru lahir hanya membutuhkan ASI untuk memenuhi kebutuhannya. Bayi membutuhkan perhatian khusus terkait pemenuhan nutrisi, dimana hal yang paling penting adalah pemenuhan nutrisi ketika dirumah. Hal ini terkait tidak semua orang tua khususnya ibu paham tentang pemenuhan nutrisi bayinya (cari jurnal). Nutrisi terbaik pada bayi adalah ASI, dimana kebutuhan ASI pada setiap bayi berbeda (cari jurnal). Kenaikan volume ASI menyesuaikan dengan usia bayi dan frekuensi stimulasi pada payudara. ASI pada hari pertama pemberian adalah 60ml/kg berat badan dan akan bertambah terus hingga usia 4 bulan jumlah ASI yang dibutuhkan mencapai 200 ml/kg berat badan (komposisi dan volume ASI dibahas di bab tersendiri).

Pemberian ASI yang adekuat dan *on demand* akan merangsang produksi ASI semakin banyak, membantu involusi uteri serta terciptanya *bounding attachment* antara ibu dan bayi. Beberapa alasan pemberian ASI sangat dianjurkan adalah

- Kolostrom mengandung antibody yang dapat mencegah infeksi pada bayi
- Pemberian ASI dapat mencegah penyakit *gastroenteritis* (Frank, dkk, 2019; natalinta, 2019)
- Kandungan lemak dan protein dapat diserap dengan mudah oleh usus

- d. Mencegah obesitas (Ginting, 2020)
- e. Mencegah kejang karena hipokalsemia (jurnal)
- f. *Bounding attachment*
- g. Murah, tidak mengeluarkan biaya

Inisiasi menyusui dini (IMD) merupakan upaya pemberian ASI sedini mungkin pada bayi lahir normal. Bayi dengan kondisi sakit seperti prematuritas atau penyakit lain tidak dapat melakukan IMD. Tetapi ibu dapat memompa ASI dan diberikan pada bayi dengan memakai sendok. Hal ini dapat dilanjutkan di rumah untuk pemberian ASI dengan cara dipompa.

Salah satu alasan yang sering diungkapkan oleh ibu adalah ASI tidak keluar atau ASI tidak cukup sehingga banyak ibu gagal dalam melakukan ASI eksklusif. Mitos tentang ASI seringkali menjadi penyebab gagal pemberian ASI, diantaranya:

- a. Minum air putih yang banyak akan meningkatkan produksi ASI
- b. Sering makan akan meningkatkan produksi ASI
- c. ASI keluar sedikit sehingga menunda pemberian ASI hingga produksi ASI banyak dahulu
- d. Apa yang dimakan ibu akan mempengaruhi kandungan ASI ibu sehingga nutrisi yang dimakan ibu harus hati-hati
- e. Ibu sedang sakit tidak boleh menyusui
- f. Kualitas ASI dilihat dari encer tidaknya ASI
- g. Menyusui membuat payudara kendur
- h. Putting mendatar tidak dapat memberikan ASI

Penyebab terganggunya produksi ASI (Varney, 2008) adalah sebagai berikut

- a. Bayi menyusu tidak secara *on demand*
- b. Pemberian empeng pada bayi
- c. Pemberian susu formula
- d. Pemakaian BH yang terlalu ketat
- e. Pemakaian pelindung putting payudara
- f. Ibu tidak menyusui pada malam hari
- g. Let down yang buruk
- h. Bayi prematur atau dismatur
- i. Putting rata derajat 2 dan 3
- j. Pembedahan pada payudara
- k. Ibu perokok
- l. Ibu mengkonsumsi obat (pengobatan karena ibu sakit)
- m. Adanya masalah endokrin terutama gangguan tiroid pada ibu

Penatalaksanaan pemenuhan nutrisi pada bayi tidak lepas dari peran tenaga kesehatan khususnya bidan sebagai mitra paling dekat dengan ibu. Peran bidan pada pemenuhan nutrisi dirumah adalah memberikan informasi dan melatih ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif dan pemberian MPASI setelah bayi berusia 6 bulan. Keberhasilan menyusui tidak lepas dari bagaimana posisi yang nyaman pada waktu menyusui. Posisi yang tidak benar akan menyebabkan putting susu lecet sehingga mengganggu proses menyusui. Setiap ibu mempunyai posisi yang berbeda tergantung dari kenyamanan pada saat menyusui. Perlekatan dan kenyamanan dalam menyusui mempengaruhi pengeluaran ASI dan timbulnya trauma pada payudara. Posisi menyusui dan perlekatan merupakan faktor keberhasilan dalam menyusui, sehingga ibu perlu diberi informasi tentang posisi menyusui dan perlekatan yang benar. Beberapa Posisi menyusui yang dapat dilakukan oleh ibu menurut Pollard (2016) :

a. Posisi mendekap atau menggendong (*cradle position*)

Ibu pada posisi duduk tegak, siku ditekuk, kepala dan bahu bayi berada diatas lengan bagian bawah ibu, telapak tangan menopang pantat bayi.



Gambar 7.1

Sumber: <https://mamaschoice.id/article/6-posisi-menyusui-yang-benar/>

b. Posisi menggendong silang (*cross cradle*)

Bayi pada posisi digendong dengan kedua tangan dengan tangan menyilang.



Gambar 7.2

Sumber: <https://mamaschoice.id/article/6-posisi-menyusui-yang-benar/>

c. Posisi dibawah lengan (*underarm hold*)

Ibu pada posisi duduk tegak, bayi dipangku dengan menggunakan bantal, posisi kepala bayi pada payudara, badan dan tungkai bayi dibawah lengan ibu (posisi ibu mengapit badan bayi. Posisi ini baik untuk ibu dengan luka operasi sesar.



Gambar 7.3

Sumber : <https://kumparan.com/kumparanmom/tips-menyusui-5-posisi-yang-benar-dan-mudah-diikuti-1535708202423033786/full/gallery/1>

d. Berbaring menyamping/bersisihan

Ibu pada posisi tidur miring, kemudian bayi menghadap payudara, harus diperhatikan payudara tidak boleh menutupi jalan pernafasan bayi.



Gambar 7.4

Sumber: <https://mamaschoice.id/article/6-posisi-menyusui-yang-benar/>

e. Mengangkang

Posisi bayi duduk diatas pangkuan ibu menghadap ke payudara. Posisi ini baik untuk bayi dengan dislokasi pinggul.



Gambar 7.4

Sumber: <https://mamaschoice.id/article/6-posisi-menyusui-yang-benar/>

Menyusui berkaitan erat dengan reflek *rooting* dan *sucking*, dimana reflek tersebut merupakan awal dari pelekatan yang efektif. Perangsangan disekitar mulut bayi dapat dilakukan agar bayi membuka mulut lebar sehingga payudara dapat memenuhi mulut bayi. Tanda-tanda bayi menyusu dengan efektif (JNPK-KR, 2014; Unicef, 2022):

- a. Mulut bayi penuh dengan payudara, aerola masuk ke mulut bayi
- b. Saat bayi menghisap, ibu tidak merasakan sakit
- c. Menyusui memiliki irama sehingga butuh waktu yang lama pada saat bayi menghisap dan menelan
- d. Bayi terlihat puas setelah selesai menyusui dan bayi melepas sendiri payudara dari mulutnya sehingga puting ibu tidak terasa sakit.
- e. Terjadi penurunan 10% berat badan lahir pada minggu pertama kelahiran
- f. Akan terjadi kenaikan berat badan pada bulan pertama sebanyak kurang lebih 300 gram
- g. Buang air kecil minimal 6 kali sehari
- h. Setelah hari ke 3, feses berubah warna dari mekonium menjadi kuning.

Salah satu kendala pemberian ASI adalah pada ibu bekerja. Ibu, keluarga dan tempat kerja harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan ASI pada bayi. Penelitian menunjukkan bahwa ibu bekerja cenderung tidak memberikan ASI eksklusif (Timporok, 2018). Informasi yang sebaiknya diberikan pada ibu dan keluarga untuk perencanaan ibu bekerja agar dapat tetap memberikan ASI (Varney, 2008) sebagai berikut:

- a. Mengajukan perencanaan untuk bekerja jauh sebelum kelahiran
- b. Segera menyusui setelah kelahiran dan memfokuskan pada produksi ASI yang adekuat
- c. Perencanaan untuk pemberian ASI secara langsung selama bekerja atau memompa ASI selama bekerja
- d. Persiapan peralatan untuk memompa dan penyimpanan ASI baik di rumah dan di tempat kerja
- e. Mengajukan memakai pakaian kerja yang mudah untuk melakukan pemompaan ASI

Pada prinsipnya ibu bekerja tetap bisa menyusui bayinya setelah pulang dan pemberian ASI dengan sendok pada waktu ibu bekerja. Bidan dapat membantu ibu memahami bahwa ibu bekerja tetap bisa memberikan ASI selama 6 bulan tanpa diberikan makanan tambahan lain dan susu formula.

2. Menjaga Suhu Tubuh Bayi Di Rumah

Awal kehidupan bayi cenderung kehilangan panas, sehingga pemaparan udara yang berlebihan pada bayi harus dihindari. Suhu normal bayi diukur melalui rektal dan aksila berkisar 36,5°C-37,5°C (Varney, 2008). Pemakaian bedong berfungsi untuk menghangatkan bayi sebaiknya cukup longgar sehingga gerak bayi tidak terhambat ketika ada perubahan suhu tubuh dan penyesuaian postur (Myles, 2009). Pemakaian bedong tidak dianjurkan dilakukan secara terus

menerus dan sepanjang hari, karena dapat menghambat perkembangan motorik bayi (Solikhah, 2017). Penggunaan bedong sebagai penghangat dilakukan pada saat suhu lingkungan rendah dan segera di lepas jika suhu stabil.

Pemakaian baju pada bayi disesuaikan dengan suhu lingkungan untuk menghindari hipotermi dan segera mengganti pakaian yang basah. Perlu diperhatikan juga suhu air pada saat memandikan bayi yaitu 36°C. Suhu air dapat diukur dengan menggunakan punggung telapak tangan (hangat-hangat kuku) dan tidak terlalu lama dalam memandikan.

Informasi yang perlu disampaikan pada ibu dan keluarga bayi terkait menjaga kehangatan (JPNKR, 2014) :

- a. Bayi membutuhkan 1 tambahan kain untuk menjaga kehangatan
- b. Ruangan harus tetap hangat, khususnya jika udara dingin
- c. Menggunakan pakaian dan sepanjang hari
- d. Bayi pada malam hari tidur dengan ibu, sehingga lebih mudah untuk menyusui.

3. Kebutuhan Personal Hygiene Pada Bayi

a. Memandikan bayi

Memandikan bayi merupakan salah satu upaya untuk menjaga kebersihan dan mencegah dari infeksi. Memandikan memerlukan ketrampilan seorang ibu untuk melakukan sendiri di rumah. Sebagian besar ibu tidak berani melakukan sendiri, mereka meminta bantuan petugas kesehatan untuk memandikan bayi dikarenakan pengetahuan tentang personal hygiene pada ibu kurang (Wulandari, 2015). Tetapi sebaiknya tenaga kesehatan melatih ibu untuk melakukan sendiri sehingga tidak tergantung pada petugas kesehatan, selain itu memandikan bayi dapat mempererat hubungan ibu dan bayi secara batin melalui sentuhan.

Memandikan bayi dilakukan 2 kali sehari yaitu pagi dan sore hari. Sebaiknya menghindari memandikan bayi saat udara dingin untuk mencegah kehilangan panas pada bayi. Berikut cara memandikan bayi:

1) Persiapan peralatan mandi bayi

Peralatan memandikan bayi perlu disiapkan terlebih dahulu untuk memudahkan jangkauan dan menghindari meninggalkan bayi untuk mengambil peralatan mandi. Peralatan mandi yang disiapkan diantaranya:

- Set pakaian bayi, handuk, sabun, shampo, minyak kayu putih, washlap, bak mandi, air dingin dan air hangat.
- Bak mandi diisi air hangat dengan suhu kurang lebih 36°C atau hangat kuku, jika tidak ada termometer air, bisa menggunakan telapak tangan bagian punggung untuk memeriksa suhu air.

- Menyusun baju bersih bayi ditempat yang datar dan kering, untuk memudahkan memakaikan baju pada bayi. Handuk diletakan disamping baju bersih bayi.

2) Memandikan bayi

Meletakkan bayi ditempat yang datar, kemudian membuka pakaian bayi. Membersihkan mata dan telinga dengan menggunakan kapas dan air hangat. Membasahi badan bayi menggunakan washlap yang lembut, diseluruh badan bayi, kemudian menyabuni badan bayi, termasuk lipatan-lipatan badan bayi, tali pusat (jika belum lepas) dan alat kelamin.

Membilas badan bayi dengan memasukan ke dalam bak mandi. Menyangga kepala dan bahu dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang tungkai kaki, mengangkat secara perlahan.

Membilas bayi dengan cepat menggunakan tangan atau cangkir kecil untuk menyiram badan bayi.

Mengangkat bayi dari bak mandi kemudian meletakkan bayi di handuk kering. Mengeringkan badan bayi secara lembut dan memindahkan bayi diatas pakaian yang telah disusun.

b. Merawat tali pusat

Perawatan tali pusat yang benar perlu diinformasikan pada ibu dan keluarga, untuk mencegah infeksi. Keadaan tali pusat yang lembab akan memicu pertumbuhan bakteri yang menimbulkan infeksi pada tali pusat. Penggunaan popok sebaiknya tidak menutupi tali pusat, hal ini bertujuan untuk menghindari tali pusat basah saat terkena air seni. Jika tali pusat terkena air seni, segera membersihkan tali pusat dengan air bersih dan dikeringkan. Menjaga tali pusat agar tetap bersih dan kering akan mempercepat pelepasan tali pusat.

Ada berbagai metode perawatan tali pusat diantaranya dengan menggunakan alkohol, perawatan tali pusat terbuka dan perawatan tali pusat dengan menggunakan ASI. Perawatan tali pusat dengan menggunakan alkohol saat ini tidak dianjurkan karena tali pusat cenderung lembab. Keadaan lembab dapat menyebabkan berkumpulnya bakteri yang dapat menimbulkan infeksi pada tali pusat. WHO sejak tahun 1998 menganjurkan untuk melakukan perawatan tali pusat dengan metode kering dan terbuka yaitu tali pusat tidak ditutup kasa dan tidak dibubuhi apapun. Metode tersebut terbukti tali pusat lebih cepat kering dan lepas (Norhidayah dkk, 2015; Rostarina dkk, 2021).

Selain metode kering dan terbuka, berdasarkan beberapa hasil penelitian perawatan tali pusat dapat dilakukan dengan mengoleskan ASI pada tali pusat. Pemberian topikal ASI dapat mempercepat proses lepasnya tali pusat (Abbaszadeh, 2016; Rostarina, 2021; Wahyuni, 2022). Pemberian

ASI pada tali pusat hingga 2 hari setelah tali pusat lepas terbukti dapat mencegah omphalitis pada tali pusat dengan durasi pemberian 12 jam sekali (Taffazoli, 2008; Lyngdoh, 2012; Wahyuni, 2022). Kandungan ASI yang kaya protein, immunoglobulin dan kandungan anti infeksi dan inflamasi dapat mempercepat penyembuhan pada tali pusat.

Perawatan tali pusat dapat dilakukan dirumah dengan memperhatikan kebersihan tangan untuk mencegah infeksi. Tenaga kesehatan memberikan informasi tentang perawatan tali pusat pada ibu dengan langkah sebagai berikut melakukan cuci tangan 7 langkah, membasuh tali pusat dengan air hangat, kemudian mengeringkan dengan kasa kering. Mengoleskan ASI pada tali pusat, membiarkan terbuka, tali popok dianjurkan dibawah tali pusat. Jika tali pusat basah terkena air kencing, segera membersihkan dengan air hangat dan dikeringkan.

c. Perawatan kulit

Kulit bayi merupakan bagian yang sensitif dan rentan terjadi infeksi sehingga pencegahan infeksi harus ditingkatkan. Tenaga kesehatan memberikan informasi tentang perawatan kulit pada ibu sebagai berikut (Myles, 2009):

- 1) Mengurangi gesekan kulit dengan pakaian. Menyarankan pada ibu untuk pakaian bayi dari bahan yang lembut sehingga terhindar dari gesekan
- 2) Membersihkan dan mengeringkan lipatan organ tubuh, seperti lipatan selakangan, lipatan kaki dan ketiak.
- 3) Jika bayi BAK dan BAB segera membersihkan dengan air hangat dan dikeringkan, jangan menunda karena menyebabkan iritasi pada kulit
- 4) Membersihkan area pantat dan alat kelamin dengan 1 arah
- 5) Penggunaan bedak tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan infeksi, baik pada kulit maupun pernafasan
- 6) Penggunaan pelembut pakaian pada waktu mencuci pakaian bayi tidak dianjurkan

Masalah yang sering timbul ada kulit bayi salah satunya adalah ruam popok, hal ini terjadi karena reaksi kulit terhadap amonia yang terkandung dari air kencing bayi. Untuk mengatasi tersebut tenaga kesehatan sebaiknya menganjurkan untuk sering mengganti popok, membersihkan dengan air hangat kemudian mengeringkan kulit agar terhindar dari iritasi. Bayi dengan ruam popok sebaiknya sering membiarkan terbuka, agar kulit mendapat sirkulasi udara yang cukup. Jika iritasi berlanjut sebaiknya membawa bayi ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan.

4. Kebutuhan Pola Istirahat Pada Bayi

Pola istirahat erat hubungannya dengan perilaku bayi, dimana perilaku bayi dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu perilaku tidur dan terjaga (Varney, 2008). Perilaku terjaga pada bayi baru lahir rata-rata kurang lebih 15% dan 85% bayi berperilaku tidur (varney, 2008). Bayi baru lahir memerlukan waktu tidur selama kurang lebih 16-20 jam, bayi hingga 1 tahun selama 14-15 jam, Batita selama 12 jam dan usia pra sekolah selama 12 jam. Perilaku terjaga sebagian besar bayi menunjukkan rasa lapar, tidak nyaman dan keinginan lain yang diekspresikan melalui tangisan.

Perilaku tidur pada bayi baru lahir mendominasi diawal-awal kehidupannya dan akan semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Tidur pada bayi sangat penting untuk perkembangan otak. Pada keadaan tidur REM (tidur dalam fase dalam) merupakan waktu yang paling efektif untuk perkembangan otak. Jika perilaku tidur tidak tercukupi maka akan terjadi gangguan tidur pada anak dan hal ini sering menjadi keluhan bagi orang tua (Sekartini, 2015). Jika gangguan tidur ini tidak tertangani maka menimbulkan gangguan perkembangan pada bayi. Gangguan tidur pada bayi dapat diatasi dengan melakukan beberapa cara yaitu

- a. Membuat lingkungan disekitar bayi tenang dan nyaman,
- b. Bayi sebaiknya dalam keadaan kenyang
- c. Pijat bayi dapat meningkatkan kualitas tidur (Widiyani, 2021; Mindell, 2018)

Informasi tentang waktu tidur sangat penting disampaikan oleh tenaga kesehatan pada orang tua agar paham pola istirahat pada bayi. Sebaiknya bayi dibangunkan untuk menyusu jika dalam 2 jam bayi belum menunjukkan tanda-tanda terjaga. Pemberian ASI disela-sela waktu tidur juga perlu disampaikan agar kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi sehingga pertumbuhan dan perkembangan bayi optimal.

5. Tanda Bahaya Bayi

Deteksi dini tanda bahaya pada bayi baru lahir dilakukan oleh tenaga kesehatan sejak terjadinya persalinan. Pemeriksaan awal pada bayi baru lahir menggambarkan keadaan bayi saat ini dan kesehatan selanjutnya, dimana usia rentan bayi adalah 0-28 hari. Jika tanda bahaya lebih dini diketahui, harapannya dapat mencegah kesakitan dan kematian bayi yang diakibatkan oleh terlambatnya mengenali tanda bahaya dan terlambat membawa bayi ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan. Peran tenaga kesehatan khususnya bidan adalah memberikan informasi tentang tanda bahaya bayi

kepada orang tua, sehingga orang tua dapat mengenali keadaan yang menyimpang dan segera membawa bayi ke pelayanan kesehatan (Sukezi, 2022).

Informasi tentang tanda gejala bahaya pada bayi baru lahir perlu disampaikan pada orang tua terutama saat bayi sudah dipulangkan. Selain itu petugas kesehatan dapat melakukan kunjungan rumah untuk memantau kesehatan bayi. Tanda bahaya pada bayi (Varney, 2008; JNPKR, 2014) tersebut diantaranya:

- a. Bayi tidak mau menyusu dan memuntahkan isi perut
- b. Bayi mengalami kejang
- c. Bayi terlihat lemah dan hanya memberikan respon ketika dirangsang
- d. Pernafasan bayi cepat dan berat
- e. Bayi terdengar merintih
- f. Ketika bernafas terlihat adanya tarikan dada
- g. Suhu tubuh tinggi lebih dari $37,5^{\circ}\text{C}$ (demam)
- h. Suhu tubuh bayi kurang dari $36,5^{\circ}\text{C}$, badan terasa dingin (hipotermia)
- i. Kulit bayi berwarna kekuningan
- j. Mata terlihat merah dan kotor
- k. Bayi mengalami diare

DAFTAR PUSTAKA

- Abbaszadeh F, Hajizadeh Z, Jahangiri M. Comparing the Impact of Topical Application of Human Milk and Chlorhexidine on Cord Separation Time in Newborns. *Pak J Med Sci.* 2016 Jan-Feb;32(1):239-43. doi: 10.12669/pjms.321.8223. PMID: 27022383; PMCID: PMC4795877.
- Aghil Keykhosravi, Bita Barghamadi, Rozita Sabzevari, Mohammad Neamatshahi, Mahboubeh Neamatshahi. Knowledge, Attitude and Practice of Mothers about Exclusively Breastfeeding in Sabzevar in 2017. *Iranian Journal of Neonatology* 2019; 10(4)
- Armina Analinta. Hubungan antara Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian Diare pada Balita di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya 2017. Analinta. Open access under CC BY – SA license. Received: 18-10-2018, Accepted: 12-12-2018, Published online: 04-03-2019. doi: 10.20473/amnt.v3.i1.2019.13-17
- Arvin, Behrman Kligman. 2000. *Nelson Ilmu Kesehatan Anak Edisi 15 Volume 1*. Penerbit Buku Kedokteran. EGC: Jakarta
- Dian R, Delialika AM. Perawatan Bayi Baru Lahir (Bbl) Pada Ibu Usia Perkawinan Kurang Dari 18 Tahun (Di Wilayah Puskesmas Tiron Kabupaten Kediri. *Jurnal Kebidanan Dharma Husada* Vol. 6, No. 1 April 2017
- Dzul Istiqomah, Nurwinda Saputri. Pendidikan Kesehatan Tanda Bahaya Bayi Baru Lahir Sebagai Upaya Pencegahan Morbiditas Dan Mortalitas Pada Bayi Baru Lahir. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik* <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jpmt>
- Frank NM, Lynch KF, Uusitalo U, Yang J, Lönnrot M, Virtanen SM, Hyöty H, Norris JM; TEDDY Study Group. The relationship between breastfeeding and reported respiratory and gastrointestinal infection rates in young children. *BMC Pediatr.* 2019 Sep 18;19(1):339. doi: 10.1186/s12887-019-1693-2. PMID: 31533753; PMCID: PMC6749679.
- Ginting, L., & Besral, B. (2020). Pemberian Asi Eksklusif dapat Menurunkan Risiko Obesitas pada Anak Balita. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.15294/jppkmi.v1i1.41421>
- Hastuti P, Sumiyati, Rusmini, Riza A. Pelatihan Dan Pendampingan Perawatan Bayi Sehari-Hari Pada Tenaga Paraji (Dukun Bayi). *LINK*, 14 (1), 2018, 18 – 21. <http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/link>
- Hidayah N, Fitri W. Analisa Pengetahuan Ibu Nfas Terhadap Tanda Bahaya Bayi Baru Lahir. *Profesi*. Volume 14 No. 1. September 2016
- JNPK-KR. 2014. *Pelatihan Klinik Asuhan Persalinan Normal*. JNPK-KR Departemen Kesehatan RI: Jakarta

- Li Y, Zheng H, Li Y, Li W, Guo X, Lv Z. Parental knowledge of moisturizers and their application to infants with eczema in Hangzhou, China. *Medicine (Baltimore)*. 2020 May 29;99(22):e20329. doi: 10.1097/MD.00000000000020329. PMID: 32481406.
- LUBIS CP. Peranan Air Susu Ibu Dalam Mencegah Diare Dan Penyakit Usus Lainnya. ©2003 Digitized by USU digital library
- Lyngdoh D, Kaur S, Kumar P, Gautam V, Ghai S. Effect of topical application of human breast milk versus 4% chlorhexidine versus dry cord care on bacterial colonization and clinical outcomes of umbilical cord in preterm newborns. *J Clin Neonatol* 2018;7:25-30.
- Mahboubeh J, Roghaiyeh N, Aboulhassan D, Mohammad B, Leila V, Sevil H. Preterm Infant Breastfeeding Behavior Scale: A study for Assessing the Validity and Feasibility. *Iranian Journal of Neonatology* 2022; 13(3)
- Mahin T, Laia AF, Ashraf M, Habiballoh E, Kiyarash G. Dose Topical Application of Breast Milk Affect on Bacterial Colonization in Ubilical Cord. Published in *Majallah-í Ilmī-í Dānishgāh-í Ulūm-í Pizishkī-í Simnān Journal volume & issue* Vol. 10, no. 01pp. 29 – 35
- Mindell JA, Lee CI, Leichman ES, Rotella KN. Massage-based bedtime routine: impact on sleep and mood in infants and mothers. *Sleep Med*. 2018;41:51–7.
- Ni Nyoman Ayuk Widiani 1, Made Pradnyawati Chania2. EFEKTIVITAS BABY MASSAGE TERHADAP KUALITAS TIDUR BAYI USIA 3-6 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS II SUKAWATI TAHUN 2021. *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9 (1) Juni 2022 :29-33. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ANN/article/view/6348>. ISSN : ISSN 2442-4986
- Noorhidayah, Fakhriyah, Isnawati, M. Tazkiah. EFEKTIFITAS PERAWATAN TALI PUSAT TEKNIK KERING DAN TERBUKA TERHADAP LAMA PUPUT TALI PUSAT DI KOTA BANJARBARU. *Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol. 2 No. 1, April 2015
- Pollard, M. 2016. *Asi Asuhan Berbasis Bukti*. EGC. Jakarta.
- Rostarina N, Hadi M, Idriani. Efektivitas Perawatan Tali Pusat Dengan Metode Terbuka, Kolostrum dan ASI pada Bayi Baru Lahir Terhadap Lamanya Pelepasan Tali Pusat di Bidan Praktek Mandiri Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan* Vol 13 (1) ; Maret 2021 Hal : 64 – 72. p-ISSN: 2301-9255 e-ISSN: 2656-1190
- Sekartini, rini. Pola tidur pada anak. <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/pengasuhan-anak/pola-tidur-pada-anak>. Diakses 24 Desember 2022
- Simanungkalit HP, Yeni S. Perawatan Tali Pusat Dengan Topikal Asi Terhadap Lama Pelepasan Tali Pusat. *Jurnal Kebidanan* Vol 5, No 4, Oktober 2019 : 364-370

Sukeesi, Sri U, Rekawati S. Pemberdayaan Keluarga Dalam Deteksi Tanda Bahaya Bayi Baru Lahir Dengan Buku KIA. Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm), P-Issn: 2615- 0921 E-ISSN: 2622-6030 Volume 5 Nomor 9 September 2022] Hal 2927-2942

UNICEF. 2015. Breastfeeding after Returning to Work or Study. <https://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources/breastfeeding-resources/breastfeedingatstudyorwork/#:~:text=You%20don't%20need%20to,certain%20obligations%20towards%20breastfeeding%20women>. Diakses 13 Desember 2022

UNICEF. 2022. Off to the Best Start. A Guide To Help You Start Breastfeeding. [nhs.uk/better-health/start-for-life](https://www.nhs.uk/better-health/start-for-life)

Varney H, Jan MK, Carolyn LG. 2008. Buku Ajar Asuhan Kebidanan. Edisi 4. Vol 2. Penerbit Buku Kedokteran. EGC: Jakarta

Wahyuni, Nyimas S. Perawatan Tali Pusat Bayi Baru Lahir. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/58/perawatan-tali-pusat-bayi-barulahir#:~:text=Hasil%20penelitian%20menunjukkan%20bahwa%20perawatan,bakteri%20kolonisasi%20pada%20kedua%20kelompok. Akses 22 Desember 2022

Yunling Li, MDa, Huiwen Zheng, MDa, Yin Li, MMA, Wei Li, MMA, Xiaoxuan Guo, MMA, Zhongfa Lv, MDb,* Parental knowledge of moisturizers and their application to infants with eczema in Hangzhou, China. *Medicine* (2020) 99:2

BAB 8

ASUHAN LANGSUNG PADA BAYI BARU LAHIR

Siswati, S.SiT., M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. PENGERTIAN BAYI BARU LAHIR

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari usia kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat badan lahirnya 2500 gram sampai dengan 4000 gram, lahir langsung menangis, dan tidak ada kelainan kongenital (cacat bawaan) yang berat (Kosim, 2012).

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37 sampai 42 minggu dan berat badannya 2.500 sampai 4.000 gram. Saat dilahirkan, bayi baru lahir memiliki kompetensi perilaku dan kesiapan interaksi sosial. Periode neonatal yang berlangsung sejak bayi lahir sampai usia 28 hari merupakan waktu berlangsungnya perubahan fisik yang drastis. Transisi dari kehidupan di dalam kandungan ke kehidupan luar kandungan memerlukan kemampuan bayi dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan yang dialami (Bidan dan Dosen Kebidanan Indonesia, 2017).

B. FISILOGI BAYI BARU LAHIR

Menurut Sulistyawati dan Nugraheny (2010), adaptasi fisiologis yang terjadi pada bayi baru lahir di luar uterus, diantaranya:

1. Perubahan pernapasan

Pernapasan pertama pada bayi normal dalam waktu 30 menit pertama sesudah lahir. Usaha bayi pertama kali untuk mempertahankan tekanan alveoli, selain karena adanya surfaktan juga karena adanya tarikan napas dan pengeluaran napas dengan merintih sehingga udara bisa tertahan di dalam. Cara neonatus bernapas dengan cara bernapas diafragmatik dan abdominal, sedangkan untuk frekuensi dan dalamnya bernapas belum teratur. Apabila surfaktan berkurang, maka alveoli akan kolaps dan paru-paru kaku sehingga terjadi *atelektasis*.

2. Sirkulasi darah

Pada masa *fetus*, peredaran darah dimulai dari plasenta melalui vena umbilikalis lalu sebagian ke hati dan sebagian lainnya langsung ke serambi kiri jantung, kemudian ke bilik kiri jantung. Dari bilik kiri darah di pompa melalui aorta ke seluruh tubuh, sedangkan yang dari bilik kanan darah dipompa sebagian ke paru dan sebagian melalui *duktus arteriosus* aorta.

Sedangkan setelah bayi lahir, paru akan berkembang yang akan mengakibatkan tekanan arteriol dalam paru menurun yang diikuti dengan menurunnya tekanan pada jantung kanan. Kondisi ini menyebabkan tekanan

jantung kiri lebih besar dibandingkan dengan tekanan jantung kanan, sehingga menyebabkan *foramen ovale* menutup.

3. Perubahan termoregulasi

Setelah bayi lahir pengaturan suhu tubuhnya belum berfungsi secara sempurna, sehingga berisiko mengalami hipotermi. Empat mekanisme yang dapat menyebabkan bayi baru lahir kehilangan panas tubuhnya yaitu *konduksi*, *konveksi*, *radiasi* dan *evaporasi*.

4. Perubahan pada traktus digestivus

Pada BBL *traktus digestivus* mengandung zat berwarna hitam kehijauan yang terdiri dari mukopolisakarida atau disebut mekonium. Pengeluaran mekonium biasanya pada 10 jam pertama kehidupan.

C. CIRI-CIRI BAYI BARU LAHIR

1. Ciri-ciri Bayi Baru Lahir

Bayi baru lahir normal mempunyai ciri-ciri berat badan lahir 2500-4000 gram, umur kehamilan 37-40 minggu, bayi segera menangis, bergerak aktif, kulit kemerahan, menghisap ASI dengan baik, dan tidak ada cacat bawaan (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

Bayi baru lahir normal memiliki panjang badan 48-52 cm, lingkar dada 30-38 cm, lingkar lengan 11-12 cm, frekuensi denyut jantung 120-160 x/menit, pernapasan 40-60 x/menit, kulit kemerahan dan licin karena jaringan subkutan yang cukup, lanugo tidak terlihat dan rambut kepala tumbuh sempurna, kuku agak panjang dan lemas, nilai APGAR >7, gerakan aktif, bayi lahir langsung menangis, refleks-refleks sudah terbentuk dengan baik *rooting* (mencari putting susu dengan rangsangan taktil pada pipi dan daerah mulut), *sucking* (hisap dan menelan), *morro* (gerakan memeluk bila dikagetkan), *grasping* (menggenggam), organ genitalia pada bayi laki-laki testis sudah berada pada skrotum dan penis berlubang, pada bayi perempuan vagina dan uretra berlubang serta adanya labia minora dan mayora, mekonium sudah keluar dalam 24 jam pertama berwarna hitam kecoklatan (Dewi, 2010).

Menurut Dewi (2010), ciri-ciri bayi baru lahir normal, terdiri dari :

- 1) Lahir aterm antara 37-42 minggu
- 2) Berat badan 2500-4000 gram
- 3) Panjang badan 48-52 cm
- 4) Lingkar dada 30-38 cm
- 5) Lingkar lengan 11-12 cm
- 6) Frekwensi denyut jantung 120-160x/menit
- 7) Pernafasan $\pm$ 40-60x/menit
- 8) Kulit kemerahan dan licin karena jaringan subkutan yang cukup

- 9) Rambut lanugo tidak terlihat dan rambut kepala biasanya telah sempurna
- 10) Kuku agak panjang dan lemas
- 11) Nilai APGAR >7
- 12) Gerak aktif
- 13) Bayi lahir langsung menangis kuat
- 14) Reflek rooting (mencari putting susu dengan rangsangan taktil pada daerah pipi dan daerah mulut) sudah terbentuk dengan baik
- 15) Reflex sucking (isap dan menelan) sudah terbentuk dengan baik
- 16) Reflex moro (gerakan memeluk bila dikagetkan) sudah terbentuk dengan baik
- 17) Reflek grasping (menggenggam) sudah baik
- 18) Genetalia pada laki-laki ditandai dengan testis yang berada pada scrotum dan penis yang berlubang
- 19) Gentalia pada perempuan kematangan ditandai dengan vagina dan uretra yang berlubang, serta adanya labia mayora dan minora
- 20) Eliminasi baik yang ditandai dengan keluar nya mekonium dalam 24 jam pertama dan berwarna hitam dan kecoklatan

2. Tanda bayi sakit

Sesak napas, frekuensi pernapasan 60 kali/ menit, gerak retraksi di dada, malas minum, panas atau suhu badan bayi rendah, kurang aktif, berat lahir rendah (1500-2500 gram) dengan kesulitan minum (Prawiroharjo, 2009).

3. Tanda bayi sakit berat

Apabila terdapat salah satu atau lebih tanda-tanda yaitu sulit minum, sinosis sentral (lidah biru), perut kembung, periode apneu, kejang/ periode kejang-kejang kecil, merintih, perdarahan, sangat kuning, berat badan lahir < 1500 gram (Prawiroharjo, 2009).

D. KLASIFIKASI NEONATUS

Bayi baru lahir atau neonatus di bagi dalam beberapa kasifikasi menurut Marmi (2015) yaitu :

1. Neonatus menurut masa gestasinya :
 - a. Kurang bulan (*preterm infant*) : < 259 hari (37 minggu)
 - b. Cukup bulan (*term infant*) : 259-294 hari (37-42 minggu)
 - c. Lebih bulan (*postterm infant*) : > 294 hari (42 minggu atau lebih)
2. Neonatus menurut berat badan lahir :
 - a. Berat lahir rendah : < 2500 gram
 - b. Berat lahir cukup : 2500-4000 gram
 - c. Berat lahir lebih : > 4000 gram

3. Neonatus menurut berat lahir terhadap masa gestasi (masa gestasi dan ukuran berat lahir yang sesuai untuk masa kehamilan) :
 - a. Neonatus cukup/kurang/lebih bulan (NCB/NKB/NLB)
 - b. Sesuai/kecil/besar untuk masa kehamilan (SMK/KMK/BMK)

E. PEMERIKSAAN PENUNJANG

1. Penilaian bayi baru lahir dilakukan dengan menggunakan system nilai APGAR. Pembagian APGAR Score yaitu :
 - a. Nilai 1-3 : asfiksia berat
 - b. Nilai 4-6 : asfiksia sedang
 - c. Nilai 7-10 : asfiksia ringan (normal)

Tabel 8.1 Tanda APGAR

Skor	0	1	2	Angka
A: Appearance color (warna kulit).	Pucat	Badan Merah, ekstremitas biru	Seluruh tubuh kemerah-merahan	
P: Pulse (heart rate) (frekuensi denyut jantung)	Tidak ada	Kurang dari 100	Di atas 100	
G: Grimace (reaksi terhadap rangsangan)	Tidak ada	Sedikit gerakan mimic	Menangis, batu/ bersin	
A: Activity (tonus otot)	Lumpuh	Ekstremitas sedikit fleksi	Gerakan Aktif	
R: Respiration (usaha bernapas)	Tidak ada	Lemah, tidak teratur	Menangis kuat	
Jumlah				

Sumber: (Mochtar, 2011).

Menurut Manuaba (2014), dalam melakukan pertolongan persalinan merupakan kewajiban untuk melakukan :

- a. Pencatatan (jam dan tanggal kelahiran, jenis kelamin bayi, pemeriksaan tentang cacat bawaan).
- b. Identifikasi bayi (rawat gabung, identifikasi bayi sangat penting untuk menghindari bayi tertukar, gelang identitas tidak boleh dilepaskan sampai penyerahan bayi).
- c. Pemeriksaan ulang dan konsultasi dengan dokter anak. Pemeriksaan ulang setelah 24 jam pertama sangat penting dengan pertimbangan pemeriksaan saat lahir belum sempurna
- d. Penampilan Pada Bayi Baru Lahir

2. Pengukuran Antropometri

Macam-macam pengukuran antropometri yang dilakukan pada bayi baru lahir yaitu lingkaran kepala, lingkaran dada, panjang badan dan berat badan.

3. Penampilan Bayi Baru Lahir

- a. Kesadaran dan reaksi terhadap sekeliling : perlu dikurangi rangsangan terhadap reaksi rayuan, rangsangan sakit, atau suara keras yang mengejutkan atau suara mainan.
- b. Keaktifan : bayi normal melakukan gerakan-gerakan tangan yang simetris pada waktu bangun.
- c. Simetris : apakah secara keseluruhan badan seimbang
- d. Kepala : apakah terlihat simetris.
- e. Muka wajah : bayi tampak ekspresi.
- f. Mata : perhatikan kesimetrisan antara mata kanan dan kiri.
- g. Mulut : penampilannya harus simetris, mulut tidak mencucu seperti mulut ikan, tidak ada tanda-tanda kebiruan pada mulut bayi.
- h. Leher, dada, abdomen : melihat adanya cedera akibat persalinan, perhatikan ada tidaknya kelainan pada pernapasan bayi, karena biasanya bayi masih ada pernapasan perut.
- i. Punggung : adanya benjolan atau tumor atau tulang punggung dengan lekukan yang kurang sempurna .
- j. Kulit dan kuku : dalam keadaan normal kulit berwarna kemerahan.
- k. Kelancaran menghisap dan pencernaan : harus diperhatikan tinja dan kemih diharapkan keluar dalam 24 jam pertama.

(Rukiyah, 2010;h.3-5)

4. Reflek Pada Bayi Baru Lahir

a. Reflex moro

Reflek dimana bayi akan mengembangkan tangan lebar-lebar dan melebarkan jari-jari, lalu mengembalikan dengan tarikan yang cepat seakan-akan memeluk seseorang.

b. Reflex rooting

Reflek ini timbul karena rangsang taktil pipi dan daerah mulut. Bayi akan memutar kepala seolah mencari putting susu.

c. Reflex sucking

Reflek ini timbul bersama reflex rooting untuk menghisap putting susu dan menelan.

Hasil penelitian oleh Tauriska dan Umamah (2015) dengan judul “Hubungan Antara Isapan Bayi dengan Produksi ASI pada ibu menyusui di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya” menunjukkan hasil uji statistik bahwa $p=0,018$ dengan tingkat signifikan $\alpha=0,05$ berarti $p < \alpha$ maka dapat disimpulkan bahwa

semakin sering bayi menghisap payudara dengan benar, ASI semakin sering diproduksi. Gerakan isapan anak dapat mempengaruhi stimulus pada puting susu, dalam puting susu terdapat banyak ujung syaraf sensoris, bila dirangsang timbul impuls menuju hipotalamus selanjutnya ke kelenjar hipofise anterior (bagian depan) sehingga kelenjar ini menghasilkan hormon prolaktin. Rangsangan puting susu tidak hanya diteruskan sampai ke kelenjar hipofise anterior, tetapi juga ke kelenjar hipofise posterior (bagian belakang), yang menghasilkan hormon oksitosin. Salah satu usaha untuk memperbanyak ASI adalah dengan menyusui anak secara teratur. Semakin sering anak menghisap puting susu ibu, maka akan terjadi peningkatan produksi ASI dan sebaliknya jika anak berhenti menyusui maka terjadi penurunan ASI.

Hasil penelitian oleh Kuswinarno, Syahadatina dan Rahmayanti (2013) dengan judul “Inisiasi Menyusui Dini Dengan Refleks Menyusui Pada Bayi Baru Lahir” mekanisme terjadinya refleks menyusui pada bayi baru lahir dikarenakan bayi baru lahir mempunyai kemampuan indera yang luar biasa, terdiri dari penciuman terhadap bau khas ibunya setelah melahirkan, penglihatan, karena bayi baru mengenal pola hitam putih, bayi akan mengenali puting dan wilayah areola ibunya karena warna gelapnya.

d. Reflex batuk atau bersin

Reflex ini timbul untuk melindungi bayi

e. Reflex graps

Reflek yang timbul jika ibu jari di letakkan pada telapak tangan bayi, lalu bayi akan menutup telapak tangannya. Respon yang sama dapat di peroleh ketika telapak kaki di gores dekat ujung jari kaki menyebabkan ujung jari kaki menekuk.

f. Reflex walking dan stapping

Reflek yang timbul jika bayi dalam posisi berdiri akan ada gerakan spontan kaki melangkah ke depan walaupun bayi tersebut belum biasa berjalan.

g. Reflex tonic neck

Reflex yang timbul jika bayi mengangkat leher dan menoleh ke kanan atau kekiri jika di posisikan tengkurap. Reflex ini tidak dapat dilihat pada bayi yang berusia 1 hari. Reflex ini dapat di amati berusia 3-4 bulan.

h. Reflex babinsky

Reflex ini akan muncul bila ada rangsangan pada telapak kaki. Ibu jari akan bergerak keatas dan jari-jari lainnya membuka. Reflex ini biasanya menghilang setelah 1 tahun.

i. Membengkokkan badan (reflex galant)

Ketika bayi tengkurap, goresan pada punggung menyebabkan pelvis membengkok ke samping. Reflex ini berkurang pada usia 2-3 bulan.

j. Reflex baeur (merangkak)

Reflex akan terlihat pada bayi aterm dengan posisi bayi tengkurap. Bayi baru lahir akan melakukan gerakan merangkak dengan menggunakan lengan dan tungkainya. Reflex ini menghilang pada usia 6 minggu (Rohani, dkk. 2011;h.251-252).

F. TAHAPAN BAYI BARU LAHIR

1. Periode Pertama

Reaktivitas Periode pertama reaktivitas berakhir kira-kira 30 menit setelah kelahiran. Frekuensi nadi cepat dan tidak teratur. Frekuensi mencapai 80 kali/menit. Fluktuasi warna dari merah jambu pucat ke sianosis. Menangis kuat, refleks mengisap yang kuat.

2. Fase Tidur

Dimulai kira-kira 30 menit setelah periode pertama reaktivitas dan bisa berakhir sampai 2-4 jam. Frekuensi jantung dan pernapasan menurun. Kestabilan warna kulit; terdapat beberapa akrosianosis. Bising usus bisa didengar.

3. Periode Kedua Reaktivitas

Periode kedua reaktivitas berakhir sekitar 4-6 jam. Frekuensi nadi 120-160 kali/menit. Pernapasan berkisar dari 30 hingga 60 kali/menit. Warna kulit menjadi warna merah jambu atau kebiruan ke sianotik ringan disertai bercak. Bayi kerap kali berkemih dan mengeluarkan mekonium selama periode ini. Refleks pengisapan sangat kuat dan bayi bisa sangat aktif.

G. PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG TERJADI PADA BAYI BARU LAHIR

1. Perubahan pernafasan pada sistem pernafasan

Bayi cukup bulan mempunyai cairan di paru-parunya. Pada saat bayi melewati jalan lahir selama persalinan, sekitar sepertiga cairan ini diperas keluar dari paru-paru. Dengan beberapa kali tarikan napas yang pertama udara memenuhi ruangan trakea dan bronkus bayi. Sisa cairan di paru-paru dikeluarkan dari paru-paru dan diserap oleh pembuluh limfe dan darah. Peningkatan aliran darah paru-paru akan memperlancar pertukaran gas dalam alveolus dan akan membantu menghilangkan cairan paru-paru dan merangsang perubahan sirkulasi janin menjadi sirkulasi luar rahim.

Selama dalam uterus, janin mendapat oksigen dari pertukaran gas melalui placenta. Setelah bayi lahir harus melalui paru-paru bayi pernafasan pertama pada BBL terjadi normal dalam waktu 30 detik. Setelah kelahiran tekanan rongga dada bayi pada saat melalui jalan lahir pervagina mengakibatkan cairan paru-paru (pada bayi normal jumlahnya 80 – 100 ml). kehilangan 1/3 dari jumlah cairan tersebut sehingga cairan yang hilang ini diganti dengan udara. Pernafasan pada neonatus

terutama pernafasan diafragmatik dan abdominal dan biasanya masih tidak teratur frekwensi dan dalamnya pernafasan. Bayi umumnya segera menangis sekluarnya dari jalan lahir. Sebagai sebab-sebab yang menimbulkan pernafasan yang pertama, dikemukakan :

- a. Rangsangan pada kulit bayi.
- b. Tekanan pada thorax sebelum bayi lahir.
- c. Penimbunan CO₂

Setelah anak lahir kadar CO₂ dalam darah anak naik dan ini merupakan rangsangan pernafasan.

- d. Kekurangan O₂ Pernafasan intrauterin

Anak sudah mengadakan pergerakan pernafasan dalam rahim, malahan sudah menangis dalam rahim. Pernafasan di luar hanya merupakan lanjutan dari gerakan pernafasan di dalam rahim.

2. Perubahan metabolisme karbohidrat/glukosa

Fungsi otak memerlukan glukosa dalam jumlah tertentu. Dengan tindakan penjepitan tali pusat dengan klem pada saat lahir seorang bayi harus mulai mempertahankan kadar glukosa darahnya sendiri.

Pada setiap bayi baru lahir glukosa darah akan turun dalam waktu cepat (1-2 jam).

Koreksi penurunan gula darah dapat terjadi dengan 3 cara:

- a. Melalui penggunaan ASI (bayi baru lahir sehat harus didorong untuk menyusu ASI secepat mungkin setelah lahir).
- b. Melalui penggunaan cadangan glikogen (glikogenolisis).
- c. Melalui pembuatan glukosa dari sumber lain terutama lemak (glukoneogenesis).

3. Perubahan suhu tubuh

Bayi baru lahir belum dapat mengatur suhu tubuh mereka, sehingga akan mengalami stres dengan adanya perubahan-perubahan lingkungan. Bayi baru lahir dapat kehilangan panas melalui:

- a. Konduksi

Kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi permukaan yang dingin, misalnya meja, tempat tidur dan timbangan yang temperaturnya lebih rendah dari tubuh bayi akan menyerap panas tubuh bayi jika bayi diletakkan di atas benda-benda tersebut.

- b. Konveksi

Kehilangan panas tubuh terjadi saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin, misalnya ruangan yang dingin, adanya aliran udara dari kipas angin, hembusan udara melalui ventilasi atau pendingin ruangan.

c. Radiasi

Kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu tubuh lebih rendah dari suhu tubuh bayi, karena benda tersebut menyerap radiasi panas tubuh bayi (walaupun tidak bersentuhan secara langsung).

d. Evaporasi

Penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi sendiri karena setelah lahir, tubuh bayi tidak segera dikeringkan.

4. Perubahan pada sistem kardiovaskuler

a. Pada sistem kardiovaskuler harus terjadi 2 perubahan besar, yaitu:

- 1) Penutupan foramen ovale atrium jantung.
- 2) Penutupan duktus arteriosus antara arteri paru dan aorta.

b. Dua peristiwa yang mengubah tekanan dalam sistem pembuluh:

- 1) Pada saat tali pusat dipotong, resistensi pembuluh darah meningkat dan tekanan atrium kanan menurun. Tekanan atrium kanan menurun karena berkurangnya aliran darah ke atrium kanan yang mengurangi volume dan selanjutnya tekanannya. Kedua kejadian ini membantu darah dengan kandungan oksigen sedikit mengatur ke paru-paru untuk mengalami proses oksigenasi ulang.
- 2) Pernafasan pertama menurunkan resistensi pembuluh paru dan meningkatkan tekanan atrium kanan. Oksigen pada pernafasan pertama ini menimbulkan relaksasi dan terbakarnya sistem pembuluh baru. Dengan peningkatan tekanan pada atrium kiri foramen ovale secara fungsi akan menutup. Perubahan sistem gastrointestinal, ginjal.

c. Kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk menelan dan mencerna makanan masih terbatas, juga hubungan antara oesophagus bawah dan lambung masih belum sempurna yang mengakibatkan gumoh pada bayi baru lahir dan bayi muda. Kapasitas lambung sendiri sangat terbatas kurang dari 30 cc.

Feses pertama bayi adalah hitam kehijauan, tidak berbau, substansi yang kental disebut mekonium. Faeces ini mengandung sejumlah cairan amnion, verniks, sekresi saluran pencernaan, empedu, dan zat sisa dari jaringan tubuh. Pengeluaran ini akan berlangsung sampai hari ke 2-3. pada hari ke 4-5 warna tinja menjadi coklat kehijauan. Bila kandung kencing belum kosong pada waktu lahir, air kencing akan keluar dalam waktu 24 jam yang harus dicatat adalah kencing pertama, frekuensi kencing berikutnya, serta warnanya bila tidak kencing/menetes/perubahan warna kencing yang berlebihan.

d. Perubahan berat badan

Dalam hari-hari pertama berat badan akan turun oleh karena pengeluaran (meconium, urine, keringat) dan masuknya cairan belum mencukupi. Turunnya berat badan tidak lebih dari 10%. Berat badan akan naik lagi pada hari ke 4 sampai hari ke 10. Cairan yang diberikan pada hari 1 sebanyak 60 ml/kg BB setiap hari ditambah sehingga pada hari ke 14 dicapai 200 ml/kg BB sehari.

e. Sistem skeletal

Tulang-tulang neonatus lunak karena tulang tersebut sebagian besar terdiri dari kartilago yang hanya mengandung sejumlah kecil kalsium.

f. Sistem neoromuskular

Pada saat lahir otot bayi lambat dan lentur, otot-otot tersebut memiliki tonus kemampuan untuk berkontraksi ketika dirangsang, tetapi bayi kurang mempunyai kemampuan untuk mengontrolnya. Sistem persarafan bayi cukup berkembang untuk bertahan hidup tetapi belum terintegrasi secara sempurna.

H. PERIODE MASA TRANSISI BAYI BARU LAHIR

Setiap bayi baru lahir harus menyesuaikan diri dari kehidupan intra uterin ke kehidupan ektrauterin. Proses ini dapat berjalan lancar tetapi dapat juga terjadi berbagai hambatan, yang bila tidak segera diatasi dapat berakibat fatal.

Terdapat tiga periode dalam masa transisi bayi baru lahir:

1. Periode reaktivitas I : 30 menit pertama setelah lahir

Pada awal stadium ini aktivitas sistem saraf simpatik menonjol, yang ditandai oleh:

a. Sistem kardiovaskuler

- 1) Detak jantung cepat tetapi tidak teratur, suara jantung keras dan kuat.
- 2) Tali pusat masih berdenyut.
- 3) Warna kulit masih kebiru-biruan, yang diselingi warna merah waktu menangis.
- 4) Traktur respiratorrus
- 5) Pernafasan cepat dan dangkal.
- 6) Terdapat ronchi dalam paru.
- 7) Terlihat nafas cuping hidung, merintih dan terlihat penarikan pada dinding thorax.

b. Suhu tubuh : Suhu tubuh cepat turun.

c. Aktivitas

- 1) Mulai membuka mata dan melakukan gerakan eksplorasi.
- 2) Tonus otot meningkat dengan gerakan yang makin mantap.
- 3) Ektrimitas atas dalam keadaan fleksi erat dan ekstrimitas bawah dalam keadaan ekstensi.

- d. Fungsi usus
 - 1) Peristaltik usus semula tidak ada.
 - 2) Meconium biasanya sudah keluar waktu lahir.
2. Periode reaktifitas II : periode ini berlangsung 2 sampai 5 jam
 Pada periode ini bayi terbangun dari tidur yang nyenyak, sistem saraf otonom meningkat lagi. Periode ini ditandai dengan:
 - a. Kegiatan sistem saraf para simpatik dan simpatik bergantian secara teratur.
 - b. Bayi menjadi peka terhadap rangsangan dari dalam maupun dari luar.
 - c. Pernafasan terlihat tidak teratur kadang cepat dalam atau dangkal.
 - d. Detak jantung tidak teratur.
 - e. Reflek gag/gumoh aktif.
 - f. Periode ini berakhir ketika lendir pernafasan berkurang.
3. Periode III stabilisasi : periode ini berlangsung 12 sampai 24 jam
 Kedua pengkajian keadaan fisik tersebut untuk memastikan bayi dalam keadaan normal/mengalami penyimpangan.

I. BOUNDING ATTACHMENT

Bounding adalah proses pembentukan sedangkan attachment adalah membangun ikatan. Sehingga bounding attachment adalah sebuah ikatan hubungan kasih sayang dengan keterikatan batin antara orang tua dan bayi. Hal ini merupakan proses dimana sebagai hasil dari suatu interaksi terus menerus antara bayi dan orang tua yang bersifat saling mencintai memberikan keduanya pemenuhan emosional dan saling membutuhkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2013) dengan judul "Keberhasilan Bounding Attachment" menunjukkan hasil bahwa kegagalan dalam proses bounding attachment dipengaruhi oleh reaksi emosi maupun pengalaman dari orang tua. Masalah lain yang dapat berpengaruh, misalnya masalah pada jumlah anak, keadaan ekonomi dan lain-lain, Respon yang diberikan orang tua perlihatkan pada bayi baru lahir, bisa positif dan juga negatif. Bounding attachment yang dilakukan sedini mungkin dapat mengurangi kejadian sibling rivalry.

Cara untuk melakukan bounding ada bermacam-macam antara lain:

a. Pemberian ASI Eksklusif

Dengan dilakukannya pemberian ASI secara eksklusif segera setelah lahir, secara langsung bayi akan mengalami kontak kulit dengan ibunya yang menjadikan ibu merasa bangga dan diperlukan, rasa yang dibutuhkan oleh semua manusia.

b. Rawat gabung

Rawat gabung merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan agar antara ibu dan bayi terjalin proses lekat (early infant mother bonding) akibat sentuhan badan antara ibu dan bayinya. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan psikologis bayi selanjutnya, karena kehangatan tubuh ibu merupakan stimulasi mental yang mutlak dibutuhkan oleh bayi. Bayi yang merasa aman dan terlindung, merupakan dasar terbentuknya rasa percaya diri dikemudian hari. Dengan memberikan ASI eksklusif, ibu merasakan kepuasan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya, dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Keadaan ini juga memperlancar produksi ASI, karena refleks let-down bersifat psikosomatis. Ibu akan merasa bangga karena dapat menyusui dan merawat bayinya sendiri dan bila ayah bayi berkunjung akan terasa adanya suatu kesatuan keluarga.

c. Kontak mata

Beberapa ibu berkata begitu bayinya bisa memandang mereka, mereka merasa lebih dekat dengan bayinya. Orang tua dan bayi akan menggunakan lebih banyak waktu untuk saling memandang. Seringkali dalam posisi bertatapan. Bayi baru lahir dapat diletakkan lebih dekat untuk dapat melihat pada orang tuanya.

d. Inisiasi Menyusu Dini

Setelah bayi lahir, dengan segera bayi ditempatkan diatas ibu. Ia akan merangkak dan mencari puting susu ibunya. Dengan demikian, bayi dapat melakukan reflek sucking dengan segera.

Penelitian yang dilakukan oleh Hutagaol (2014) dengan judul Pengaruh Inisiasi Menyusu Dini (IMD) terhadap Suhu dan Kehilangan Panas pada Bayi Baru Lahir menunjukkan hasil bahwa IMD berpengaruh terhadap peningkatan suhu aksila. Kehilangan panas kering lebih rendah pada kelompok IMD walau tidak bermakna secara statistic. Menurunkan kehilangan panas sangat berhubungan dengan upaya bertahan hidup pada bayi baru lahir. Selama periode kontak kulit ke kulit, suhu inti dan suhu kulit perut meningkat yang mengindikasikan keuntungan dalam pencegahan kehilangan panas.

J. Program Kunjungan Neonatus

Pada Kemenkes RI (2013) tentang standar pelayanan minimal KN dibagi menjadi 3, yaitu:

1. KN1 adalah kunjungan pada 0-2 hari. Asuhan yang diberikan yaitu pemberian vitamin K1 injeksi dan imunisasi hepatitis B₀ bila belum diberikan pada saat lahir, perawatan tali pusat, pencegahan hipotermi, pencegahan infeksi.

2. KN2 adalah kunjungan 2-7 hari. Asuhan yang diberikan yaitu konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat, periksa tanda bahaya infeksi, pencegahan hipotermi.
3. KN3 adalah kunjungan setelah 7-28 hari. Asuhan yang diberikan yaitu imunisasi bayi 1 bulan meliputi BCG dan Polio 1, memastikan tidak terdapat tanda-tanda infeksi, memastikan pemberian ASI eksklusif.

K. Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir

Semua bayi diperiksa segera setelah lahir untuk mengetahui apakah transisi dari kehidupan intrauterine ke ekstrauterine berjalan dengan lancar dan tidak ada kelainan. Pemeriksaan medis komprehensif dilakukan dalam 24 jam pertama kehidupan. Pemeriksaan rutin pada bayi baru lahir harus dilakukan, tujuannya untuk mendeteksi kelainan atau anomali kongenital yang muncul pada setiap kelahiran dalam 10-20 per 1000 kelahiran, pengelolaan lebih lanjut dari setiap kelainan yang terdeteksi pada saat antenatal, mempertimbangkan masalah potensial terkait riwayat kehamilan ibu dan kelainan yang diturunkan, dan memberikan promosi kesehatan, terutama pencegahan terhadap *sudden infant death syndrome* (SIDS) (Lissauer, 2013).

Tujuan utama perawatan bayi segera sesudah lahir adalah untuk membersihkan jalan napas, memotong dan merawat tali pusat, mempertahankan suhu tubuh bayi, identifikasi, dan pencegahan infeksi (Saifuddin, 2008).

Asuhan bayi baru lahir meliputi:

1. Pencegahan Infeksi (PI)
2. Penilaian awal untuk memutuskan resusitasi pada bayi
Untuk menilai apakah bayi mengalami asfiksia atau tidak dilakukan penilaian sepintas setelah seluruh tubuh bayi lahir dengan 3 pertanyaan :
 - a) Apakah kehamilan cukup bulan?
 - b) Apakah bayi menangis atau bernapas/tidak megap-megap?
 - c) Apakah tonus otot bayi baik/bayi bergerak aktif?

Jika ada jawaban “tidak” kemungkinan bayi mengalami asfiksia sehingga harus segera dilakukan resusitasi. Penghisapan lendir pada jalan napas bayi tidak dilakukan secara rutin (Kementerian Kesehatan RI, 2013).

3. Pemotongan dan perawatan tali pusat

Setelah penilaian sepintas dan tidak ada tanda asfiksia pada bayi, dilakukan manajemen bayi baru lahir normal dengan mengeringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan *vernix*, kemudian bayi diletakkan di atas dada atau perut ibu. Setelah pemberian oksitosin pada ibu, lakukan pemotongan tali pusat dengan cara menjepit tali pusat dengan klem pada sekitar 3 cm dari

pusat (umbilikus) bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal (ibu) dan melakukan penjepitan kedua pada 2 cm distal dari klem pertama. Kemudian melakukan pemotongan dan pengikatan tali pusat dengan cara mengangkat tali pusat yang telah di jepit kemudian melakukan pemotongan tali pusat (melindungi perut bayi) di antara 2 klem tersebut. Selanjutnya mengikat tali pusat dengan umbilical cord.

Perawatan tali pusat dilakukan dengan tidak membungkus tali pusat atau mengoleskan cairan/bahan apa pun pada tali pusat (Kementerian Kesehatan RI, 2013). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Asiyah dkk (2017) tentang perawatan tali pusat terbuka sebagai upaya mempercepat pelepasan tali pusat menunjukkan bahwa waktu lepasnya tali pusat yang dirawat terbuka rata-rata 5-7 hari sebanyak 15 bayi (75 %), lebih cepat dibandingkan dengan perawatan tali pusat tertutup.

4. Inisiasi Menyusui Dini

Bayi harus mendapatkan kontak kulit dengan kulit ibunya segera setelah lahir selama paling sedikit satu jam. Prinsip menyusui/ pemberian ASI adalah dimulai sedini mungkin dan secara eksklusif (JNPK-KR, 2008).

Setelah bayi lahir dan tali pusat dipotong, segera letakkan bayi tengkurap di dada ibu, kulit bayi kontak dengan kulit ibu untuk melaksanakan proses IMD selama 1 jam. Biarkan bayi mencari, menemukan puting, dan mulai menyusui. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan IMD dalam waktu 60-90 menit, menyusui pertama biasanya berlangsung pada menit ke- 45-60 dan berlangsung selama 10-20 menit dan bayi cukup menyusui dari satu payudara. Jika bayi belum menemukan puting ibu dalam waktu 1 jam, posisikan bayi lebih dekat dengan puting ibu dan biarkan kontak kulit dengan kulit selama 30-60 menit berikutnya. Jika bayi masih belum melakukan IMD dalam waktu 2 jam, lanjutkan asuhan perawatan neonatal esensial lainnya kemudian dikembalikan lagi kepada ibu untuk belajar menyusui (Kementerian Kesehatan RI, 2013).

5. Pencegahan kehilangan panas (menjaga kehangatan)

Bayi baru lahir dapat kehilangan panas tubuhnya melalui cara evaporasi, konduksi, konveksi dan radiasi. Mencegah terjadinya kehilangan panas dapat dilakukan dengan cara mengeringkan tubuh bayi tanpa membersihkan verniks, meletakkan bayi agar terjadi kontak kulit ibu ke kulit bayi, menyelimuti bayi dan ibu dan pakaikan topi di kepala bayi, tidak segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir (BBL dimandikan 6 jam setelah lahir), dan menempatkan bayi di lingkungan yang hangat (JNPK-KR, 2008).

Berdasarkan penelitian Ekawati (2015) tentang Pengaruh IMD terhadap Perubahan Suhu Tubuh pada Bayi Baru Lahir didapatkan hasil bahwa hampir

seluruhnya atau 76,2% bayi baru lahir sebelum dilakukan IMD mengalami penurunan suhu tubuh dan sesudah dilakukan IMD sebagian kecil atau 23,8% bayi baru lahir yang mengalami suhu tubuh rendah artinya adanya pengaruh pelaksanaan IMD terhadap perubahan suhu tubuh bayi baru lahir. Sehingga IMD dapat untuk mencegah terjadinya Hipotermi pada bayi baru lahir.

6. Memberikan salep mata tetrasiklin 1% pada kedua mata

Salep mata untuk mencegah infeksi mata diberikan setelah 1 jam kontak kulit dan bayi selesai menyusui. Pencegahan infeksi tersebut mengandung antibiotika tetrasiklin 1%. Salep antibiotika harus tepat diberikan pada waktu satu jam setelah kelahiran. Upaya pencegahan infeksi mata tidak efektif bila diberikan lebih dari satu jam setelah kelahiran (JNPK-KR, 2008).

7. Memberikan suntikan vitamin K₁ 1 mg intramuskular, di paha kiri anterolateral setelah Inisiasi Menyusu Dini

Semua bayi baru lahir harus diberikan vitamin K₁(*Phytomenadione*)injeksi 1 mg IM di paha kiri, setelah 1 jam kontak kulit ke kulit dan bayi selesai menyusui untuk mencegah perdarahan BBL akibat defisiensi vitamin K yang dapat dialami oleh sebagian BBL (Kemenkes Kesehatan RI, 2013).

Pemberian vitamin K sebagai profilaksis melawan *hemorrhagic disease of the newborn* dapat diberikan dalam suntikan yang memberikan pencegahan lebih terpercaya, atau secara oral yang membutuhkan beberapa dosis untuk mengatasi absorpsi yang bervariasi dan proteksi yang kurang pasti pada bayi (Lissauer, 2013).

8. Memberikan imunisasi Hb 0

Imunisasi hepatitis B 0,5 ml diberikan secara intramuskular, di paha kanan anterolateral, diberikan kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K₁ atau batas maksimal 7 hari (JNPK-KR, 2008).

Menurut Varney (2007) apabila HB0 belum diberikan pada saat lahir, maka diberikan sebelum bayi berumur 7 hari.

9. Pemeriksaan Bayi baru Lahir

Pemeriksaan BBL untuk mengetahui sedini mungkin adanya kelainan pada bayi. Bayi yang lahir di fasilitas kesehatan dianjurkan tetap berada di fasilitas tersebut selama 24 jam karena risiko terbesar kematian BBL, saat kunjungan tindak lanjut (KN) yaitu 1 kali pada umur 1-3 hari, 1 kali pada umur 4-7 hari dan 1 kali pada umur 8-28 hari (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

10. Defeksi dan miksi

Keluarnya segera mekonium dan air kencing segera setelah lahir merupakan tanda bahwa saluran pencernaan dan saluran kencing baik, sebaliknya bila tidak keluar dengan segera kemungkinan terdapat kelainan bawaan (Wirakusumah, dkk, 2016).

11. Kehilangan Berat Badan

Selama 3 atau 4 hari pertama bayi boleh dikatakan hampir tidak memasukkan cairan produksi ASI belum lancar), sedangkan bayi mengeluarkan feses, urine dan keringat cukup banyak, tidak heran apabila berat badannya turun sampai diimbangi oleh air susu yang cukup.

Kehilangan berat ini $\pm 7\%$ dari berat badan dan tidak boleh melebihi 10% dari berat badannya. Bayi bertambah ± 25 gr sehari untuk bulan-bulan pertama dan pada bulan ke-5 dua kali berat lahir (Wirakusumah, dkk, 2016).

12. Memulai pemberian ASI

Pemberian ASI di mulai dalam waktu satu jam setelah bayi lahir. Jika mungkin, anjurkan ibu untuk memeluk dan mencoba untuk menyusukan bayinya segera setelah tali pusat di klem dan di potong. Dan tidak membuang ASI yang pertama kali keluar (kolostrum). Hal ini dikarenakan pada studi pendahuluan yang dilakukan Prasetya, Wijayanti and Atik (2015) tentang “Tingkat pengetahuan Ibu Hamil Tentang Pemberian ASI Kolostrum Pada Bayi Baru Lahir Di Rumah Bersalin Sayang Ibu Undaan Kudus” ditemukan 3 dari 16 orang ibu tidak mengetahui tentang kolostrum. Berikan ASI saja selama 6 bulan pertama kehidupan. Berikan ASI pada bayi sesuai dengan kebutuhannya baik siang atau malam (8x/ lebih dalam 24 jam atau selama bayi menginginkannya)

Keuntungan pemberian ASI :

- a. Merangsang produksi ASI
- b. Memperkuat reflek menghisap bayi
- c. Memberikan kekebalan pasif segera kepada bayi melalui kolostrum
- d. Memastikan keterikatan antara ibu dan bayinya

Posisi tubuh bayi dalam menyusui :

- a. Posisi kepala dan tubuh bayi lurus
- b. Tubuh bayi menghadap dada ibu
- c. Perut bayi menempel pada payudara ibu

Posisi mulut bayi yang benar :

- a. Dagunya bayi menempel payudara ibu
- b. Mulut bayi terbuka lebar
- c. Bibi bawah membuka lebar
- d. Areola tampak lebih banyak di bagian atas mulut bayi

Bayi menghisap ASI dengan efektif apabila :

- a. Bayi menghisap dengan perlahan dan dalam, serta kadang – kadang berhenti
- b. Gerakan leher bayi ketika menelan ASI dapat terlihat jelas.

Imunisasi :

- a. Pada daerah resiko tinggi infeksi tuberculosis, imunisasi BCG dapat di berikan pada uji segera setelah lahir.
- b. Pemberian dosis pertama tetesan vaksin polio di anjurkan pada bayi segera setelah lahir / pada umur 2 minggu.
- c. Imunisasi hepatitis B merupakan program nasional pada daerah resiko tinggi. Pemberian imunisasi hepatitis B di anjurkan pada bayi segera setelah lahir.

13. Melakukan rawat gabung dengan ibu

Rawat gabung ialah penempatan bayi dalam satu kamar dengan ibunya, biasanya disamping ibu atau tempat tidur ibunya. Rawat gabung juga merupakan lanjutan dari ambulasi dini supaya ibu mampu merawat anaknya karena hubungan kasih sayang antara ibu dan anak akan terjalin. Dan ibu akan lebih pandai memelihara anaknya setelah keluar dari rumah sakit (Wirakusumah, dkk, 2016).

Menurut penelitian Lestari tentang Hubungan Rawat Gabung dengan Mobilisasi Dini didapatkan hasil bahwa ada hubungan antara rawat gabung dengan mobilisasi dini pada ibu nifas hari pertama (χ^2 hitung > χ^2 tabel dengan derajat kepercayaan 95%, berarti H_0 ditolak dan H_1 . Sehingga keinginan ibu untuk segera merawat bayinya sendiri, serta keinginan ibu untuk segera menyusui bayinya menyebabkan meningkatnya motivasi ibu untuk melakukan mobilisasi dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrinah. 2010. *Asuhan Kebidanan Masa Kehamilan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Asiyah, dkk. 2017. *Perawatan Tali Pusat Terbuka Sebagai Upaya Mempercepat Pelepasan Tali Pusat*. Indonesia Jurnal Kebidanan Vol. 1 No. 1 (2017). Diakses tanggal 21 Januari 2018. Didapatkan dari fileCUsersuserDownloads112-592-2-PB.pdf
- Dewi, Vivian Nanny Lia. 2010. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Jakarta: Salemba Medika.
- Ekawati. 2015. *Pengaruh Inisiasi Menyusu Dini (IMD) terhadap Perubahan Suhu Tubuh pada Bayi Baru Lahir di Klinik Bersalin Mitra Husada Desa PangeanKecamatanMaduran Kabupaten Lamongan*. STIKES Muhammadiyah Lamongan Vol.07 No.01.
- JNPK-KR. 2008. *Asuhan Persalinan Normal & Inisiasi Menyusu Dini*. Jakarta: JNPK - KR.
- Hutagaol, Darwin, Yantri. 2014. *Pengaruh Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Terhadap Suhu dan Kehilangan Panas Pada Bayi Baru Lahir*. Jurnal Kesehatan Andalas, Vol 3 No 3.
- Kementrian Kesehatan RI. 2013. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementrian Kesehatan RI. 2013. *Rencana Aksi Percepatan Penurunan AKI di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kuswinarno, Syahadatina, Rahmayanti. 2013. *Inisiasi Menyusui Dini dengan Refleksi Menyusu Pada Bayi Baru Lahir*. Vol. 01, No. 01.
- Ladewig, Patricia, Marcia dan Sally. 2006. *Buku Saku Asuhan Ibu & Bayi Baru Lahir*. Jakarta: EGC.
- Lestari. 2010. *Hubungan Rawat Gabung dengan Mobilisasi Dini pada Ibu Nifas Hari Pertama di BPS Endang Desa Banaran Kecamatan Kandangan kabupaten Kediri*. Jurnal AKP Vol 1 No 2.
- Manuaba, I.B.G, I.A. Chandranita Manuaba, I.B.G. Fajar Manuaba. 2007. *Pengantar Kuliah Obstetri*. Jakarta: EGC.
- Mochtar, Rustam. 2012. *Sinopsis: Obstetri Fisiologi, Onstetri Patologi*. Jakarta: EGC.
- Prawiroharjo, Sarwono. 2009. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- _____. 2011. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

- Rukiyah, A. Y., Lia Yulianti, Maemunah, & Susilawati, L. 2013. *Asuhan bayi baru lahir*. Jakarta:TIM
- Saminem. 2008. *Asuhan Kebidanan Kehamilan Normal*. Jakarta: EGC.
- Saifuddin. 2008. *Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka
- Sulistyawati, Ari. 2009. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Kehamilan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Tauriska dan Umamah. 2015. *Hubungan Antara Isapan Bayi dengan Prpduksi ASI Pada Ibu Menyusui di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya*. Jurnal Ilmiah Kesehatan, Vol 8, No. 1
- Wirakusumah, dkk. 2016. *Obstetri Fisiologi: Ilmu Kesehatan Reproduksi, Ed.2*. Jakarta: EGC
- Wong, Donna L, etal. 2009. *Buku Ajar Keperawatan Pediatrik*. Jakarta: EGC.
- Yuliastanti, Triana. 2013. *Keberhasilan Bounding Attachment*. Jurnal Kesehatan, Vol V, No. 02.

BAB 9

KONSEP DASAR PENCEGAHAN INFEKSI

PADA NEONATUS

Ani Triana, SST., Bd., M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. PENDAHULUAN

Salah satu penanda keberhasilan program KIA adalah Angka Kematian Bayi (AKB). Kesuksesan dari pembangunan kesehatan keluarga dengan indikasi semakin menurunnya AKB. Bersumber dari informasi Bank Dunia, bahwa Indonesia di tahun 2020 untuk angka kematian bayi baru lahir (0-28 hari) sejumlah 11,7 jiwa/1.000 kelahiran hidup, yang berarti untuk setiap 1000 bayi yang lahir, 11-12 bayi meninggal antara usia 0 sampai 28 hari. Data tersebut di bawah dari angka tahun sebelumnya yang berjumlah 12,2 jiwa/1.000 kelahiran hidup sehingga dalam 1 dekade terakhir ini terlihat tren menurun pada grafik. Hal tersebut juga selalu berada di bawah data dunia pada tahun 2020 yaitu sebesar 17 jiwa/1.000 kelahiran hidup. Tapi AKB di Indonesia masih dikategorikan tinggi jika di bandingkan negara yang berada di wilayah Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nation/ASEAN*) dan masuk pada peringkat 5 terbesar (Kusnandar, 2022).

Dari data kematian 1 dari 30 anak meninggal berada di usia sebelum 5 tahun pada rentang 1 dari 10 berasal dari beberapa wilayah kabupaten yang ada di Indonesia Timur, karena wilayah tersebut masih sangat tertinggal di Indonesia. Bayi baru lahir memiliki kondisi yang sangat rentan sehingga menyebabkan sekitar 50% dari seluruh kematian di tahun pertama kehidupannya, dengan 75% kematian terdapat di tahun pertama kehidupan (UNICEF Indonesia, 2022).

Menurut WHO dalam Ashriady (2018), bahwa pada negara berkembang hampir 98% dari 5 juta terjadi kematian bayi baru lahir. Lebih 2/3 kematian ini terjadi di masa neonatal dini dan 42% kematian bayi baru lahir diakibatkan oleh infeksi seperti: sepsis, tetanus neonatorum, meningitis, pneumonia, dan diare. Menurut Dinkes Jateng (2009) dalam Sofiana dan Agustina (2011) bahwa di Indonesia penyakit yang menyebabkan kematian bayi baru lahir tertinggi pada usia 0-28 hari, terhitung sebesar 42,9% (termasuk tetanus, sepsis, infeksi tali pusat, pneumonia dan diare), dengan sisanya adalah masalah gizi.

Kecacatan dan kematian pada bayi merupakan dampak apabila infeksi tidak dapat diobati (Adrian, 2020). Oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan infeksi pada neonatus sebagai upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi.

B. DEFINISI INFEKSI DAN PENCEGAHAN INFEKSI PADA NEONATUS

Infeksi pada neonatus adalah tahap awal dari sepsis yang biasanya tidak belum ditemukan tanda peradangan (Fitriana, 2019). Infeksi merupakan adanya infeksi bakteri umum generalisata yang biasanya terjadi pada bulan pertama kehidupan dan menyebar ke seluruh tubuh bayi. Ini terjadi pada periode bayi (neonatus), persalinan dan setelah kelahiran. Infeksi juga didefinisikan sebagai respon dari tubuh karena adanya penyebaran mikroorganisme melalui darah dan jaringan tubuh lainnya. Keadaan ini terjadi <1% pada bayi baru lahir, namun menyebabkan 30% kematian bayi baru lahir (Sembiring, 2019).

Pencegahan infeksi adalah upaya penanganan awal yang harus dilakukan ketika bayi baru lahir, hal ini dikarenakan mereka sangat rentan mengalami infeksi. Pada saat penatalaksanaan dilakukan, perlu dipastikan bahwa penolong melakukan tindakan pencegahan infeksi tersebut (Handayani et al., 2018).

C. PRINSIP UMUM PENCEGAHAN INFEKSI

Menurut Yuniarti (2019) bahwa dengan melakukan praktik pencegahan infeksi di bawah ini maka akan memberi perlindungan pada bayi, ibu dan penolong/tenaga kesehatan dari infeksi. Hal ini akan menjadi upaya pencegahan dari penyebaran infeksi:

1. Melakukan perawatan rutin pada neonatus
2. Pertimbangkan siapa saja (termasuk bayi dan staf) yang dapat menularkan infeksi
3. Cuci tangan atau gunakan *hand sanitizer*
4. Gunakan alat pelindung diri (APD)
5. Lakukan teknik aseptik
6. Ambil alat-alat medis yang tajam secara berhati-hati dan bersihkan, lakukan sterilisasi atau disinfeksi alat sesuai kebutuhan.
7. Membersihkan bagian rawatan khusus bayi baru lahir secara rutin dan jaga kebersihan dengan membuang sampah.
8. Cegah infeksi nosokomial dengan memisahkan bayi yang mengalami infeksi.

D. Praktik Pencegahan Infeksi

Menurut *World Health Organization* (WHO) (2005) bahwa praktik pencegahan infeksi dapat dilakukan melalui tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan perawatan rutin neonatus
 - a. Pada waktu > 6 jam pertama kelahiran atau ketika suhu bayi sudah stabil, perlu menggunakan kain katun atau handuk yang telah direndam air hangat untuk mengusap darah dan cairan tubuh lainnya pada bayi, setelah itu

keringkan bayi. Menunda untuk memandikan bayi yang BBLR atau prematur hingga minimal dihari kedua kehidupannya.

- b. Membersihkan area anus dan genitalia bayi setiap akan mengganti pakaian bayi, atau ketika bayi buang air kecil/besar atau jika keadaan yang dibutuhkan, dengan menggunakan kapas basah yang telah direndam air hangat, lalu keringkan dengan hati-hati dan cermat.
 - c. Memastikan bahwa ibu diajarkan dan mengetahui teknik menyusui yang benar untuk mencegah infeksi pada payudara dan lecet pada puting.
2. Orang sebagai sumber infeksi
- a. Meletakkan bagian perawatan khusus bayi baru lahir lokasi yang tidak padat dengan akses terbatas.
 - b. Perlu disediakan ruangan khusus bayi baru lahir, apabila ada.
 - c. Pastikan bahwa tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan bayi baru lahir sudah mendapatkan proteksi dengan imunisasi berikut:
 - 1) Rubela;
 - 2) Campak;
 - 3) Virus hepatitis B;
 - 4) Parotitis;
 - 5) Influenza (setiap tahun).
 - d. Tidak diizinkan orang yang menderita infeksi kulit atau lesi bersentuhan langsung dengan bayi.
 - e. Tidak diizinkan baik tenaga kesehatan atau pengunjung melewati bagian perawatan khusus bayi baru lahir apabila terindikasi menderita infeksi akut (mis., virus pernapasan).
 - f. Membatasi jumlah tenaga kesehatan yang berbeda dalam penanganan bayi.
3. Mencuci tangan
- a. Melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir (jika tangan terlihat bersih, gunakan hand sanitizer):
 - 1) Sebelum dan sesudah melakukan perawatan bayi dan sebelum tindakan apa pun;
 - 2) Sesudah melepas handscoon;
 - 3) Sesudah memegang alat yang kotor atau lainnya.
 - b. Menginformasikan ibu dan keluarga untuk selalu mencuci tangan mereka sebelum dan sesudah memegang bayi.
 - c. Untuk melakukan cuci tangan:
 - 1) Membasahi keseluruhan tangan sampai pergelangan tangan;
 - 2) Mencuci tangan selama 10-15 detik dengan sabun biasa dan air yang mengalir atau air yang dituang dengan dialirkan;

- 3) Membiarkan tangan selalu kering dengan udara atau mengeringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi.
- d. Pembersih tangan beralkohol/hand sanitizer, membuatnya dari menambahkan 2 ml gliserin (atau emolien lain) ke 100 ml etil atau iso propil alkohol 60%-90%, lebih efektif untuk membersihkan tangan daripada mencuci tangan kecuali apabila tangan terlihat kotor. Untuk melakukan cuci tangan dengan penggunaan pembersih tangan beralkohol:
 - 1) Oleskan hand sanitizer secukupnya sampai keseluruhan permukaan dan jari-jari tangan;
 - 2) Gosokan larutan tersebut ke tangan sampai kering.
4. Menggunakan alat pelindung diri (APD)
 - a. Tidak perlu menggunakan gaun atau masker ketika melakukan perawatan rutin pada bayi.
 - b. Menggunakan baju pelindung (mis., apron, gaun) ketika akan memegang atau membersihkan darah atau cairan tubuh.
 - c. Memakai sepatu atau sandal tertutup, apabila memungkinkan menggunakan sepatu boots. Dilarang tanpa alas kaki atau alas kaki yang terbuka.
 - d. Saat handscoon digunakan untuk tindakan, gunakan sepasang handscoon yang berbeda untuk setiap bayi yang bertujuan mencegah kontaminasi silang, dan segera buang handscoon sesudah kontak. Penggunaan handscoon yang berbeda untuk keadaan yang berbeda:
 - 1) Gunakan handscoon steril atau yang di DTT untuk kontak dengan kulit yang luka atau untuk tindakan invasif (mis., pungsi lumbal, kateterisasi vena umbilikalis);
 - 2) Gunakan handscoon periksa yang bersih untuk kontak dengan membran mukosa atau cairan tubuh (mis., mengambil sampel darah, merawat umbilikus);
 - 3) Gunakan handscoon karet tebal atau handscoon lateks serbaguna saat menyentuh benda yang terkontaminasi, membersihkan alat, dan membuang sampah.
 - e. handscoon sekali pakai lebih diminati, namun apabila terbatas, handscoon dapat dipakai kembali apabila:
 - 1) Dilakukan dekontaminasi melalui perendaman dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit;
 - 2) Dilakukan pencucian dan pembilasan;
 - 3) Dilakukan sterilisasi menggunakan autoklaf (menghilangkan seluruh mikroorganisme) atau di DTT dengan pengukusan atau perebusan (menghilangkan seluruh mikroorganisme kecuali beberapa endospora bakteri).

- f. Apabila handscoon bedah sekali pakai digunakan kembali, dilarang memprosesnya > 3 kali karena dapat terjadi robekan yang tidak terlihat.

Catatan: Jangan menggunakan handscoon yang robek, terkelupas, atau berlubang.

5. Teknik aseptik

Teknik aseptik bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi hingga tingkat aman jumlah mikroorganisme pada kulit, jaringan, dan benda mati.

- a. Menggosok tangan selama 3-5 menit dengan memakai sabun antiseptik, lalu bilas pada air yang mengalir atau air yang dituang dengan dialirkan.
- b. Membiarkan tangan kering di udara atau mengeringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi.
- c. Menggunakan handscoon periksa yang bersih.
- d. Menyiapkan kulit untuk tindakan dengan mencucinya menggunakan swab atau bola kapas yang direndam dalam larutan antiseptik dengan gerakan spiral ke arah luar. Ulangi sebanyak 2 kali lagi, dengan menggunakan swab baru atau bola kapas setiap kalinya, dan biarkan tetap kering. Jika digunakan polividon iodine, biarkan kering setelah mengoleskannya atau tunggu minimal 2 menit sebelum prosedur selanjutnya.
- e. Lepaskan handscoon periksa dan pakai handscoon yang di DTT atau steril.
- f. Menggunakan instrumen dan peralatan yang di DTT atau steril.
- g. Apabila terdapat pertanyaan tentang apakah suatu benda steril atau tidak, kita harus beranggapan bahwa barang tersebut sudah terkontaminasi.

6. Vial yang penggunaannya berkali-kali

- a. Pakai jarum dan spuit baru dan steril setiap kali pengambilan obat dari vial atau tempat yang dipakai berulang kali.
- b. Vial yang dipakai berulang kali disimpan sesuai dengan petunjuk (mis., simpan di tempat sejuk dan gelap atau lemari pendingin).
- c. Melakukan pencatatan pada vial berdasarkan tanggal dan waktu vial dibuka, dan gunakan hingga 1 bulan atau sesuai dengan tanggal kedaluwarsa.
- d. Jangan membiarkan ampul kaca terbuka dan digunakan untuk banyak bayi, karena akan menyebabkan obat tersebut tidak stabil, dan menutup ampul tidak akan mencegah kontaminasi.
- e. Membuang larutan pengencer (mis., air steril atau salin normal) sesudah 24 jam.
- f. Mengganti infus set beserta kantong cairan IV setiap 24 jam walaupun kantong masih ada cairan IV (karena bisa menjadi sumber utama infeksi).

7. Larutan antiseptik dan desinfektan

Walaupun terkadang istilah antiseptik dan desinfektan sering tertukar penggunaannya, larutan tersebut mempunyai fungsi dan tujuan yang tidak sama.

Larutan antiseptik dipakai untuk kulit dan biasanya tidak seefektif desinfektan. Larutan desinfektan dipakai untuk tindakan dekontaminasi atau desinfeksi tingkat tinggi pada instrumen dan peralatan. Untuk mencegah terjadinya kontaminasi larutan antiseptik dan desinfektan:

- a. Pakai hanya menggunakan air mendidih untuk pengenceran, apabila pengenceran dibutuhkan (didihkan air selama 20 menit untuk tindakan desinfeksi tingkat tinggi);
 - b. Berhati-hatilah supaya tidak terjadi kontaminasi mulut wadah saat penuangan larutan pada wadah yang lebih kecil;
 - c. Mengosongkan dan mencuci wadah menggunakan sabun dan air lalu biarkan tetap kering di udara minimal 1 kali seminggu;
 - d. Menuangkan larutan antiseptik pada bola kapas atau kasa. Dilarang mencelupkan ke dalam larutan;
 - e. Menyimpan larutan pada daerah yang sejuk dan gelap.
8. Instrumen dan peralatan untuk penanganan instrumen tajam dengan aman
- a. Sesudah digunakan, segera dekontaminasi spuit dan jarum dengan pembilasan memakai larutan desinfektan sebanyak 3 kali.
 - b. Buang segera benda tajam dengan meletakkannya pada wadah antibocor. Tidak menutup kembali, membengkokkan/mematahkan jarum/melepasnya dari spuit. Apabila jarum harus ditutup kembali, pakai tindakan 1 tangan:
 - 1) Meletakkan tutup pada alas yang keras dan datar;
 - 2) Memegang spuit dengan 1 tangan dan pakai jarum untuk “mengangkat” tutup;
 - 3) Saat tutup menutupi jarum keseluruhannya, pegangkan dasar jarum dan pakai tangan lain untuk memfiksasi tutup.
 - c. Membuang wadah.
9. Memproses instrumen
- a. Memerlukan panduan khusus memproses instrumen dengan tujuan memastikan bahwa instrumen bersih dan di DTT atau steril.
 - b. Memastikan bahwa instrumen yang menembus kulit (mis., jarum, kateter) dilakukan sterilisasi atau DTT secara memadai sebelum dipakai dan diproses secara benar sesudah dipakai
 - c. Menggunakan larutan desinfektan untuk membersihkan alat-alat yang tidak kontak dengan aliran darah (mis., stetoskop, inkubator) antara setiap kali digunakan, dan paling penting ketika digunakan pada bayi yang berbeda.
10. Penanganan rumah tangga dan pembuangan sampah
- Pembersihan yang teratur dan menyeluruh akan mengurangi mikroorganisme pada permukaan dan membantu mencegah infeksi. Perlu

diingat bahwa penanganan rumah tangga dan pembuangan sampah sebagai berikut:

- a. Setiap bagian perawatan khusus bayi baru lahir harus terdapat jadwal penanganan rumah tangga:
 - 1) Mempelkan jadwal pembersihan di lokasi yang mudah dilihat;
 - 2) Memberikan rincian tindakan yang harus dilakukan dan seberapa sering;
 - 3) Mengajarkan petugas mengenai pembersihan, dan pemberian tanggung jawab.
 - b. Mengikuti panduan umum untuk penanganan rumah tangga:
 - 1) Membersihkan dari atas ke bawah (mis., dinding dan penutup jendela) sehingga kotoran yang jatuh selama proses membersihkan dapat dihilangkan;
 - 2) Selalu menggunakan handscoon karet yang tebal atau handscoon lateks serbaguna;
 - 3) Memastikan bahwa tempat baru yang isinya larutan desinfektan selalu ada setiap saat;
 - 4) Lakukan segera tindakan untuk membersihkan percikan darah atau cairan tubuh dengan penggunaan larutan desinfektan;
 - 5) Membungkus atau menutupi dengan alas bersih dan simpan dalam kereta atau lemari yang tertutup untuk mencegah kontaminasi debu;
 - 6) Setiap sesudah dipakai, bersihkan tempat tidur, meja, dan troli tindakan dengan menggunakan larutan desinfektan.
 - c. Memisahkan sampah yang mengalami kontaminasi (mis., benda yang terkontaminasi oleh darah, pus, dan cairan tubuh lain) dari sampah yang tidak terkontaminasi.
 - d. Gunakan tempat antitertusuk untuk benda tajam yang terkontaminasi dan hancurkan tempat tersebut apabila sudah 2/3 penuh:
 - 1) Menambahkan sedikit minyak tanah ke wadah, dan bakar sampah pada yang terbuka sesuai arah angin dan jauh dari tempat layanan;
 - 2) Apabila tidak mungkin membakar pada tempat pembuangan, lakukan penguburan pada suatu tempat yang jaraknya minimal 50 meter jauh dari sumber air.
11. Metode tambahan untuk pencegahan infeksi
- a. Perlunya disediakan ruangan pribadi khusus untuk bayi baru lahir, apabila memungkinkan.
 - b. Cegah terlalu padat dan terlalu sedikit petugas.
 - c. Dilarang meletakkan 2 bayi atau lebih pada pelbet atau inkubator yang sama atau di bawah pemanas radian atau bagian fototerapi yang sama.

E. TINDAKAN UMUM PENCEGAHAN INFEKSI

Menurut Handayani, dkk (2018) bahwa tindakan umum pencegahan pada bayi baru lahir, adalah sebagai berikut:

1. Mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan penanganan dengan kontak langsung pada bayi
2. Memakai handscoon yang bersih saat penanganan bayi yang belum dimandikan
3. Memastikan seluruh peralatan sudah dilakukan tindakan DTT/steril. Apabila memakai bola karet untuk menghisap lendir, pakai yang bersih dan baru
4. Memastikan bahwa barang-barang lain yang akan kontak langsung dengan bayi harus dalam kondisi yang bersih.

F. JENIS-JENIS PENCEGAHAN INFEKSI PADA NEONATUS

Menurut Handayani, dkk (2018) bahwa jenis-jenis pencegahan infeksi pada neonatus terdiri dari:

1. Pencegahan infeksi pada tali pusat

Upaya ini dilakukan dengan cara merawat talipusat yang berarti menjaga agar luka tersebut tetap bersih, tidak terkena air kencing, kotoran bayi atau tanah. Pemakaian popok bayi diletakkan di sebelah bawah talipusat. Apabila talipusat kotor, cuci luka talipusat dengan air bersih yang mengalir dan sabun, segera dikeringkan dengan kain kasa kering dan dibungkus dengan kasa tipis yang steril dan kering. Dilarang membubuhkan atau mengoles ramuan, abu dapur dan sebagainya pada luka talipusat, karena akan menyebabkan infeksi dan tetanus yang dapat berakhir dengan kematian neonatal. Tanda-tanda infeksi talipusat yang harus diwaspadai, antara lain kulit sekitar talipusat berwarna kemerahan, ada pus/nanah dan berbau busuk. Mengawasi dan segera melaporkan kedokter jika pada tali pusat ditemukan perdarahan, pembengkakan, keluar cairan, tampak merah atau berbau busuk (Yuniarti, 2019).

Menurut Damanik dan Linda (2019) bahwa ada hubungan yang signifikan antara perawatan tali pusat dengan kejadian infeksi pada bayi baru lahir di RSUD dr. Pirngadi Medan tahun 2018 dengan pvalue $0,017 < 0,05$. Menurut Kasiati, dkk (Kasiati et al., 2013) bahwa ternyata ASI merupakan bahan yang mudah tersedia dan efektif untuk perawatan tali pusat yang bisa diterapkan di negara berkembang untuk mengurangi infeksi tali pusat dan mempercepat waktu pelepasan. Beberapa penelitian membuktikan bahwa perawatan tali pusat dengan topikal ASI adalah metode yang aman, efektif dan efisien maka perlu dikembangkan lebih lanjut.

2. Pencegahan infeksi pada kulit

Iritasi kulit, ruam popok serta permasalahan kulit bayi lainnya yang disebabkan karena produk kosmetik, menyebabkan luka terbuka pada kulit bayi.

Luka ini pada akhirnya dapat menimbulkan komplikasi yang lebih buruk karena bakteri, virus atau parasit dapat dengan mudah menginfeksi, seperti impetigo. Mengingat kulit neonatus sangat tipis dan sensitif. serta mengalami adaptasi progresif dari lingkungan ekstrasuterin sehingga memerlukan perawatan khusus selama periode neonatus. Diperlukan pelatihan tentang cara melakukan perawatan kulit bayi sehat dan mengenali produk-produk kosmetik bayi yang aman dan bermanfaat bagi bayi (Argentina et al., 2016).

Beberapa cara yang diketahui dapat mencegah terjadi infeksi pada kulit bayi baru lahir atau penyakit infeksi lain adalah meletakkan bayi di dada ibu agar terjadi kontak kulit langsung ibu dan bayi, sehingga menyebabkan terjadinya kolonisasi mikroorganisme ibu yang cenderung bersifat nonpatogen, serta adanya zat antibodi bayi yang sudah terbentuk dan terkandung dalam air susu ibu (Handayani et al., 2018).

3. Pencegahan infeksi pada mata bayi baru lahir

Belekan atau kotoran pada sudut mata sering dialami bayi baru lahir sejak hari-hari hingga minggu pertama usianya. Belekan yang terjadi bisa mengenai satu atau kedua mata sekaligus. Mata tampak lengket, diikuti warna belek yang kuning. Air mata sering tampak menetes dan kelopak mata tampak sembab namun tanpa diikuti oleh kemerahan pada bagian putih mata atau *konjunktiva* serta belekan seperti nanah. Keadaan ini disebabkan karena adanya sumbatan pada saluran atau duktus nasolakrimalis yang normalnya berfungsi mengalirkan air mata dari sudut bola mata ke hidung yang kemudian akan menguap seiring dengan udara pernapasan yang mengalir ke hidung. Jika terjadi sumbatan, maka air mata tidak dapat dialirkan ke hidung dan menggenang atau menumpuk pada mata, membuat mata tampak sembab, air mata menetes, atau kemudian mengering dan bercampur dengan sekret atau kotoran yang larut pada air mata dan membuat mata belekan. Untuk menghindari terjadinya infeksi mata yang ditandai dengan mata kemerahan dan nanah, maka pada bayi baru lahir pemberian salep atau tetes mata seperti eritromisin sangatlah penting (Farah, 2016).

Cara mencegah infeksi pada mata bayi baru lahir adalah merawat mata bayi baru lahir dengan mencuci tangan terlebih dahulu, membersihkan kedua mata bayi segera setelah lahir dengan kapas atau sapu tangan halus dan bersih yang telah dibersihkan dengan air hangat. Dalam waktu 1 jam setelah bayi lahir, berikan salep/obat tetes mata untuk mencegah oftalmia neonatorum (Tetrasiklin 1%, Eritromisin 0,5% atau Nitrasn, Argensi 1%), biarkan obat tetap pada mata bayi dan obat yang ada di sekitar mata jangan dibersihkan. Setelah selesai merawat mata bayi, cuci tangan kembali. Keterlambatan memberikan salep mata, misalnya bayi baru lahir diberi salep mata setelah lewat 1 jam setelah

lahir, merupakan sebab tersering kegagalan upaya pencegahan infeksi pada mata bayi baru lahir (Yuniarti, 2019).

Hal ini juga sejalan menurut (Permenkes RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial, 2014) bahwa salep atau tetes mata untuk pencegahan infeksi mata diberikan segera setelah proses IMD dan bayi selesai menyusui, sebaiknya 1 jam setelah lahir. Pencegahan infeksi mata dianjurkan menggunakan salep mata antibiotik tetrasiklin 1%. Cara pemberian salep mata antibiotik:

- a. Cuci tangan (gunakan sabun dan air bersih mengalir) kemudian keringkan
- b. Jelaskan kepada keluarga apa yang akan dilakukan dan tujuan pemberian obat tersebut.
- c. Tarik kelopak mata bagian bawah kearah bawah.
- d. Berikan salep mata dalam satu garis lurus mulai dari bagian mata yang paling dekat dengan hidung bayi menuju ke bagian luar mata atau tetes mata.
- e. Ujung tabung salep mata atau pipet tetes tidak boleh menyentuh mata bayi.
- f. Jangan menghapus salep dari mata bayi dan anjurkan keluarga untuk tidak menghapus obat-obat tersebut.

4. Imunisasi

Pada daerah risiko tinggi infeksi tuberkulosis, imunisasi BCG harus diberikan pada bayi segera setelah lahir. Pemberian dosis pertama tetesan polio dianjurkan pada bayi segera setelah lahir atau pada umur 2 minggu. Maksud pemberian imunisasi polio secara dini adalah untuk meningkatkan perlindungan awal. Imunisasi Hepatitis B sudah merupakan program nasional, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Pada daerah risiko tinggi, pemberian imunisasi Hepatitis B dianjurkan pada bayi segera setelah lahir (Handayani et al., 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, K. (2020). *Mengenal Sepsis Neonatorum, Infeksi Darah pada Bayi Baru Lahir*. Alodokter. <https://www.alodokter.com/mengenal-sepsis-neonatorum-infeksi-darah-pada-bayi-baru-lahir>
- Argentina, F., Yahya, Y. F., Melizah, A., Amalia, E., & Prasasty, G. D. (2016). Upaya Pencegahan Penyakit Kulit pada Bayi Melalui Penyuluhan Perawatan Kulit Sehat. *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*, 302–309.
- Ariyani, F. (2019). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang Imunisasi BCG Dengan Pemberian Imunisasi BCG Pada Bayi Usia 0-2 Bulan Di Puskesmas Pauh Padang. *Jurnal Kesehatan Mercusuar*, 2(1), 7. <https://doi.org/10.36984/jkm.v2i1.24>
- Ashriady, N. S. (2018). Perilaku Ibu Dalam Memandikan Bayi Baru Lahir Di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. *Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 91(5), 1689–1699. <https://forikes-ejournal.com/index.php/SF/article/download/9215/sf9215>
- Damanik, R., & Linda. (2019). Hubungan Perawatan Tali Pusat dengan Kejadian Infeksi pada Bayi Baru lahir di RSUD Dr. Pirngadi Medan 2019. *Jurnal Keperawatan Priority*, 2(2), 51. <https://doi.org/10.34012/jukep.v2i2.556>
- Farah, F. (2016). *Belekan pada Bayi Baru Lahir, Normalkah?* IDAI. <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/pengasuhan-anak/belekan-pada-bayi-baru-lahir-normalkah>
- Fitriana, F. (2019). *Faktor Risiko yang Mempengaruhi Terjadinya Infeksi Neonatal di Rumah Sakit Mitra Delima Malang*. Univeritas Brawijaya, Malang.
- Handayani, T. E., Setiyani, A., Sa'adab, N., & Magetan, prodi kebidanan. (2018). *Modul Ajar Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Balita*. Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- Kasiati, Santoso, B., Yunitasari, E., & Nursalam. (2013). Topikal Asi: Model Asuhan Keperawatan Tali Pusat Pada Bayi. *Jurnal Ners*, 8(1), 9–16. <https://www.e-journal.unair.ac.id/JNERS/article/view/3864>
- Permenkes RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial, Pub. L. No. 53 (2014).
- Kusnandar, V. B. (2022). *Angka Kematian Bayi Neonatal Indonesia Menunjukkan Tren Turun*. Data Boks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/21/angka-kematian-bayi-neonatal-indonesia-menunjukkan-tren-turun>
- Sembiring, J. B. (2019). *Buku ajar Neonatus, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah*. Deepublish. https://www.google.co.id/books/edition/Buku_ajar_Neonatus_Bayi_Balita_Anak_Pra/ZAyfDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

- Sofiana, I., & Agustina, E. E. (2011). Efektivitas Metode Kolostrum dan Metode Kasa Kering terhadap Waktu Pelepasan Tali Pusat di BPS Ny. Endang Purwaningsih dan BPS Ny. Istiqomah Kecamatan Rakit Kabupaten Banjar Negara. *Bidan Prada*, 2(2).
- UNICEF Indonesia. (2022). *Memberi peluang terbaik untuk bertahan hidup bagi anak-anak*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/kesehatan>
- World Health Organization (WHO). (2005). *Buku Saku "Manajemen Masalah Bayi Baru Lahir" Panduan untuk Dokter, Perawat & Bidan* (P. E. Karyuni & E. Meiliya (eds.)). EGC. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Yuniarti. (2019). *Fisiologi Holistik Neonatus, Bayi, Balita Dan Anak Pra Sekolah*. Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Palagkaraya.

BAB 10

RAWAT GABUNG (*ROOMING IN*)

Bd. Novita Br Ginting Munthe, SST., M.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 10

RAWAT GABUNG (*ROOMING IN*)

Novita Br Ginting Munthe

A. PENDAHULUAN

Tujuan dari pembangunan nasional salah satunya adalah membangun sebuah sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan energik, sehingga mampu melanjutkan pembangunan nasional menuju masyarakat sejahtera, adil, makmur dan aman sentosa. SDM berkualitas dan energik mulai dibentuk sejak masih dalam kandungan dan awal kelahiran. Sarana untuk membangun SDM tersebut salah satunya adalah melalui Air Susu Ibu (ASI) yang salah satunya adalah makanan yang sangat sempurna menjamin tumbuh kembang bayi yang optimal di enam bulan pertama dan akan mendukung tumbuh kembang di periode selanjutnya. Pemberian ASI dapat dimaksimalkan melalui rawat gabung antara ibu dan bayi (Harefa et al., 2019).

Rawat gabung merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan bonding attachment Ibu dan bayi. Selain itu, infeksi pada bayi baru lahir juga dapat diminimalisir melalui rawat gabung karena mengurangi risiko kontaminasi silang antara satu bayi dengan bayi lainnya (Jaafar et al., 2016).

B. DEFINISI RAWAT GABUNG (*ROOMING IN*)

Rawat gabung adalah Teknik rawatan bayi baru lahir (BBL) yang difasilitasi untuk tinggal bersama – sama dalam satu ruangan antara ibu dan bayinya untuk memudahkan ibu menjangkau dan memperhatikan kondisi bayinya (Jaafar et al., 2016).

C. TUJUAN RAWAT GABUNG (*ROOMING IN*)

Tujuan dari pelaksanaan rawat gabung (Lai et al., 2015), meliputi:

1. Supaya ASI atau kolostrum segera didapatkan oleh bayi.
2. Ibu dan suami mendapatkan kesempatan dan pengalaman bagaimana merawat bayi yang baik dan benar.
3. Stimulasi mental secara dini didalam proses tumbuh dan kembang bayi.

D. JENIS RAWAT GABUNG (*ROOMING IN*)

1. Rawat gabung penuh waktu (kontinu/penuh)
Merupakan suatu cara perawatan ibu dan bayinya yang disatukan dalam satu ruangan dalam waktu 24 jam atau secara terus menerus bayinya berada disamping ibunya.
2. Rawat gabung penggal waktu (tidak penuh/parsial/intermiten)

lah suatu cara merawat ibu dan bayi yang dilakukan dengan waktu tertentu dirawat secara terpisah, yaitu:

- a) *Rooming in* selama beberapa jam per hari, contohnya setelah dimandikan pag9i diantar ke ruangan ibu sampai sore hari dan malamnya bayi diantar ke ruangan atau kamar bayi
- b) Perawatan saat ibu hendak menyusui bayinya atau sewaktu – waktu ibu bermohon agar bayinya diantar ke dalam ruangnya.
- c) *Rooming in* intermiten sekarang ini tidak dipakai atau tidak dibenarkan lagi (Newman et al., n.d.).

E. INDIKASI DILAKUKAN *ROOMING IN*

Rooming in tidak semua ibu dan bayi dapat segera dilakukan. Kriteria atau syarat dari ibu dan bayinya yang dapat dirawat dalam satu tempat/ digabungkan adalah (Handelzalts et al., 2021)

1. Bayi yang lahir spontan, pada presentasi bokong ataupun kepala.
2. Bayi yang lahir dengan tindakan, Ketika kondisi bayi dipastikan sehat dengan refleks hisap yang baik, serta tidak ditemukan adanya tanda dan gejala dari infeksi atau penyakit lainnya.
3. Bayi dilahir melalui seksio caesaria (SC) dengan menggunakan anestesi umum, rawat gabung diizinkan jika kondisi ibu dalam keadaan penuh sadar. Ibu tetap menyusui bayinya walaupun ibu dalam kondisi terpasang infus.
4. Dalam waktu lima menit pertama, dimana bayi tidak gagal napas (asfiksia).
5. Usia dari kehamilan lebih atau sama dari 37 minggu.
6. Berat badan bayi saat lahir 2000-2500 gram atau lebih.
7. Tidak ditemukan adanya tanda dan gejala infeksi intrapartum.
8. Bayi dan ibu dalam kondisi sehat.

Sedangkan kondisi bayi yang membuat tidak diizinkan untuk dilakukan rawatan secara *rooming in*, meliputi:

1. Bayi lahir dengan prematur
2. Bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2000 gram
3. Bayi dengan infeksi pada aliran darah atau sepsis
4. Bayi dengan gangguan nafas
5. Bayi dengan kondisi cacat bawaan berat, seperti meningokel, anensefali, hidrosefalus, atresia ani, omfalokel,,
6. Palato/labio/kelainan kongenital gnatoschizis dan lainnya.
7. Ibu yang mengalami infeksi berat, seperti sepsis.

F. KONTRA INDIKASI *ROOMING IN*

Walaupun keberhasilan dari *rooming in* kategori berhasil dan memuaskan, namun masih ada pertimbangan yang menjadi pusat perhatian dalam pelaksanaan *rooming in*. ***Rooming in*** tidak diperbolehkan atau dianjurkan dalam kondisi – kondisi sebagai berikut:

1. Kondisi ibu
 - a) Ibu yang keadaan pernapasan dan jantungnya bermasalah, misalnya: ibu dengan sakit jantung fungsional pada derajat III, dianjurkan tidak menyusui.
 - b) Ibu sesudah eklamsia dan kesadarannya belum stabil.
 - c) Ibu dengan kondisi penyakit infeksi akut atau TBC.
 - d) Ibu yang menderita sakit hepatitis B, Infeksi HIV (sampai saat ini masih kontroversi)
 - e) Ibu dengan kanker dibagian payudara.
2. Kondisi bayi
 - a) Bayi kejang ataupun keadaan umum tidak baik/kesadaran menurun.
 - b) Bayi dengan kondisi sakit dibagian jantung atau paru.
 - c) Bayi cacat bawaan sehingga membuat bayi tidak bisa menyusu.
 - d) Bayi yang kondisinya butuh perawatan intensif/terapi khusus.

G. MANFAAT *ROOMING IN*

Dalam *rooming in*, Ibu dapat dibantu oleh suami dan keluarga untuk memberikan perawatan dan menyusui bayinya, sehingga posisi ibu dapat dikondisikan dengan baik dan nyaman. *Rooming in* juga berdampak positif karena dapat meningkatkan *bonding attachmet* atau kehangatan emosi antara bayi dengan ibu, bapak dan keluarga dan sebaliknya (Theo & Drake, n.d.).

Rooming in juga dapat meningkatkan produksi ASI dan memperlancar pemberian ASI dikarenakan bertambahnya hormon oksitoksin yang ada di dalam tubuh ibu yang sangat erat kaitannya dengan kondisi emosional ibu. Hormon oksitoksin akan semakin meningkat saat kondisi ibu bahagia dan nyaman saat mendekap/menggendong bayinya, maka ASI pun lebih cepat dan banyak keluar yang membuat bayi puas menyusu sampai kenyang. Bagi bayi, *rooming in* membuat bayi lebih cepat beradaptasi untuk tidur dan saat bangun bersama ibu. Selain itu, bila bayinya menangis dapat langsung didekap/dipeluk ibu sehingga bayi akan kembali tenang ditambah lagi langsung mendengar detak jantung ibu yang membuat kenyamanan (Wu et al., 2022a).

Hadirnya *rooming in* sangatlah bermanfaat bagi ibu karena bisa menurunkan morbiditas bayi, seperti ketika ibu optimis memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya yang berfungsi meningkatkan sistem imunitas tubuh bayi. *Rooming in* juga berperan besar menurunkan angka mortalitas ibu, karena melalui *rooming in* dapat

meminimalisir kejadian perdarahan post partum yaitu dengan bayi diberikan ASI yang eksklusif.

Berdasarkan sumber lainnya juga disebutkan bahwa manfaat *rooming in* sangat baik untuk bayi, ibu dan keluarga serta petugas kesehatan, yaitu sebagai berikut (Van Dellen et al., 2022):

1. Bagi ibu

Aspek psikologi

- Terjalannya suatu proses perlekatan antara bayi dan ibu (*early infant-mother bonding*) karena adanya kontak langsung atay sentuhan tubuh ibu dan bayi.
- Adanya peluang besar dan kesempatan ibu dan keluarga untuk belajar bagaimana cara merawat bayi dengan baik dan benar.
- Meningkatkan rasa percaya diri ibu untuk melakukan perawatan bagi bayinya. ASI dapat sesering mungkin diberikan oleh ibu kepada bayinya dan kapan saja bayi mau menyusu, sehingga timbul kepuasan ibu dalam memberikan nutrisi yang adekuat bagi bayinya. Ibu juga merasakan bahwa bayinya sangat membutuhkannya dan siapapun tidak dapat menggantikan posisi ibu yang pada akhirnya hal tersebutlah yang membuat produksi ASI akan semakin lancar.

Aspek fisik

- Proses involusi uteri berjalan dengan baik karena kontraksi uterus ibu berjalan dengan baik dengan menyusui secara eksklusif.
- Bayi dapat dirawat langsung oleh Ibunya, sehingga mobilisasi juga berjalan dengan baik.

2. Bagi bayi

Aspek psikologi

- Kontak langsung tubuh bayi dan ibu sangat berdampak untuk perkembangan psikologis bayi kedepannya, karena transformasi hangatnya tubuh ibu ke bayi merupakan rangsangan mental yang dibutuhkan bayi.
- Terbentuk rasa percaya diri anak ke depannya apabila sejak awal kelahiran mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dari ibu.

Aspek fisik

- Sesegera mungkin bayi akan memperoleh kolostrum/ASI jolong yang berguna untuk meningkatkan antibodi bayi.
- Bayi segera memperoleh nutrisi sesuai dengan usia pertumbuhannya
- Infeksi nosokomial dapat diminimalisir sekecil mungkin
- Berkurangnya bahaya aspirasi yang ditimbulkan karena pemberian susu melalui botol.

- Mengurangi timbulnya penyakit sariawan pada bayi
- Mengurangi terjadinya alergi terhadap susu formula buatan

3. Bagi keluarga

Aspek psikologi

- *Rooming in* menambahkan peluang bagi suami dan keluarga untuk mendukung dan memberikan semangat kepada ibu agar diberikan ASI eksklusif pada bayi.

Aspek ekonomi

- Lebih pendek masa rawatan ibu karena proses pemulihan ibu juga lebih cepat dan bayi lebih sehat sehingga biaya perawatannya lebih sedikit.

4. Bagi petugas

Aspek psikologi

- Petugas di dalam ruang perawatan merasa lebih aman, tenang, dan dapat melakukan pekerjaannya yang lain karena bayi bersama bayinya dan jarang mendengarkan tangisan bayi.

Aspek fisik

- Pekerjaan dari petugas kesehatan semakin berkurang dikarenakan sebagian besar tugasnya sudah diambil alih ibu dan petugas tidak perlu menyediakan susu formula ke dalam botol susu dan menghabiskan waktu memberikan susu tersebut kepada bayinya.

H. PELAKSANAAN *ROOMING IN*

Berbagai keadaan dan situasi dapat menimbulkan perbedaan dalam memberikan asuhan kepada bayi. Pelaksanaan *rooming in* prenatal di poliklinik sampai ke kamar bersalin lalu di ruangan rawat gabung. Persiapan ini dilakukan dan disiapkan agar ibu mulai beradaptasi, memahami, dan pada akhirnya terbiasa menerima dengan baik konsep rawat gabung (Miller et al., 1998).

1. Di Poliklinik Kebidanan:

- Ibu – ibu dibekali informasi melalui penyuluhan terkait: kebermanfaatan ASI dan konsep rawat gabung, *breast care*, nutrisi ibu hamil, perawatan bayi, dan lain sebagainya.
- Alangkah lebih baik jika disiapkan satu ruangan yang digunakan untuk memutar film tentang teknik perawatan payudara (*breast care*), cara memandikan bayi, merawat bagian tali pusat bayi, keluarga berencana, dan lainnya.
- Memberikan layanan konsultasi seputaran kesehatan ibu dan bayi.
- Membuat dokumentasi laporan bulanan tentang jumlah dari pengunjung, aktivitas-aktivitas, masalah yang ditemukan dan lainnya yang dianggap penting untuk diselesaikan.

2. Di Kamar Bersalin:

- Bayi yang dikategorikan memenuhi persyaratan *rooming in* diberikan perawatan bayi baru lahir seperti biasanya. Patokan yang dikatakan memenuhi bayi diperbolehkan rawat gabung dengan ibunya jika memenuhi kriteria berikut:
 - a) Apgar score >7
 - b) Berat badan bayi ≥ 2500 gram dan < 4000 gram
 - c) Masa kehamilan > 36 minggu dan < 42 minggu
 - d) Bayi lahir normal/spontan
 - e) Tidak ditemukan infeksi intrapartum
 - f) Ibu dalam kondisi sehat
 - g) Tidak terdapat komplikasi persalinan pada ibu atau bayi
 - h) Tidak terdapat kelainan kongenital berat
 - i) Setengah jam pertama sesudah lahir, Ibu segera menyusui bayinya untuk menstimulus keluarnya ASI.
 - j) Memberikan informasi melalui penyuluhan tentang ASI dan perawatan gabung, khusus bagi ibu yang belum mendapatnya di poliklinik.
 - k) Mengisi status pasien dengan lengkap dan benar.
 - l) Persiapan untuk ibu dan bayi supaya bersamaan ke ruangan.
 - m) Menginformasikan ke bagian petugas di ruangan Perinatologi bahwa akan ada bayi dirawat gabung serta mengurus segala administrasi.

3. Di Ruang Perawatan:

- Bayi diletakkan disamping tempat tidur ibunya dengan posisi bayi berada di dalam tempat tidurnya.
- Petugas kesehatan wajib mengecek kondisi umum bayi dan mampu mengenali keadaan yang abnormal, serta melaporkan kepada dokter jaga jika terjadi.
- Bayi menyusui jika bayi/ibu menginginkannya.
- Bayi tidak diizinkan untuk diberi susu dari botol. Bila terpaksa atau sesuai dengan indikasi medis maka bayi dapat diberikan susu formula menggunakan sendok/cangkir/sonde lambung/pipet.
- Ibu wajib dibantu untuk menyusui bayinya dengan benar dan baik, juga untuk melakukan *breast care*.
- Kondisi bayi setiap harinya dicatat di dalam status.
- Bila bayi sakit/perlu observasi lebih teliti, maka bayi dipindahkan ke ruang perawatan khusus bayi baru lahir.
- Bila ibu dan bayi sudah boleh pulang, sekali lagi diberi penerangan tentang cara-cara merawat bayi dan memberikan ASI serta perawatan payudara dan

makanan ibu menyusui. Kepada ibu diberikan brosur yang berhubungan dengan itu dan dipesan agar memeriksakan bayinya satu minggu kemudian.

- Status yang sudah lengkap, dikirim ke ruangan follow-up (Klinik Laktasi/Poliklinik).
- Di Ruang Poliklinik/Ruangan Rawat Jalan:
- Biasanya dilakukan di Poliklinik Kebidanan atau di Klinik Laktasi.
- Pemeriksaan di ruangan poliklinik meliputi pemeriksaan bayi dan keadaan ASI. Yang dikerjakan di ruangan ini ialah:
- Menimbang berat badan bayi.
- Melihat kondisi payudara ibu, apakah terdapat kelainan atau tidak mengganggu proses laktasi.
- Anamnesis mengenai nutrisi bayi serta keluhan yang timbul.
- Mengecek keadaan ASI.
- Memberi nasihat mengenai makanan bayi, cara menyusukan bayi, perawatan payudara, perawatan bayi dan makanan ibu menyusui.
- Memberikan peraturan makanan bayi.
- Pemeriksaan bayi oleh ahli anak.
- Pemberian imunisasi menurut aturannya.

I. PERSYARATAN *ROOMING IN* YANG IDEAL

Adapun persyaratan *rooming in* yang ideal adalah sebagai berikut (Wu et al., 2022):

1. Bayi
 - Tempat tidur bayi dibuat tersendiri dan mudah untuk dijangkau atau dilihat oleh ibunya
 - Rak bayi bagi yang membutuhkan
 - Tempat tidur bayi berukuran 40 x 60 cm
2. Ibu
 - Tempat tidur Ibu berukuran 90 x 200 cm
 - Tingginya 90 cm
3. Ruang
 - Ukuran dari ruangan untuk satu tempat tidur adalah 1,5 x 3 m
 - Ruangan dekat dengan ruangan petugas kesehatan (khusus yang masih membutuhkan perawatan)
4. Sarana
 - Lemari pakaian
 - Perlengkapan dan tempat mandi bayi
 - Tempat cuci tangan ibu
 - Kamar mandi untuk setiap kamar ibu

- Tersedia sarana penghubung: Sarana tempat *breast care*, nifas dan bayi, dan bayi diberikan makanan menggunakan bahasa sederhana.
 - Perlengkapan untuk perawatan bayi
5. Petugas
- Rasio antara petugas dan pasien adalah 1 : 6
 - Memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait *rooming in*

J. MODEL PENGATURAN RUANGAN RAWAT GABUNG

Ruang untuk *rooming in* harus diatur dengan model berikut ini (Handelzalts et al., 2021)

- Satu kamar disiapkan untuk satu ibu dan bayinya.
- Dalam 1 kamar terdiri dari empat sampai dengan lima orang ibu bersama bayi beradadi kamar yang lainnya bersebelahan, sehingga ibu dapat mengambil bayi tanpa harus meninggalkan tempat tidur ibu.
- Disiapkan satu ruangan kaca kedap suara dimana beberapa ibu dalam satu kamar dan bayi di tempat yang terpisah.
- Model tempat tidur yang sama dimana ibu dan bayi bisa tidur bersama
- Bayi berada di tempat tidur yang posisinya disamping ibu

K. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN

Keuntungan *rooming in* dan kerugiannya adalah (Van Dellen et al., 2022):

1. Keuntungan

- Penggunaan ASI semaksimal mungkin dapat digalakkan
- Kontak emosional antara ibu dan bayi terjalin lebih erat dan dini
- Keadaan bayi yang tidak normal atau aneh dapat segera dilaporkan oleh ibu kepada petugas kesehatan
- Ibu dapat mempelajari tentang perawatan bayi
- Meminimalisir ketergantungan ibu kepada bidan
- Menumbuhkan rasa percaya diri yang sangat besar dalam hal merawat bayi
- Mengurangi terjadinya infeksi nosokomial/silang
- Mengurangi pekerjaan petugas kesehatan terutama pengawasan pada bayi

2. Kerugian

- Istirahat ibu menjadi berkurang
- Pemberian makanan bayi kemungkinan dapat terjadi karena dipengaruhi oleh keluarga atau orang lain.
- Infeksi bisa terjadi pada bayi melalui pengunjung
- Dalam pelaksanaan kemungkinan terdapat hambatan dibagian fasilitas atau teknis

DAFTAR PUSTAKA

- Handelzalts, J. E., Levy, S., Molmen-Lichter, M., Muzik, M., Krissi, H., Wiznitzer, A., & Peled, Y. (2021). Associations of rooming-in with maternal postpartum bonding: the impact of mothers' pre-delivery intentions. *Midwifery*, 95, 102942. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.102942>
- Harefa, J. K., Anwar, A. D., Novi, T., Wijayanegara, H., Septiani, L., Garna, H., Kebidanan, M. T., Dharma, S., Bandung, H., Akbid, /, Keluarga-Nias, H., Sadikin, H., Rsia, B. /, Bandung, L., Rsia, /, Bunda, G., Bandung, K., Kedoteran, F., Islam, U., ... Husada, D. (2019). Influence Breast Care Massage Methods To Increase Production Oketani mother's milk (ASI) On Mother Post Partum In Puskesmas Gunungsitoli-Nias. *Journal Of Nursing And Midwifery*, 2(1).
- Jaafar, S. H., Ho, J. J., & Lee, K. S. (2016). Rooming-in for new mother and infant versus separate care for increasing the duration of breastfeeding. In *Cochrane Database of Systematic Reviews* (Vol. 2016, Issue 8). John Wiley and Sons Ltd. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD006641.pub3>
- Lai, Y.-L., Hung, C.-H., Stocker, J., Chan, T.-F., & Liu, Y. (2015). Postpartum fatigue, baby-care activities, and maternal-infant attachment of vaginal and cesarean births following rooming-in. *Applied Nursing Research*, 28(2), 116–120.
- Miller, N. O., Friedman, S. B., & Coupey, S. M. (1998). Adolescent preferences for rooming during hospitalization. *Journal of Adolescent Health*, 23(2), 89–93. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1054-139X\(98\)00015-9](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1054-139X(98)00015-9)
- Newman, A., Fcfp, C., Davies, G. A., Fabog, F., Dow, K., Holmes, B., Rsw, M., Macdonald, J., Mcknight, S., & Newton, L. (n.d.). *Rooming-in care for infants of opioid-dependent mothers Implementation and evaluation at a tertiary care hospital*.
- Theo, L. O., & Drake, E. (n.d.). Rooming-In: Creating a Better Experience. *The Journal of Perinatal Education*, 2, 79–84. <https://doi.org/10.1891/1058-1243.26.2.79>
- van Dellen, S. A., Wisse, B., & Mobach, M. P. (2022). Effects of lactation room quality on working mothers' feelings and thoughts related to breastfeeding and work: a randomized controlled trial and a field experiment. *International Breastfeeding Journal*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s13006-022-00499-0>
- Wu, H. L., Lu, D. F., & Tsay, P. K. (2022a). Rooming-In and Breastfeeding Duration in First-Time Mothers in a Modern Postpartum Care Center. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(18). <https://doi.org/10.3390/ijerph191811790>

BAB 11

ADAPTASI BAYI BARU LAHIR

TERHADAP KEHIDUPAN DILUAR UTERUS

Novita Ayu Indraswati, S.ST., M.Tr.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

ADAPTASI BAYI BARU LAHIR TERHADAP KEHIDUPAN DILUAR UTERUS*Novita Ayu Indraswati, S.ST., M.Tr.Keb*

A. PENDAHULUAN

Bayi baru lahir dengan berat lahir antara 2500 dan 4000 gram, yang telah mencapai usia kehamilan penuh, dan tidak memiliki kelainan bawaan utama dianggap "normal" (cacat bawaan).

Tubuh dan pikiran bayi yang baru lahir mengalami serangkaian penyesuaian psikologis segera setelah lahir. Semua penyesuaian radikal ini berarti bahwa bayi yang baru lahir akan membutuhkan pengamatan yang cermat karena dokter mencari cara terbaik untuk memudahkannya memasuki dunia di luar rahim. Merawat bayi baru lahir dapat meningkatkan peluang mereka untuk menyesuaikan diri dengan baik.

Selama proses adaptasi bayi baru lahir, bayi melakukan peralihan dari lingkungan perlindungan rahim ke dunia luar untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar rahim sangat penting bagi peluang bayi baru lahir untuk bertahan hidup. Perubahan fisiologis dibuat, seperti dalam sirkulasi kardiopulmoner, untuk mengganti hilangnya fungsi plasenta dan menjaga agar tetap stabil. Awal hubungan orang tua dengan anak mereka dimulai saat lahir, dan begitu ibu dan bayi sama-sama sehat, memiliki waktu sendiri untuk menjalin ikatan sangat penting bagi semua orang yang terlibat.

B. DEFINISI

Bayi baru lahir dengan usia kehamilan antara 37 dan 42 minggu dan berat antara 2.500 dan 4.000 gram dianggap sehat. Bayi baru lahir adalah organisme yang rentan dan masih tumbuh yang harus pulih dari efek traumatis kelahiran dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar rahim.

Bayi yang baru lahir disebut "bayi baru lahir", dan mereka membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Perkembangan neonatal dan pergeseran fungsional yang dihasilkan dipengaruhi oleh tiga proses: pematangan, adaptasi, dan toleransi. Sistem pernapasan, peredaran darah, dan penghasil glukosa bayi mengalami perubahan yang paling dramatis dan cepat.

Siklus hidup meliputi periode prenatal dan beberapa jam pertama kehidupan di luar rahim. Saat bayi lahir, ketergantungan fisik mereka pada ibunya berakhir. Disebut "masa transisi" karena rumitnya proses perubahan itu. Sebagai aturan, bidan harus berusaha untuk memahami banyak aspek dari perubahan yang cepat ini.

C. TAHAPAN BAYI BARU LAHIR

Pengkajian setelah kelahiran, terjadi dalam 3 tahap:

- ❖ Tahap 1 Penilaian fisik dan ibu-bayi interaksi bayi-ibu menggunakan sistem penilaian Apgar segera dalam menit pertama kehidupan.
- ❖ Tahap kedua juga dikenal sebagai fase transisi reaktif. Kaji dalam 24 jam pertama setelah perubahan perilaku
- ❖ tahap III Fase periodik, sesudah 24 jam pertama setiap tubuh dinilai setelah pemeriksaan.

D. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN FUNGSI KEHIDUPAN INTRAUTERIN KE KEHIDUPAN EKSTRAUTERIN

1. Faktor kematangan Masa kehamilan bayi baru lahir berkaitan erat dengan persiapan janin dari rahim ke luar rahim
2. Faktor adaptif Adaptasi janin dari intrauterin ke ekstrauterin
3. Faktor toleransi Kemampuan bayi untuk mentolerir dan menghadapi bahaya yang sebenarnya.

E. PERUBAHAN – PERUBAHAN FISILOGIS PADA BAYI BARU LAHIR

1. Perubahan – Perubahan Fisiologis Pada Bayi Baru Lahir :

Berikut ini adalah ciri-ciri bayi baru lahir:

- ❖ Dalam 30 detik pertama setelah lahir, bayi mulai bernapas dan menangis dengan kecepatan 40-60 kali per menit.
- ❖ Jantung berdetak dengan kecepatan 180 per menit, turun ke tingkat istirahat 120-140.
- ❖ Warna kulit merah, dengan atau tanpa vernix. Karena tebalnya lemak subkutan, tubuh tidak mampu mengatur suhunya
- ❖ Rambut lanugo dan kulit kepala sangat sehat.
- ❖ Kebebasan bergerak (otot) Keterlibatan aktif menekuk anggota badan.
- ❖ memiliki panjang tubuh 45-53 cm.
- ❖ BB 2500 – 4000 gram
- ❖ Lingkar kepala ukuran standar memiliki keliling 34 sentimeter.
- ❖ Fungsi berkemih normal, dengan bayi mampu berkemih 20-30 ml dalam 24 jam pertama.
- ❖ Kotoran mekonium dikeluarkan dalam 48 jam pertama. Labia mayora telah berpindah ke labia minora, dan testis telah turun ke dalam skrotum, melengkapi alat kelamin.

- ***Sistem Pernafasan***

Konstruksi paru-paru. Pertumbuhan di faring memunculkan paru-paru, dan paru-paru itu pada gilirannya memunculkan bronkus, jaringan saluran udara yang bercabang ke berbagai arah. Meskipun janin menunjukkan tanda-tanda gerakan pernapasan pada trimester kedua dan ketiga, prosesnya tidak berakhir sampai usia 8 tahun, di mana jumlah bronkiolus dan alveoli telah meningkat dan berkembang sempurna. Perkembangan paru-paru prematur, termasuk alveoli yang kurang berkembang, jaringan kapiler paru yang lemah, dan surfaktan yang tidak mencukupi, sangat mengurangi kemungkinan kelangsungan hidup neonatal dalam 24 minggu pertama kehamilan.

- ***Sistem Sirkulasi Darah***

Transformasi yang menarik terjadi pada sistem kardiovaskular bayi baru lahir. Baik duktus arteriosus dan duktus venosus serta foramen ovale tertutup. Ligamen terdiri dari arteri umbilikal, vena, dan arteri hepatika.⁸

Ketika bayi baru lahir mengambil napas pertama mereka, paru-paru mereka mengembang, menurunkan resistensi pembuluh darah paru dan membiarkan darah mengalir lebih mudah dan menurunkan tekanan di arteri paru-paru mereka. Rantai reaksi ini adalah mekanisme utama penurunan tekanan di atrium kanan. Sianosis ringan dapat terjadi pada bayi yang menangis sementara mengembalikan aliran darah melalui foramen ovale selama beberapa hari pertama kehidupan.

Saat lahir, detak jantung bayi biasanya sekitar 140 detak per menit, meskipun bisa berkisar antara 120 hingga 140 detak per menit. Siklus tidur dan bangun bayi memiliki frekuensi yang berbeda. Denyut jantung rata-rata bayi baru lahir pada usia satu minggu adalah 128 detak per menit, dengan peningkatan menjadi 163 detak per menit setelah bayi bangun.

- ***Sistem Pencernaan***

Bayi yang lahir cukup bulan dapat makan, mencerna, memetabolisme, dan menyerap protein dan karbohidrat sederhana serta mengemulsi lemak. Meconium bayi baru lahir adalah bentuk limbah gastrointestinal. Kehadiran meconium di usus pertama kali terdeteksi pada usia kehamilan 16 minggu. Sekitar dua hingga tiga hari setelah lahir, meconium dikeluarkan sepenuhnya. Biasanya, meconium pertama dikeluarkan dalam 24 jam pertama kehidupan bayi baru lahir. Bayi dengan sistem pencernaan yang berfungsi penuh memiliki feses yang berubah warna dari kuning pucat menjadi kuning kecoklatan saat diberi makanan padat. Ini selain meconium yang dikeluarkan, merupakan bukti anus yang sehat.

Jika Anda menunggu 4 atau 5 hari, feses Anda akan menguning. Bayi yang diberi ASI eksklusif memiliki feses yang tidak berbau, lembut, berwarna kuning cerah. Sementara bayi yang diberi susu formula pucat dan memiliki bau yang samar, bayi yang disusui memiliki warna kulit yang lebih gelap dan bau yang lebih kuat.

- ***Sistem Pengaturan Suhu Tubuh***

Karena bayi baru lahir memiliki pengaturan suhu tubuh yang tidak efisien dan lemah, sangat penting untuk menjaga bayi tetap hangat dan menghindari segala kondisi yang dapat menyebabkan hipotermia. Konveksi, evaporasi, konduksi, dan radiasi merupakan jalur potensial panas untuk keluar dari kulit bayi. Jika ruang bersalin bersuhu antara 21 dan 24 derajat Celcius, bayi dikeringkan, lalu dibungkus dengan hangat, hal ini tidak akan terjadi. Karena tidak bereaksi terhadap dingin dan kemampuan untuk meningkatkan produksi panas, bayi baru lahir tidak memiliki alasan untuk mengkhawatirkan cuaca.

Bayi baru lahir yang terlalu dingin untuk merasa nyaman akan bekerja secara aktif untuk tetap hangat dengan meregangkan dan meningkatkan pernapasan dan tangisan. Semua upaya harus dilakukan untuk menjaga bayi baru lahir tetap hangat untuk mencegah hipotermia, yang dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran kalori, hipoglikemia, dan, pada akhirnya, infeksi karena serangkaian efek samping termasuk hipoksia, hiperbilirubinemia, dan sistem kekebalan tubuh yang terganggu. Suhu rata-rata bayi baru lahir adalah antara 36,5 dan 37,5°C.

- ***Sistem Ginjal***

Kehamilan disertai dengan buang air kecil janin dalam cairan ketuban. Ginjal bayi baru lahir belum sepenuhnya berkembang, tetapi masih dapat menyaring darah dan membuang kotoran. Tidak mungkin untuk menyaring urin sepenuhnya karena kapasitas filtrasi glomerulus masih cukup rendah. Sehingga jumlah besar cairan yang dibutuhkan untuk mengekstrak padatan seperti urea dan natrium klorida akan terganggu.

Bayi harus membuat kekosongan pertama mereka di hari pertama kehidupan. Urin output meningkat dari sekitar 20 sampai 30 ml per hari pada akhir minggu pertama.

- ***Sistem Reproduksi***

Estrogen ibu digunakan untuk merangsang pertumbuhan payudara, dan terkadang disertai dengan keluarnya cairan pada hari keempat atau kelima. Karena akan hilang dengan sendirinya, tidak perlu mengobatinya. Pseudomenstruasi berkembang ketika labia mayor terbentuk di atas labia

minor pada bayi perempuan. Testis laki-laki terletak di skrotum pada saat ia mencapai usia kehamilan 36 minggu.

- **Sistem Syaraf**

Kerja sama antara sistem saraf dan sistem muskuloskeletal terlihat jelas pada bayi baru lahir. Contoh refleks tersebut adalah:

- a. Reflek Morro

Refleks di mana bayi merentangkan tangan dan jarinya, seolah-olah sedang memeluk seseorang, lalu dengan cepat menariknya kembali. Jika dia berbaring telentang, Anda dapat memicu refleks dengan mengetuk permukaannya. Bayi harus merentangkan tangannya secara metodis dan kemudian menariknya kembali. Dengan membentuk huruf C dengan ibu jari dan telunjuk, jari-jari akan meregang, dan tangan akan dilipat dengan gerakan memeluk sebelum kembali ke posisi istirahat. Tindakan serupa dapat dilakukan dengan kaki. Biasanya terlihat saat lahir, refleks Morro memudar antara usia 3 dan 4 bulan.

- b. Reflek Rooting

Ketika bayi dirangsang di pipi atau di sekitar mulut, refleks alami bayi adalah memutar kepalanya seolah mencari puting. Saat bayi disentuh di pipi atau sudut mulutnya, refleks rooting muncul, menyebabkan bayi berbalik dan, menanggapi sensasi itu, membuka mulutnya dan mulai mengisap. Pada saat bayi berusia 7 bulan, refleks ini biasanya memudar.

- c. Reflek Sucking

Refleks ini terjadi bersamaan dengan rooting reflex, yang memungkinkan puting tersedot dan susu tertelan.

- d. Reflek Batuk dan Bersin

Refleks pelindung ini muncul saat jalan napas bayi terancam.

- e. Reflek Graps

Saat ibu jari bayi diletakkan di atas telapak tangannya, terjadi penutupan tangan secara refleksif. Saat bagian bawah kaki tergores di dekat jari kaki, jari kaki juga akan menekuk sebagai respons. Bayi akan menggenggam jari-jari dengan erat jika jari-jari kaki diletakkan di atas telapak tangan. Sampai usia sekitar tiga atau empat bulan, bayi akan memegang apa saja yang ada di telapak tangannya. Refleks ini, ditandai dengan pembengkokan jari kaki ke dalam, paling menonjol pada bayi baru lahir dan bertahan hingga sekitar usia satu tahun, ketika mulai memudar.

- f. Reflek Walking dan Stapping

Karena refleks ini, saat bayi berdiri, kakinya akan bergerak ke depan dengan sendirinya, meski bayi belum bisa berjalan. Karena tidak semua bayi kooperatif, belajar untuk memicu refleks ini terkadang menjadi

tantangan. Refleks ini dapat diamati secara real time. Kecenderungan untuk menginjak biasanya menghilang pada saat bayi berusia 4 bulan.

g. Reflek Tonic Neck

Bayi berumur satu hari mungkin menunjukkan refleks yang melibatkan mengangkat leher dan memutar ke kanan atau ke kiri; setelah refleks ini diamati, dapat diamati selama tiga sampai empat bulan lagi.

h. Reflek Babinsky

Merangsang bagian bawah kaki menyebabkan gerakan ke atas dari jari-jari lainnya sebagai refleks. Setelah usia satu tahun, anak biasanya tidak lagi menunjukkan refleks ini.

i. Reflek Galant/ Membengkokkan Badan

Tulang belakang bayi melengkung ke satu sisi akibat pukulan punggung saat tengkurap. Jika punggung bayi digaruk sekitar 5 cm dari tulang belakang dengan gerakan ke bawah, bayi akan bereaksi dengan membungkuk ke sisi garukan. Usia dua hingga tiga bulan adalah saat refleks ini mulai memudar.

j. Reflek Bauer/ Melangkah

Refleks ini diamati pada bayi cukup bulan dengan menekan telapak kaki. Bayi akan bereaksi dengan gerakan merangkak pura-pura. Sekitar usia enam minggu, refleks ini menghilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Vivian Nanny Lia. 2010. *Asuhan Neonatus Bayi dan Balita*. Jakarta: Selemba Medika
- Green, Carol J. 2012. *Rencana Asuhan Keperawatan Maternal & Bayi Baru Lahir*. Jakarta:EGC
- Mochtar, Rustam. 2018. *Sinopsis : Obstetri Fisiologis, Obsetri patologi*. Jakarta. 2018
- JNPK-KR.2018. Pelatihan Klinik Asuhan Persalinan normal. JNPK-KR Dapartemen Kesehatan RI: Jakarta
- Kemenkes RI. 2020. *Buku Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta: Kemenkes dan JICA
- Kemenkes RI. 2013. Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu Edisi Kedua. Jakarta: Direktorat Bina Kesehatan Ibu.
- Patricia, ramona. 2013. *Buku Saku Asuhan Ibu dan Bayi baru lahir*. Edisi 5 : Jakarta. EGC
- Sudarti, Endang khairunisa. 2010. *Asuhan kebidanan Neonatus, Bayi dan anak balita*. Yogyakarta:Nuha Medika
- Varney H, Jan MK, Carolyn LG. 2009. Buku Ajar Asuhan Kebidanan. Edisi 5. Vol 3. Penerbit Buku Kedokteran. EGC:Jakarta
- Wahyuni, sari. 2011. *Asuhan Neonatus, bayi dan balita*. Jakarta:EGC

SINOPSIS

Asuhan kebidanan kasus fisiologis pada bayi, balita, dan anak pra sekolah merupakan bentuk kegiatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada bayi, balita, dan anak pra sekolah sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Peran bidan dalam memberikan asuhan dititikberatkan pada pemberian pendidikan kesehatan pada ibu dan keluarga untuk melakukan perawatan secara mandiri bertujuan meningkatkan ikatan batin antara ibu dan anak, sehingga dapat meningkatkan tumbuh kembangnya.

Buku asuhan kebidanan (askeb) ini disajikan dengan sangat menarik dan mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang sering dihadapi oleh mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran dalam kasus fisiologis pada bayi, balita, dan anak pra sekolah. Pada buku ini terdapat materi yang disusun penulis dari berbagai sumber dan kebijakan bertujuan untuk memudahkan dalam memahami pemberian pelayanan kesehatan kepada bayi, balita, dan anak pra sekolah khususnya pada kasus fisiologis. Buku askeb ini terdiri dari 11 bab yang disajikan dengan uraian setiap bab yaitu:

BAB 1: Deteksi Dini Pertumbuhan Dan Perkembangan Neonatus, Bayi, Balita Dan Anak Pra Sekolah

BAB 2: Gizi Pada Bayi Serta Balita

BAB 3: Buku KIA

BAB 4: Baby Spa

BAB 5: Dokumentasi Asuhan Kebidanan Pada Bayi Balita Dan Anak Pra Sekolah

BAB 6: Pemeriksaan Fisik Pada Bayi, Balita Dan Anak Pra Sekolah

BAB 7: Perawatan Bayi Di Rumah

BAB 8: Asuhan Langsung Pada Bayi Baru Lahir

BAB 9: Konsep Dasar Pencegahan Infeksi Pada Neonatus

BAB 10: Rawat Gabung (*Rooming In*)

BAB 11: Adaptasi Bayi Baru Lahir Terhadap Kehidupan Diluar Uterus

Semoga buku askeb ini memiliki manfaat yang besar bagi seluruh pembaca khususnya mahasiswi kebidanan dalam pencapaian pembelajaran terkait asuhan kebidanan kasus fisiologis pada bayi, balita, dan anak pra sekolah.

Asuhan kebidanan kasus fisiologis pada bayi, balita, dan anak pra sekolah merupakan bentuk kegiatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada bayi, balita, dan anak pra sekolah sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Peran bidan dalam memberikan asuhan dititikberatkan pada pemberian pendidikan kesehatan pada ibu dan keluarga untuk melakukan perawatan secara mandiri

bertujuan meningkatkan ikatan batin antara ibu dan anak, sehingga dapat meningkatkan tumbuh kembangnya.

Buku asuhan kebidanan (askeb) ini disajikan dengan sangat menarik dan mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang sering dihadapi oleh mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran dalam kasus fisiologis pada bayi, balita, dan anak pra sekolah. Pada buku ini terdapat materi yang disusun penulis dari berbagai sumber dan kebijakan bertujuan untuk memudahkan dalam memahami

pemberian pelayanan kesehatan kepada bayi, balita, dan anak pra sekolah khususnya pada kasus fisiologis. Buku askeb ini terdiri dari 11 bab yang disajikan dengan uraian setiap bab yaitu:

BAB 1: Deteksi Dini Pertumbuhan Dan Perkembangan Neonatus, Bayi, Balita Dan Anak Pra Sekolah

BAB 2: Gizi Pada Bayi Serta Balita

BAB 3: Buku KIA

BAB 4: Baby Spa

BAB 5: Dokumentasi Asuhan Kebidanan Pada Bayi Balita Dan Anak Pra Sekolah

BAB 6: Pemeriksaan Fisik Pada Bayi, Balita Dan Anak Pra Sekolah

BAB 7: Perawatan Bayi Di Rumah

BAB 8: Asuhan Langsung Pada Bayi Baru Lahir

BAB 9: Konsep Dasar Pencegahan Infeksi Pada Neonatus

BAB 10: Rawat Gabung (Rooming In)

BAB 11: Adaptasi Bayi Baru Lahir Terhadap Kehidupan Diluar Uterus
Semoga buku askeb ini memiliki manfaat yang besar bagi seluruh pembaca khususnya mahasiswi kebidanan dalam pencapaian pembelajaran terkait asuhan kebidanan kasus fisiologis pada bayi, balita, dan anak pra sekolah.

ISBN 978-623-88659-3-2



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

Anggota IKAPI
No. 624/DKI/2022

Penerbit :

PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919